FÉVRIER 2007

RNAO Registered Nurses' Association of Ontario
L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario

PROGRAMME DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SOINS INFIRMIERS

## Programme de lignes directrices pour la pratique exemplaire des soins infirmiers

# Développement et maintien du leadership infirmier

Ontario

# Mot de bienvenue de Doris Grinspun, Directrice générale Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario

**C'est avec grand plaisir** que l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) distribue ces lignes directrices (LD) pour la pratique exemplaire en leadership. C'est la première de six lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les lieux de travail sains (LDPELTS) développées jusqu'à maintenant par la communauté des infirmières. L'objectif de ces lignes directrices est d'offrir la meilleure information possible afin d'appuyer la création de lieux de travail sains et prospères.

Les LDPE dans les lieux de travail sains, lorsqu'elles sont appliquées, appuieront la qualité des services que les infirmières offrent dans leur travail quotidien. L'AIIAO est enchantée d'être en mesure de vous offrir cette ressource clé.

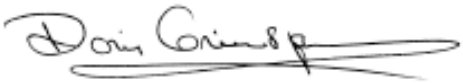
Nous remercions infiniment les nombreux établissements et les innombrables personnes qui permettent à l'AIIAO de concrétiser sa vision des lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les lieux de travail sains (LDPELTS); le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, qui a reconnu l'expertise de l'AIIAO pour mener à bien ce projet et contribuera un financement important; Donna Tucker, directrice du projet de 2003 à 2005, et à Irmajean Bajnok, directrice du Centre for Professional Nursing Excellence de l'AIIAO et directrice actuelle du projet, pour leur savoir et leur travail ayant permis de faire progresser l'élaboration des LPDELTS; ainsi que tous les chefs de LDPELTS et, tout particulièrement pour la présente LDPE, Heather Laschinger pour avoir partagé leur gestion exemplaire, leur dévouement et, surtout, leur expertise rigoureuse : nous n'y serions pas parvenus sans vous!

La communauté des infirmières, par son engagement et sa passion pour l'excellence en soins infirmiers, partage ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la création, à l'évaluation et à la révision de chaque ligne directrice. Un tel partenariat est voué à produire d'excellents résultats et à créer une culture des pratiques professionnelles basées sur des données probantes. Ensemble, nous bâtissons des communautés d'apprentissage, impatients que nous sommes de bâtir des réseaux et de partager notre expertise. La synergie qui en résultera se fera sentir dans le mouvement LDPE et les lieux de travail.

La création de lieux de travail sains est une responsabilité à la fois individuelle et collective. La mise en place réussie de ces LDPELTS nécessite un effort conjugué de la part des infirmières administratrices, du personnel et des infirmières en pratique avancée, des infirmières qui participent à l'établissement de politiques, à l'éducation et à la recherche et d'autres collègues d'autres disciplines à l'échelle de l'organisation. Nous vous demandons de partager ce document avec les membres de l'équipe. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les infirmières et les autres travailleurs de la santé contribuent à la création de lieux de travail sains. Cela est essentiel pour assurer des soins de qualité aux patients. Tentons de faire des fournisseurs de soins de santé et des gens qu'ils traitent les véritables gagnants de cet effort d'envergure!

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph. D. (doctorante), Ontario



Directrice générale
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario

# Avis de non-responsabilité et droits d'auteur

## Avis de non-responsabilité

Les infirmières et les organismes qui les emploient ne sont pas tenus d'appliquer les présentes lignes directrices. Leur utilisation doit être souple afin de s'adapter aux désirs du client et de sa famille et aux situations particulières. Elles ne constituent en rien une responsabilité ni une décharge de la responsabilité. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s'assurer de l'exactitude du contenu au moment de la publication, ni les auteurs, ni l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) ne garantissent l'exactitude de l'information contenue dans ces lignes directrices, ni n'acceptent aucune responsabilité quant à la perte, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses découlant d'erreurs ou d'omissions dans le contenu de ce document.

## Droit d'auteur

À l'exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière contre la copie est indiquée, le reste de ce document est du domaine public et peut être reproduit et publié sans nécessiter le consentement ou la permission des détenteurs des droits d'auteur. Toutefois, l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) apprécie qu'une citation ou une référence apparaisse dans le format indiqué ci-dessous :

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (2006). *Développement et maintien du leadership infirmier.* Toronto, Canada : Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario.

# Membres du groupe de préparation

Heather K. Spence Laschinger, inf. aut., Ph. D.
**Présidente du groupe**
Professeure et codirectrice de la recherche
en sciences infirmières
École de sciences infirmières,
University of Western Ontario
London (Ontario)

Joan Almost, inf. aut., M. Sc. Inf.
Doctorante
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

Irmajean Bajnok, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
Directrice, Centre for Professional Nursing
Excellence de l'Association des infirmières
et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO)
Toronto (Ontario)

Diane Bewick, inf. aut., B. Sc. Inf.,
M. Sc. Inf., DPA
Directrice, Unités de santé familiale;
chef des soins infirmiers
Bureau de santé de London
London (Ontario)

Denise Dietrich, inf. aux. aut., B. A. , M. S. Sc.
Infirmière soignante
Parkwood Mennonite Home
Waterloo (Ontario)

Karen Eisler, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf.
Coordonnatrice des membres
Saskatchewan Registered Nurses' Association
Régina (Saskatchewan)

Carol Fine, inf. aut., B. Sc. Inf., M. S. Sc.
Codirectrice programme d'études supérieures
Ryerson School of Nursing
Toronto (Ontario)

Paula J. Manuel, inf. aut., B. Sc. Inf.
Infirmière soignante
Hospital for Sick Children
Toronto (Ontario)

Sue Matthews, inf. aut., B. A., M. S. Sc. Inf., D.H.P.
Infirmière en chef de la province
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Secrétariat des soins infirmiers
Toronto (Ontario)

Jane Merkley, inf. aut., M.Sc.
Directrice de la formation et de la pratique infirmière
Hôpital St. Michael's
Toronto (Ontario)

Kaaren Neufeld, inf. aut., M. Sc. Inf.
Infirmière en chef et directrice exécutive
Hôpital général Saint-Boniface
Winnipeg (Manitoba)

Barbara Oke, inf. aut., B. Sc. Inf., MHSA
Conseillère en politique de soins infirmiers
Ministère de la Santé
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Nancy Purdy, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
(candidate)
Doctorante
Université de Western Ontario
London (Ontario)

Shirlee Sharkey, inf. aut., B. A., B. Sc. inf., M. S. Sc., CHE
Présidente-directrice générale
Saint Elizabeth Health Care
Markham (Ontario)

Judith Skelton-Green, inf. aut., Ph. D.
Présidente
TRANSITIONS : HOD Consultants Inc
Penetanguishene (Ontario)

Marcia Taylor, inf. aut., B. Sc. Inf.
Infirmière soignante
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

Donna Tucker, inf. aut., M. Sc. Inf.
Coordonnatrice du groupe (2003 à 2005)
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO)
Toronto (Ontario)

# Responsabilté du développement

**L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO),** grâce au financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée en partenariat avec Santé Canada, a entrepris un projet s'échelonnant sur plusieurs années visant à préparer, à mettre en place à l'essai, à évaluer et à diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires dans les milieux de travail sains. La présente ligne directrice a été préparée par un groupe d'experts réunis par l'AIIAO, effectuant leur travail indépendamment de toute partialité ou d'influence provenant d'organismes de financement. Le groupe a bénéficié du soutien de l'équipe de projet de l'équipe de l'AIIAO présentée ci-après.

## Équipe de projet

Irmajean Bajnok, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
Directrice, Centre for Professional Nursing Excellence
de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l'Ontario (AIIAO)
Directrice de projet (depuis juillet 2005)

Donna Tucker, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice de projet (de 2003 à 2005)

Cian Knights, B. A.
Assistante de projet (d'août 2003 à août 2005)

Erica Kumar, B. Sc.
Assistante de projet (depuis septembre 2005)

Coordonnées
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario
Projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains
158, rue Pearl, Toronto (Ontario) M5H 1L3
Site Web : http://www.rnao.org

# Reconnaissance des parties intéressées

**L'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario souhaite remercier les personnes suivantes pour leur contribution à la révision de la présente ligne directrice en soins infirmiers et pour nous avoir communiqué leur précieuse rétroaction.**

Silvana Biscaro, B. Sc. Inf., M. A. (Ed.)
Directrice, chirurgie cardiaque
Trillium Health Centre
Mississauga (Ontario)

Dorothy Broeders-Morin, inf. aut., DHA
Directrice
Saint Elizabeth Health Care
Kingston (Ontario)

Darlene Brown, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice du projet de soins axés sur le client
Community Living South
Dashwood (Ontario)

Barbara Bruinse, inf. aut., B. Sc.
Infirmière en réponse clinique et coprésidente du conseil des infirmières autorisées
Hospital for Sick Children
Toronto (Ontario)

Beth Brunsdon-Clark, inf. aut., B. N., M. Sc. Inf.
Vice-présidente des programmes et des soins aux patients et de l'OIIO
Victoria General Hospital
Winnipeg (Manitoba)

Robin Buckland, inf. aut., M. Sc. Inf.
Analyste des politiques principale
Santé Canada, division des stratégies en matière de ressources humaines
Ottawa (Ontario)

Janet Carr, inf. aut., B. Sc. Inf.
Infirmière de la santé publique
Santé publique Ottawa
Ottawa (Ontario)

Anne Coghlan, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice exécutive
Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario
Toronto (Ontario)

Anne Coghlan, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice exécutive
College of Nurses of Ontario
Toronto (Ontario)

Kim Cook, inf. aut., B. A., M. Sc. S. Aux., au nom de la direction de NLN.ON
Présidente
NLN-ON
Toronto (Ontario)

Janet Cormier, inf. aut., B. Sc. Inf., CON (candidate), M. A.
Conseillère clinique
Saint Elizabeth Home Health Care
Markham (Ontario)

Salma Deb-Ivall, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf.
Coordonnatrice générale adjointe, formation en soins infirmiers
L'Hôpital d'Ottawa

Cori Dmitriew, inf. aut., B. Sc. inf., CINA (candidate), Inf. ACSP (candidate)
Superviseure des services de santé
Saint Elizabeth Health Care
Thunder Bay (Ontario)

Mary Anne Fish, inf. aut., B. A.
Directrice du centre de prestation de services
Saint Elizabeth Home Health Care
Ottawa (Ontario)

Wendy Gifford, inf. aut., Ph. D. (candidate)
Doctorante, Faculté des sciences de la santé
Université d'Ottawa, École de sciences infirmières
Ottawa (Ontario)

Greta Cummings, inf. aut., Ph. D.
Professeure adjointe, Faculté des soins infirmiers
Université de l'Alberta
Edmonton (Alberta)

Barbara Davies, inf. aut., Ph. D.
Professeure adjointe, École de sciences infirmières
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)

Michele Durrant, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc.
Infirmière enseignante principale
The Hospital for Sick Children
Toronto (Ontario)

Era Mae Ferron, inf. aut., B. Sc. Inf., M. N.
Infirmière coordonnatrice de la recherche
Ontario Neurotrauma Foundation Shaken Baby Syndrome Prevention Program
Life Span Adaptation Projects, Université de Toronto

Sharon Goodwin, inf. aut., B. Sc. Inf., M. N.
Vice-présidente des services aux clients
VON Canada
North Bay (Ontario)

Julie Gregg, inf. aut., M. Ad. Éd.
Coordonnatrice, Relations avec les membres et perfectionnement
College of Registered Nurses of Nova Scotia
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pat Griffin, inf. aut., Ph. D.
Directrice exécutive
Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)
Ottawa (Ontario)

Lisa-Anne Hagerman, inf. aut., D. Ed.
Professeure adjointe
Université Trent
Peterborough (Ontario)

Linda Hamilton, inf. aut., M. N.
Directrice exécutive
College of Registered Nurses of Nova Scotia
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Donna Hutton, inf. aut., M. Ed.
Directrice exécutive
Alberta Association of Registered Nurses
Edmonton (Alberta)

Mildred G. Jarvis, inf. aut., Dipl. Ed. Sc. Inf., BIS
Conseillère en milieu hospitalier et en SLD
L'Armée du Salut, siège social du Territoire du Canada et des Bermudes

Janice Joyce, inf. aux. aut., Dipl. Ad.
Spécialiste en pratique des soins infirmiers
College of Licensed Practical Nurses of British Columbia
Burnaby (Colombie-Britannique)

Alison Kitson, inf. aut., Ph. D., FRCN
Directrice exécutive des soins infirmiers
The Royal College of Nursing
Londres (Royaume-Uni)

Paulette Lacroix, inf. aut., B. Sc. Inf., M.H.P. (candidate)
Infirmière-conseil
PC Lacroix Consulting Inc.
Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Sue Le Beau, inf. aut. (Ec.), B. Sc. Inf., M. Sc. Inf.
Directrice de programme
Hôpital général de North Bay
North Bay (Ontario)

Heather Lee Kilty, B. A., M. Ed., Ph. D.
Professeure adjointe
Université Brock
St. Catherines (Ontario)

Jan Linscott, inf. aut., M. Sc. Inf.
Infirmière de pratique avancée- St. Mary's of Lake Site
Providence Continuing Care Centre
Kingston (Ontario)

### Francis Loos, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf., ICSI (candidat)
Spécialiste en développement clinique
Hôpital Pasqua – Régie régionale de la santé de Regina Qu'Appelle
Regina (Saskatchewan)

### Sandra MacDonald-Rencz, B. N., M. Ed., Dir. Soins de santé
Directrice exécutive
Santé Canada, Bureau de la politique des soins infirmiers
Ottawa (Ontario)

### Ann Mann, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice exécutive et registraire
College of Licensed Practical Nurses of Nova Scotia
Halifax (Nouvelle-Écosse)

### Mariana Markovic, inf. aut., B. Sc. Inf., Inf. Péd. Agréée (candidate)
Spécialiste de l'exercice professionnel, agente des relations du travail
Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario
Toronto (Ontario)

### Sylvia Masters, inf. aux. aut.
Infirmière auxiliaire autorisée
Leisureworld Caregiving Centre
Brampton (Ontario)

### Martine Mayrand Leclerc, inf. aut., M.G.S.S. (MHA), Ph. D. (candidate)
Professeure et coordonnatrice, Programmes d'études supérieures en soins infirmiers
Département des soins infirmiers, Université du Québec en Outaouais
Gatineau (Québec)

### Shirley McKay, inf. aut., B. Sc. inf., M. S. A.
Directeur, Services réglementaires et registraire
Saskatchewan Registered Nurses' Association
Régina (Sakatchewan)

### Barbara L. Mildon, inf. aut., M. Sc. Inf., Dir. Soins de santé
Associée de recherche, services infirmiers en soins de santé
Unité de recherche, Faculté des soins infirmiers
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

### Jean Morrison, inf. aut.
Infirmière en chef
Saskatoon Regional Health Authority
Saskatoon (Saskatchewan)

### Holly Quinn, inf. aut., B. Sc. Inf.
Directrice des programmes cliniques
Bayshore Home Health
Mississauga (Ontario)

### Christine Rieck-Buckley, inf. aut., M. Sc. A.
Infirmière-ressource en pratique avancée
Service de santé SCO
Ottawa (Ontario)

### Cheryl Reid Haughian, inf. aut., B. Sc. Inf.
Directrice, exercice professionnel
ParaMed Home Health Care
Ottawa (Ontario)

### Janet Rush, inf. aut., Ph. D.
Consultante, Soins infirmiers et évaluation de programme
Professeure agrégée, Trent; Professeure adjointe, McMaster
Hamilton (Ontario)

### Lisa Safian, inf. aut., B.A., M. Ed. (candidate)
Enseignante- Perfectionnement du personnel
The Brant Community Health Care System
Brantford (Ontario)

### Marcy Saxe-Braithwaite, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf., M. B. A., CHE
Vice-présidente des programmes et infirmière en chef
Providence Continuing Care Centre
Kingston (Ontario)

**Marlene Smadu, inf. aut., D. Ed.**
Vice-doyenne aux sciences infirmières, site de Régina
Université de la Saskatchewan
Régina (Saskatchewan)

**Patricia Somers, inf. aut., M. Sc. Inf., Dir. Soins de santé**
Vice-présidente des programmes cliniques
et infirmière en chef
Hotel Dieu Grace Hospital
Windsor (Ontario)

**Heather Tales, inf. aut., B. Sc. inf.**
Spécialiste de l'exercice professionnel en soins infirmiers
London Health Sciences Centre
London (Ontario)

**Deborah Tamlyn, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Ed., Ph. D.**
Présidente
Association des infirmières et des infirmiers du Canada
Ottawa (Ontario )

**Ann-Marie Urban, inf. aut., B. Sc. Inf., M. N.**
Infirmière enseignante
Nursing Education Program of Saskatchewan
Saskatchewan Institute of Applied Science & Technology
Regina (Saskatchewan)

**Colleen Van Berkel, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. S.**
Directrice, Service de la recherche appliquée
et de l'évaluation
Bureau des services communautaires et de santé
Division des politiques et de la planification des
programmes
Ville de Hamilton
Hamilton (Ontario)

**Michael J. Villeneuve, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc.**
Infirmier-conseil principal
Association des infirmières et des infirmiers du Canada
Ottawa (Ontario)

**Leslie Vincent, inf. aut., M. Sc.(A), CON (candidate)**
Première vice-présidente, sciences infirmières
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

**Robin Buckland, inf. aut., M. Sc. Inf.**
Analyste principale en matière de politiques
Santé Canada- Division des stratégies des ressources
humaines en santé
Ottawa (Ontario)

**Maureen White, inf. aut., M. Sc. Inf., IBCLC, PNC (candidate)**
Professeure adjointe
Université Dalhousie, École de sciences infirmières
Halifax (Nouvelle-Écosse)

**Leslie Williams, inf. aut., B. Sc., B. Sc. Inf.**
Coordonnateur de la recherche clinique
The Gerry & Nancy Pencer Brain Tumor Centre
Princess Margaret Hospital
Toronto (Ontario)

**Pete Wimpenny, inf. gén. aut., B. Sc., Cert. Ed., Ph. D.**
Codirecteur
Joanna Briggs Collaborating Centre, Royaume-Uni
Aberdeen, Écosse

**Carol Wong, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf.**
Professeure adjointe
Université de Western Ontario
London (Ontario)

**Cheryl Yost, inf. aut., B. Sc., M. Ed.**
Directrice, Formation et perfectionnement
Huron Perth Healthcare Alliance
Stratford (Ontario)

# Table des matières

Contexte du projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains ..... 12

Structure organisationnelle du projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains ..... 14

Contexte d'origine de la Ligne directrice sur le développement et le maintien du leadership infirmier ..... 19

Intention et champ d'activité ..... 21

Comment utiliser ce document ..... 22

Modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership ..... 24

Aperçu du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership ..... 25

Sommaire des recommandations ..... 27

Sources et types de données probantes sur le développement et le maintien du leadership infirmier ..... 29

Recommandations relatives à la pratique du leadership ..... 31
- Établir des rapports et des liens de confiance ..... 33
- Créer un milieu de travail habilitant ..... 37
- Créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances ..... 42
- Diriger et maintenir le changement ..... 47
- Équilibrer les valeurs et les priorités contradictoires ..... 52

Recommandations relatives à l'établissement ..... 56

Recommandations relatives aux ressources personnelles ..... 71

Recommandations relatives au système ..... 77
- Recommandations aux gouvernements ..... 77
- Recommandations aux chercheurs ..... 80
- Recommandations aux organismes responsables de l'agrément ..... 83
- Recommandations relatives à la formation ..... 83

Processus de mise à jour et de révision des lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains ..... 87

Évaluation et surveillance du développement et du maintien de la ligne directrice sur le leadership infirmier ..... 88

Références
Références numérotées ..... 91
Références – auteurs en ordre alphabétique ..... 114

Annexe A : Glossaire ..... 134

Annexe B : Processus de préparation des Lignes directrices ..... 140

Annexe C : Processus de l'examen méthodique de la littérature spécialisée sur
le développement et le maintien du leadership infirmier effectué par le Joanna Briggs Institute ..... 141

Annexe D : Mesures des concepts liés au modèle conceptuel pour le développement
et le maintien du leadership ..... 144

# Contexte du projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains

**En juillet 2003, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIAO),** grâce au financement du ministère de la Santé et des Soins longue durée de l'Ontario (MSSLD), en partenariat avec le Bureau de la politique des soins infirmiers de Santé Canada, a débuté la rédaction des lignes directrices[G] pour la pratique exemplaire basées sur les données probantes afin de créer des milieux de travail sains pour les infirmières. Tout comme pour la prise de décisions cliniques, il est important que ceux qui se concentrent sur la création de milieux de travail sains prennent des décisions en fonction des meilleures données probantes possibles.

Le projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains[G] se veut une réponse aux besoins prioritaires déterminés par le Joint Provincial Nursing Committee (JPNC) et le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers[1]. L'idée de rédiger et de distribuer à grande échelle un guide sur les milieux de travail sains a d'abord été proposée dans *Ensuring the care will be there: Report on nursing recruitment and retention in Ontario*[2], soumise au MSSLD en 2000 et approuvée par JPNC.

Les systèmes de soins de santé sont sous l'effet de pressions croissantes pour contrôler les coûts et accroître la productivité tout en répondant aux demandes croissantes des populations qui grandissent et vieillissent, de la technologie qui progresse et du consumérisme plus élaboré[3]. Au Canada, la réforme des soins de santé est axée sur les principaux objectifs précisés dans l'Accord des premiers ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de 2000[4], l'Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé de 2003[5] et de 2004[6] :

- la prestation en temps opportun de services de santé en fonction des besoins;
- des soins de santé de qualité supérieure, efficaces, axés sur le patient et fiables;
- un système de santé viable et abordable.

Les infirmières[G] sont une composante essentielle dans l'atteinte de ces objectifs. Un nombre suffisant d'infirmières est primordial au maintien d'un accès abordable aux soins de santé sûrs et opportuns. La création de milieux de travail sains pour les infirmières est cruciale au recrutement et au maintien en poste des infirmières.

De nombreux rapports et articles ont documenté les défis que représentent le recrutement et le maintien d'un effectif sain d'infirmières[2, 7-11]. Certains suggèrent que le fondement de la pénurie actuelle de personnel infirmier est le résultat de milieux de travail malsains[12-15]. Des stratégies visant à améliorer les milieux de travail des infirmières sont nécessaires pour réparer les dommages causés par une décennie de restructuration incessante et de réduction des effectifs[3].

La relation entre les milieux de travail des infirmières, les résultats obtenus auprès des patients et le rendement de l'organisation et du système est de mieux en mieux comprise[16-18]. De nombreuses études ont montré des liens solides entre la dotation en infirmières et les conséquences défavorables auprès des patients[19-29]. Les données probantes ont montré que les lieux de travail sains rapportent des avantages financiers aux organisations sur le plan de la réduction de l'absentéisme, de la perte de productivité, des dépenses organisationnelles en matière de soins de santé[30] et des coûts provenant des conséquences défavorables[G] auprès des patients[31].

La création de milieux de travail sains pour les infirmières nécessite un *changement transformationnel,* au moyen « d'interventions ciblant le milieu de travail sous-jacent et les facteurs organisationnels »[32]. C'est pourquoi nous avons préparé ces lignes directrices. Nous croyons que la mise en place intégrale fera une différence au niveau des infirmières, de leurs patients, ainsi qu'à celui des organisations et des communautés dans lesquelles elles pratiquent. On prévoit que le fait de mettre l'accent sur la création de milieux de travail sains sera bénéfique non seulement aux infirmières, mais aux autres membres de l'équipe soignante. Nous croyons aussi que les lignes directrices pour la pratique exemplaire ne peuvent être mises en place avec succès qu'en présence de planification, de ressources et d'appuis organisationnels et administratifs adéquats, ainsi qu'avec la facilitation appropriée.

## Le projet se traduira par six lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains

- Pratique en collaboration au sein des équipes de soins infirmiers
- Développement et maintien de pratiques efficaces en matière de dotation et de charge de travail
- Développement et maintien du leadership infirmier
- Souscription au principe de la diversité culturelle dans les soins de santé : développement de la compétence culturelle
- Professionnalisme de l'infirmière
- Santé, sécurité et bien-être de l'infirmière dans un milieu de travail sain

*« Un milieu de travail sain, c'est…*

*…un milieu de travail qui maximise la santé et le bien-être des infirmières, des résultats de qualité chez le patient, le rendement organisationnel et les retombées sociales. »*

# Le projet se traduira par six lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains

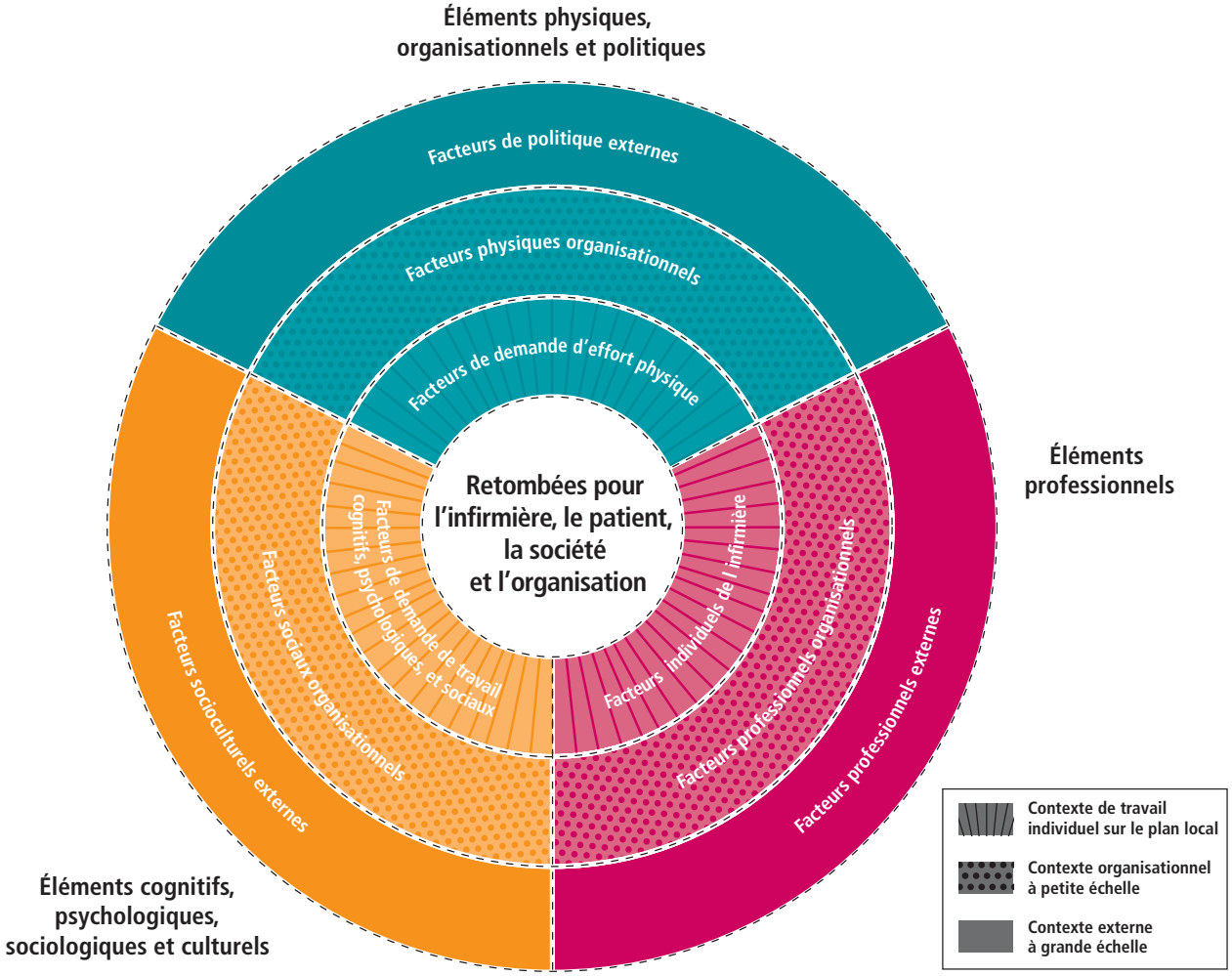



**Figure 1. Modèle conceptuel des milieux de travail sains des infirmières – Éléments, facteurs et résultats** [iii]

Un milieu de travail sain pour les infirmières est complexe et multidimensionnel, et se compose de nombreux éléments, ainsi que de rapports entre les éléments. Un modèle complet est nécessaire afin de guider la préparation, la mise en place et l'évaluation d'une approche systématique dans le but d'améliorer le milieu de travail des infirmières. Les milieux de travail sains pour les infirmières se définissent comme des lieux de travail qui maximisent la santé et le bien-être de l'infirmière, des résultats de qualité chez le patient, le rendement organisationnel et les retombées sociales.

Dans son intégralité, le modèle conceptuel des lieux de travail sains des infirmières présente le milieu de travail sain comme un produit de l'interdépendance entre les déterminants du système individuel (petite échelle), organisationnel (local) et externe (grande échelle), tel qu'illustré ci-dessus dans les trois cercles extérieurs. Au centre des cercles se trouvent les bénéficiaires des milieux de travail sains : les infirmières, les patients, les organisations et les systèmes, et la société dans son ensemble, y compris des collectivités plus saines[2]. Les lignes à l'intérieur du modèle sont pointillées afin d'indiquer les interactions synergiques entre tous les niveaux et les éléments du modèle.

Le modèle suppose que le rôle de la personne est modifié et influencé par les interactions entre la personne et son environnement. Par conséquent, les interventions visant à promouvoir les lieux de travail sains doivent cibler divers niveaux et éléments du système. De même, les interventions n'influencent pas que les facteurs à l'intérieur du système et les interactions parmi ces facteurs : ils influencent aussi le système en soi[3 vi].

Voici les hypothèses sous-jacentes au modèle :

- des milieux de travail sains sont essentiels pour des soins aux patients de qualité et sûrs;
- le modèle s'applique à tous les lieux de travail et à tous les domaines de soins infirmiers;
- les facteurs sur le plan des systèmes individuel, organisationnel et externe sont les déterminants des lieux de travail sains pour les infirmières,
- les facteurs des trois niveaux influent sur la santé et le bien-être des infirmières, les résultats de qualité pour les patients, le rendement de l'organisation et du système, les retombées sociales, soit individuellement ou au moyen d'interactions synergiques;
- à chaque niveau, il y a des éléments de politique physiques et structurels, des éléments cognitifs, psychologiques, sociaux et culturels, ainsi que des éléments professionnels;
- les facteurs professionnels sont uniques à chaque profession, alors que les autres facteurs sont génériques à toutes les professions ou à tous les postes.

---

i Adaptation de DeJoy, D.M, & Southern, D.J. (1993) *An Intergrative perspective on work-site health promotion.* Journal of medicine, 35(12): décembre, 1221-1230; modifié par: Lashinger, MacDonald et Shamian (2001) et davantage par Griffin, El-Jardali, Tucker, Grinspun, Bajnok et Shamian (2003).

iI Baumann, A., O'Brien-Pallas, L. Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., Irvin Doran D., et al (juin 2001) *Commitment and care: The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients, and the system.* Ottawa (Canada): Fondation canadienne sur les services de santé et The Challenge Foundation.

iii O'Brien-Pallas, L., & Baumann, A. (1992) *Quality of nursing worklife issues: A unifying framework.* Canadian Journal of Nursing Administration, 5(2):12-16.

iv Hancock, T. (2000) *The Healthy Communities vs. "Health".* Canadian Health Care Management, 100(2):21-23.

v Green, L.W., Richard, L. and Potvin L. (1996) *Ecological foundation of health promotion.* American Journal of Health Promotion, 10(4): mars-avril, 270-281.

vi Grinspun, D., (2000) *Taking care of the bottom line: shifting paradigms in hospital management.* Dans Diana L, Gustafson (éd.), Care and Consequence: Health Care Reform and Its Impact on Canadian Women. Halifax, Nouvelle-Écosse (Canada). Fernwood Publishing.

**Éléments physiques, organisationnels et politiques**

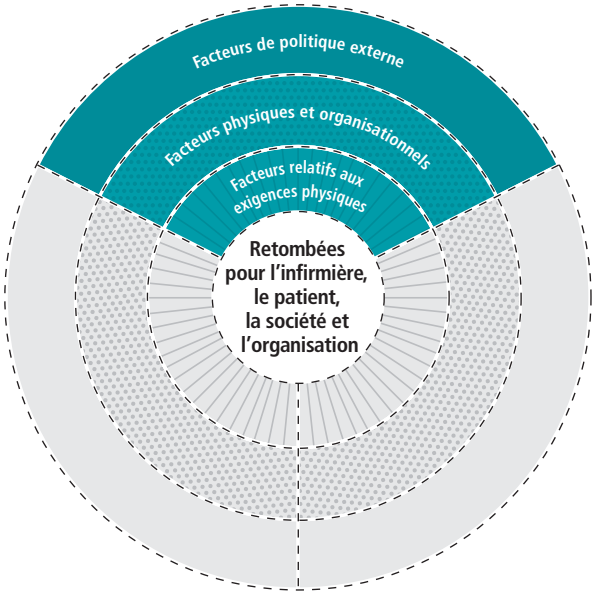



**Figure 1A**

## Éléments physiques, organisationnels et politiques

- Sur le plan individuel, les facteurs de demande d'effort physique sont les exigences du travail qui nécessitent des capacités physiques et un effort de la part de l'individu[vii]. Parmi ces facteurs on trouve, la charge de travail, les horaires et les quarts qui changent constamment, le soulèvement de charges lourdes, l'exposition aux substances dangereuses et infectieuses et les menaces pour la sécurité personnelle.
- Sur le plan organisationnel, les facteurs physiques organisationnels comprennent les caractéristiques de l'environnement physique de l'organisation, ainsi que les processus et les structures organisationnels créés pour répondre aux exigences physiques de l'emploi. Parmi ces facteurs, on trouve les pratiques de dotation, les horaires flexibles et l'établissement d'horaires par les infirmières, l'accès à un matériel de levage en bon état, les politiques sur la santé et la sécurité au travail et la sécurité personnelle.
- Sur le plan externe et celui du système, les facteurs de politique comprennent les modèles de prestation de soins de santé, le financement et les cadres législatif, commercial, économique et politique (p. ex., politiques migratoires, réforme du système de santé) externes à l'organisation.

vii Grinspun, D. (2000) The Social Construction of Nursing Caring. (thèse de doctorat soumise non publiée)

**Éléments cognitifs, psychologiques, sociologiques, et culturels**

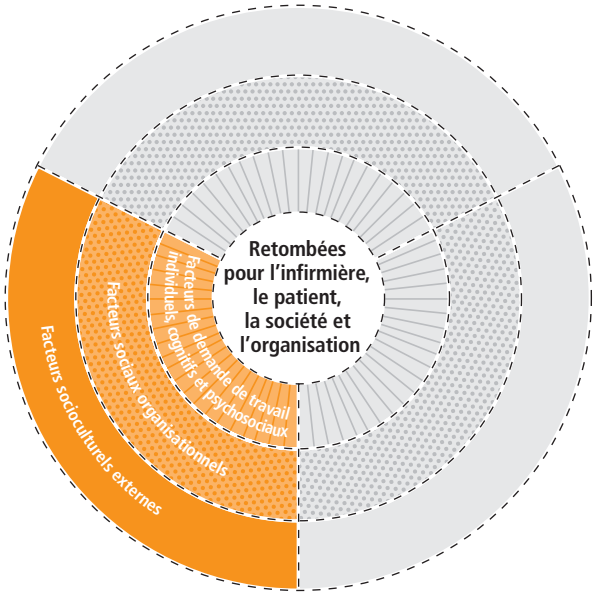



**Figure 1B**

## Éléments cognitifs, psychologiques, sociaux et culturels

- Sur le plan individuel, les facteurs de demande de travail cognitif et psychosociaux comprennent les exigences du travail qui nécessitent une des capacités cognitives, psychologiques et sociales (p. ex., connaissances cliniques, habiletés d'adaptation efficaces, aptitudes à communiquer) de la part de l'individu[vii]. Parmi ces facteurs, on trouve la complexité clinique, la sécurité d'emploi, les relations d'équipe, les difficultés affectives, la précision du rôle et la tension liée au rôle.
- Sur le plan organisationnel, les facteurs sociaux organisationnels sont liés aux climat organisationnel, à la culture et aux valeurs. Parmi ces facteurs, on trouve la stabilité organisationnelle, les pratiques et les structures de communication, les relations de travail, la gestion des relations et une culture d'apprentissage continu et de soutien.
- Sur le plan du système, les facteurs socioculturels externes comprennent les tendances en consommation, les préférences en ce qui concerne les soins changeants, les rôles changeants de la famille, la diversité de la population et celle des fournisseurs, ainsi que les données démographiques changeantes – tous influent sur le fonctionnement des organismes et des individus.

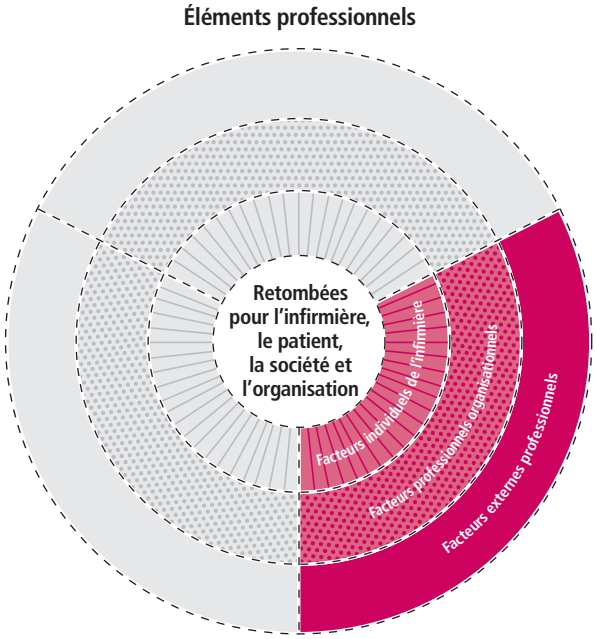



**Figure 1C**

## Éléments professionnels

- Sur le plan individuel, les facteurs individuels de l'infirmière comprennent les qualités personnelles et les compétences acquises de même que le savoir de l'infirmière qui déterminent la façon dont elle répond aux demandes physiques, cognitives et psychosociales du travail[vii]. Parmi ces facteurs, on trouve l'engagement envers les soins aux patients, l'organisation et la profession, les valeurs personnelles et l'éthique, la pratique réflexive, la résistance, l'adaptabilité et la confiance en soi, et l'équilibre entre le travail et la vie de famille.
- Sur le plan organisationnel, les facteurs professionnels et organisationnels sont caractéristiques de la nature et du rôle du poste. Parmi ces facteurs, on trouve le champ d'activité de la pratique, le degré d'autonomie et le contrôle sur la pratique, ainsi que les relations intradisciplinaires.
- Sur le plan externe et celui du système, les facteurs professionnels externes comprennent les politiques et les règlements au niveau provincial ou territorial, national et international qui ont une influence sur les politiques sociales et de santé, ainsi que la socialisation du rôle au sein des diverses disciplines et des divers domaines concernés.

# Contexte d'origine des lignes directrices pour le développement et le maintien du leadership infirmier

**Au cours des 20 dernières années,** nous avons été témoins d'un taux de changement sans précédent dans le domaine des soins de santé en raison des réformes visant en grande partie à réduire les coûts tout en tentant d'améliorer ou de maintenir les résultats. Pendant cette période, il y a une diminution spectaculaire du nombre de postes officiels de leadership en soins infirmiers. De 1994 à 2002, au Canada, il y a eu abolition de 6 733 postes de direction, soit une baisse de 29 %[1, 33-35]. Pour ceux qui conservent leur poste de direction, l'expansion du rôle et les multiples demandes contradictoires ne laissent que peu de temps pour soutenir les nouveaux chefs et agir à titre de mentor à leur intention[36]. Le Canada est un pays qui possède un effectif infirmier de plus en plus diversifié[37] à la suite de la mondialisation et du mouvement international des infirmières. Les leaders en soins infirmiers doivent être en mesure de favoriser la croissance et d'agir à titre de mentor auprès des futurs leaders à l'échelle de cet effectif diversifié.

Les structures de gestion de programme ont entraîné le démantèlement des structures départementales professionnelles traditionnelles qui appuient généralement la pratique professionnelle et facilitent l'éducation de la prochaine génération de leaders en soins infirmiers[38]. Le poste d'infirmière en chef a été modifié pour devenir un poste consultatif et cela présente des défis supplémentaires, car le leader doit s'en remettre à son influence et à ses aptitudes de persuasion hautement développées plutôt qu'à son autorité directe sur les décisions d'allocation de ressources, qui influent sur la pratique des soins infirmiers et la qualité des soins offerts aux patients[38]. M. Clifford a mentionné que, au fur et à mesure que les organismes de soins de santé passent d'une orientation professionnelle à une orientation commerciale, la nécessité de s'attarder au côté commercial n'est pas mise en cause, mais plutôt la façon dont les leaders conservent l'équilibre et assure un leadership professionnel[36].

Le leadership en soins infirmiers efficace est important dans tous les rôles de soins infirmiers, qu'il s'agisse d'une infirmière qui pratique dans le domaine de l'éducation visant à former de futurs leaders, d'un chercheur mentor auprès de nouveaux chercheurs, d'un administrateur qui offre soutien et conseils au personnel, d'un praticien qui fournit des soins exemplaires et partage son expertise, ou tous ceux qui donnent des directives et appuient la pratique grâce à la préparation de politiques. Pour les nouveaux diplômés, le leadership c'est aussi apprendre comment déléguer et superviser les autres. Pour les infirmières plus expérimentées, le leadership intègre des tâches de préceptorat, de mentorat et d'administration, telles qu'établir les horaires et agir à titre de responsable, ainsi que les activités professionnelles comme le travail en comité[39].

La qualité du leadership professionnel en soins infirmiers a été liée à l'atteinte de bons soins aux patients de même qu'au recrutement et au maintien en poste du personnel infirmier[40-42]. Les études menées par Kramer et Schmalenberg aux États-Unis, entre 1985 et 2001, sur les hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier[G] ont montré que le fait de compter sur les services d'une infirmière gestionnaire offrant un soutien est un des éléments essentiels au « magnétisme » et qui est important pour établir la confiance

dans le milieu de travail[40,41]. Non seulement les taux de recrutement et de conservation des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier sont-ils plus élevés, le taux de mortalité des patients qui s'y trouvent a diminué[43]. De façon similaire, M. Boyle, dans le cadre d'une étude sur les caractéristiques des lieux de travail des infirmières au sein de l'unité, a découvert un lien entre les traits d'autonomie et de collaboration caractéristiques des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier[G] et l'amélioration des résultats escomptés chez les patients (un plus faible taux d'échec en réanimation et un moindre taux d'infection urinaire)[44]. Des niveaux élevés d'appui au leadership ont été associés à des taux inférieurs de prévalence des plaies de pression et des taux de mortalité.

Des rapports récents tels que celui de la Commission sur l'avenir des soins de santé au Canada, présidé par le commissaire Roy Romanow [45], l'Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé[5], la communication portant sur le leadership de l'*Academy of Canadian Executive Nurses*[38] et le rapport de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada sur le développement des soins infirmiers au Canada[46] attirent tous l'attention sur l'importance de renforcer le leadership en soins infirmiers au Canada, à la fois pour la qualité des résultats des patients et pour la durabilité des ressources humaines en soins infirmiers. *À l'écoute II*[47], une consultation nationale publiée récemment par la Fondation canadienne de la recherche sur les services de soins de santé qui porte sur les enjeux relatifs aux services et aux politiques de la santé, a déterminé que l'éducation de leaders professionnels était une priorité tout comme la nécessité de déterminer :

- les caractéristiques principales de leaders remarquables dans le domaine des soins de santé et à l'extérieur;
- les compétences en leadership pertinentes sont nécessaires dans le domaine des soins de santé;
- les fondements d'une formation efficace et expérientielle afin de développer de futurs leaders en soins de santé;
- un processus d'évaluation afin de déterminer les effets du milieu de travail sain sur les résultats de soins escomptés chez les patients[47].

# Intention et champ d'activité

## Intention

**Nous avons préparé ces lignes directrices pour la pratique exemplaire afin de déterminer et de décrire :**

- les pratiques de leadership qui entraînent des résultats sains pour les infirmières, les patients, les organisations et les systèmes;
- les ressources du système qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
- la culture organisationnelle, les valeurs et les ressources qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
- les ressources personnelles qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
- les résultats prévus du leadership efficace en soins infirmiers.

## Champ d'activité

**Par conséquent, ce document traite :**

- des connaissances[G], des compétences et des comportements des leaders efficaces;
- des exigences scolaires et des stratégies;
- des changements à la politique sur le plan de l'organisation et du système nécessaires pour appuyer et soutenir les pratiques de leadership;
- de la mise en place de stratégies et d'outils;
- des critères et des outils d'évaluation;
- des possibilités de recherches futures.

## Public cible

**Les lignes directrices pour la pratique exemplaire sont pertinentes aux infirmières :**

- peu importe leur rôle, y compris les étudiants, les infirmières cliniciennes, les administrateurs, les enseignants, les chercheurs et toutes les personnes qui participent à la mise sur pied de politiques;
- de tous les domaines des soins infirmiers (pratique clinique, administration, enseignement, recherche et politique);
- de tous les lieux de pratique.

**Ce document sera aussi utile :**

- aux membres de l'équipe interprofessionnelle;
- aux administrateurs qui n'œuvrent pas en soins infirmiers au sein de l'unité, de l'organisme et du système;
- aux décideurs et aux gouvernements;
- aux organisations professionnelles, aux employeurs et aux syndicats;
- aux organismes de normalisation fédéraux, provinciaux et territoriaux.

*« Si vos gestes inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à accomplir davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader (traduction) John Quincy Adams »*

*1767-1848*

# Comment utiliser ce document

**Les normes professionnelles exigent que les infirmières,** peu importe leur rôle, fassent preuve de leadership[G]. Les infirmières qui jouent un rôle en pratique clinique, ainsi que celles qui jouent un rôle de leadership formel ou non, le font en relation avec les patients, leurs collègues infirmières, les autres membres de l'équipe de soins de santé, les étudiants et dans le cadre d'une relation mentor-personne encadrée. Les lignes directrices pour la pratique exemplaire offrent une approche globale du leadership. Elles ne sont pas conçues pour être lues et appliquées en un seul bloc, mais, plutôt, pour être examinées puis, à la suite d'une réflexion, au fil du temps, appliquées comme il convient, pour vous-même, votre situation ou votre organisation. Nous suggérons l'approche suivante.

1. **Étudiez le modèle :** les lignes directrices pour la pratique exemplaire en leadership sont établies selon un modèle conceptuel de leadership créé pour permettre aux utilisateurs de comprendre les relations qu'entretiennent les principaux facteurs présents dans le cadre du leadership infirmier. Comprendre le modèle décrit à la figure 2 est essentiel à l'utilisation efficace du document. Nous recommandons que vous consacriez d'abord du temps à sa lecture et que vous y réfléchissiez.

2. **Déterminez un domaine cible :** une fois que vous aurez étudié le modèle, nous suggérons que vous déterminiez un domaine cible pour vous-même, votre situation ou votre organisation, un domaine sur lequel vous croyez devoir vous attarder afin de renforcer l'efficacité du leadership.

3. **Lisez les recommandations et les résumés des recherches dans votre domaine cible :** un nombre de recommandations basées sur les données probantes sont offertes pour chaque élément important du modèle. Les recommandations sont des énoncés de ce que les leaders *font* ou de la façon dont ils se *comportent* en situation de leadership. La documentation qui préconise ces recommandations est résumée et nous croyons que vous trouverez utile de la lire afin de comprendre le « pourquoi » des recommandations.

4. **Concentrez-vous sur les recommandations ou les comportements souhaités qui semblent les plus applicables pour vous et votre situation actuelle :** les recommandations contenues dans ce document ne doivent pas être appliquées comme des règles; elles doivent plutôt vous servir d'outil afin d'aider les personnes et les organisations à prendre des décisions visant à améliorer le leadership infirmier, à reconnaître la culture, le climat et les défis conjoncturels uniques à chaque organisation. Dans certains cas, il faut tenir compte de nombreux renseignements. Vous voudrez explorer davantage et déterminer ces comportements qui doivent être analysés ou renforcés selon votre situation.

5. **Établissez un plan à l'état de projet :** après avoir choisi un petit nombre de recommandations et de comportements sur lesquels vous attarder, consultez le tableau des stratégies et considérez les suggestions présentées. Établissez un plan à l'état de projet qui traite de ce vous souhaitez vraiment *faire* pour aborder votre domaine cible. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consultez certaines des références citées ou certains des instruments d'évaluation mentionnés à l'annexe D.

6. **Discutez du plan avec les autres** : prenez le temps d'obtenir l'avis des personnes qui sont susceptibles d'être touchées par votre plan ou dont l'engagement sera essentiel au succès, ainsi que des conseillers, qui vous donneront de la rétroaction honnête et utile sur la pertinence de vos idées. C'est une phase aussi importante pour le développement des compétences en leadership individuel que pour le développement d'une initiative de leadership organisationnel.

7. **Révisez votre plan et commencez** : il est important de commencer et de faire les ajustements au fur et à mesure. Le développement de pratiques en leadership infirmier[G] efficaces est un processus continu, **profitez-en!**

# Modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership

***Le modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership*** organise et guide la discussion au sujet des recommandations. Il offre un modèle afin de comprendre les pratiques en leadership nécessaires à l'obtention de milieux de travail sains, ainsi que les soutiens organisationnels et les ressources personnelles qui mettent en œuvre ces pratiques en leadership efficaces.

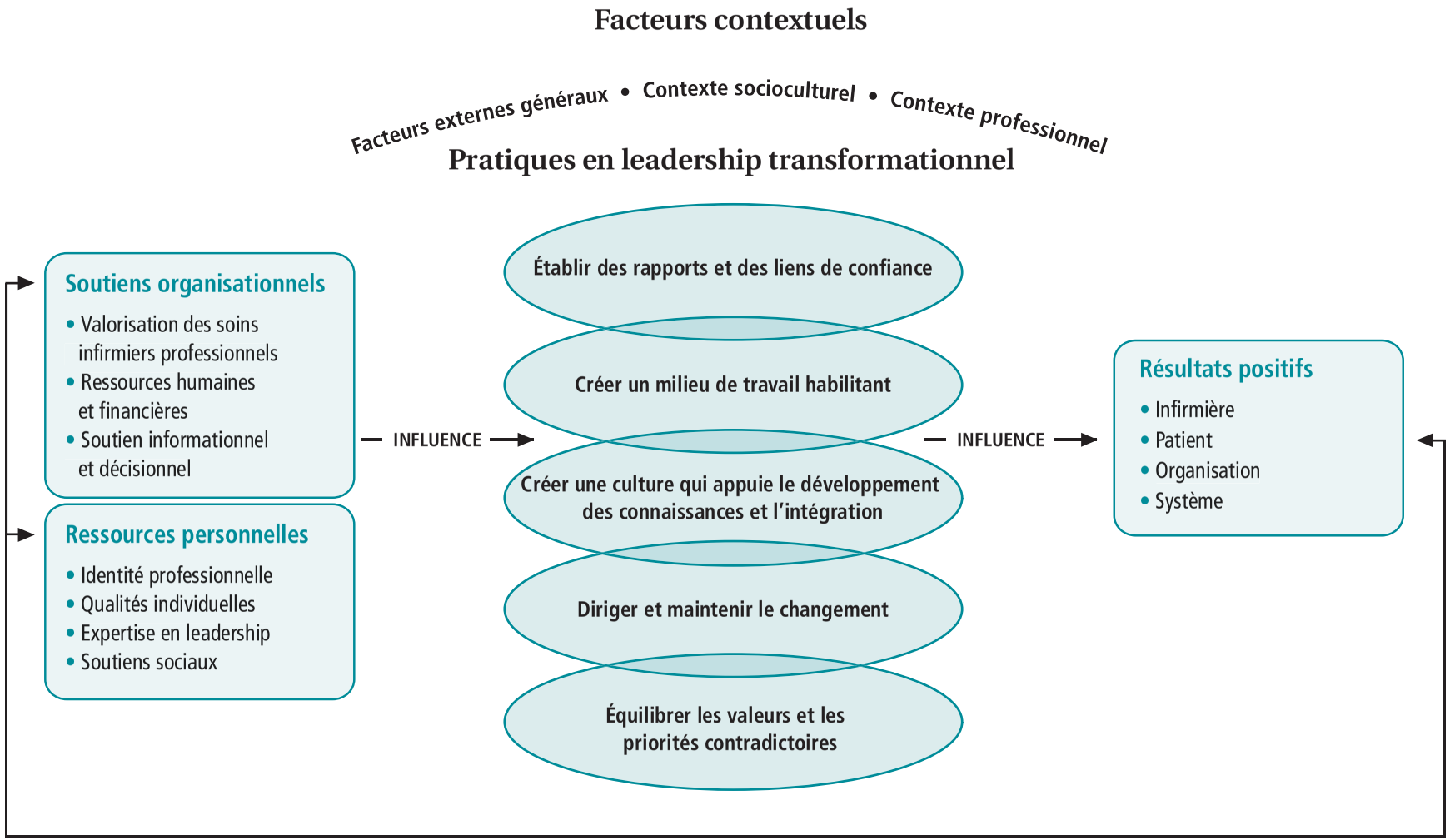



**Figure 2 – Modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership**

# Aperçu du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership

**L'élément central du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership** (Figure 2) consiste en cinq *pratiques en leadership transformationnel* basées sur des données probantes essentielles pour transformer les lieux de travail des infirmières en des milieux de travail sains. Les facteurs de prédisposition aux *soutiens organisationnels* et aux *ressources personnelles* influencent la capacité du leader à mettre en œuvre les pratiques de leadership efficaces. Il a été démontré que les pratiques de leadership entraînent des résultats positifs pour les patients, les infirmières et les organisations[48, 49]. En retour, grâce à une boucle de rétroaction, les résultats renforcent une culture positive du milieu de travail. Tout ceci se déroule dans un *contexte environnemental* plus large où les politiques, les facteurs socioculturels et professionnels influent sur la façon dont les facteurs de prédisposition, les pratiques de leadership et les résultats sont mis en œuvre au sein des milieux de travail de soins infirmiers.

## Les cinq pratiques de leadership transformationnel

1. *Établir des rapports et des liens de confiance* est une pratique de leadership qui constitue le fondement de toutes les autres pratiques.

2. *Créer un milieu de travail habilitant* dépend des relations de confiance respectueuses qu'entretiennent les membres d'un milieu de travail. Un milieu de travail habilitant suppose un accès à l'information, du soutien, des ressources et des occasions d'apprentissage et de croissance dans un cadre qui appuie l'autonomie professionnelle et les solides réseaux de support collégial.

3. *Créer une culture qui appuie le développement et l'intégration des connaissances* nécessite l'encouragement du développement et du partage des nouvelles connaissances, ainsi que le fait de susciter une remise en question continue de la pratique au sein du lieu de travail. Ces connaissances sont utilisées pour diriger les efforts visant à continuellement améliorer les processus cliniques et organisationnels de même que les résultats.

4. *Diriger et maintenir le changement* signifie qu'il faut prendre une approche proactive et participative afin de mettre en œuvre les changements qui se traduisent par l'amélioration des processus cliniques et organisationnels, ainsi que des résultats.

5. *Équilibrer les valeurs et les priorités* contradictoires nécessite la promotion des ressources en soins infirmiers nécessaires afin d'assurer la qualité supérieure des soins aux patients, tout en reconnaissant les demandes multiples à aborder lors de la prise de décision organisationnelle.

***Les soutiens organisationnels*** influencent la mise en place réussie de pratiques de leadership et le leadership infirmier solide et visible. Parmi ces soutiens, on trouve :

- la valorisation du rôle essentiel des infirmières dans la prestation de soins aux patients;
- la présence de ressources humaines et financières suffisantes et adéquates;
- l'information et l'aide à la décision nécessaires.

Chaque membre apporte des ***ressources personnelles*** à son rôle de leadership, y compris de nombreuses qualités personnelles et des ressources qui influencent leur succès en ce qui concerne la mise en œuvre des cinq pratiques de leadership. Parmi les *ressources personnelles,* on trouve :

- l'identité professionnelle;
- l'expertise, l'éducation et l'expérience en leadership;
- les caractéristiques individuelles, telles que la santé et la résilience;
- les soutiens sociaux, y compris les personnes et les relations qui assurent un soutien.

## Le leadership infirmier efficace :

- Est un ingrédient essentiel pour la réalisation d'un milieu de travail sain pour les infirmières;
- Influence et contribue à une organisation et à une collectivité saines;
- Est influencé par la culture organisationnelle, les valeurs et les ressources de soutien;
- Est façonné par les ressources personnelles et le caractère unique de chacun;
- Est influencé par les politiques et les contextes socioculturels et professionnels.

# Sommaire des recommandations

| | RECOMMANDATION |
|---|---|
| Recommandations relatives à la pratique de leadership transformationnel | 1. Les leaders en soins infirmiers utilisent la pratique de leadership transformationnel pour développer et maintenir des milieux de travail sains. |
| | 1.1 Les leaders en soins infirmiers établissent des rapports et des liens de confiance. |
| | 1.2 Les leaders en soins infirmiers créent un milieu de travail habilitant. |
| | 1.3 Les leaders en soins infirmiers créent une culture qui appuie le développement des connaissances et l'intégration. |
| | 1.4 Les leaders en soins infirmiers dirigent et maintiennent le changement. |
| | 1.5 Les leaders en soins infirmiers équilibrent les valeurs et les priorités contradictoires. |
| Recommandations relatives aux soutiens organisationnels | 2. Les organismes de services de santé* soutiennent le leadership infirmier efficace. |
| | 2.1 Les organismes de services de santé font preuve de respect envers les infirmières en tant que professionnelles et envers leur contribution aux soins. |
| | 2.2 Les organismes de services de santé respectent les infirmières en tant qu'individu. |
| | 2.3 Les organismes de services de santé offrent des occasions de développement professionnel, d'avancement et de leadership. |
| | 2.4 Les organismes de services de santé appuient une culture de responsabilisation afin de permettre aux infirmières d'être responsables de leur pratique. |
| | 2.5 Les organismes de services de santé offrent un accès aux systèmes d'information et d'aide à la décision ainsi qu'aux ressources nécessaires dans le cadre des soins aux patients. |
| | 2.6 Les organismes de services de santé favorisent et appuient les relations de collaboration. |
| | 2.7 Les organismes de services de santé établissent des champs de responsabilité et de responsabilisation qui permettent des pratiques de leadership infirmier. |
| | 2.8 Les organismes de services de santé disposent d'un plan stratégique pour le développement du leadership infirmier. |
| Recommandations relatives aux ressources personnelles | 3. Les leaders en soins infirmiers développent continuellement leurs ressources personnelles pour un leadership efficace. |
| | 3.1 Les leaders en soins infirmiers font preuve d'une forte identité professionnelle en soins infirmiers. |
| | 3.2 Les leaders en soins infirmiers réfléchissent au sujet de leurs qualités de leadership individuelles et les développent. |
| | 3.3 Les leaders en soins infirmiers sont responsables de la croissance et du développement de leur propre expertise en leadership et agissent à titre de mentors pour développer une expertise en leadership. |
| | 3.4 Les leaders en soins infirmiers cultivent les soutiens professionnel et personnel. |

* Les recommandations relatives aux organismes de services de santé sont la responsabilité de l'équipe principale, y compris le comité, la direction générale et le leader principal en soins infirmiers.

# Sommaire des recommandations – suite

| | RECOMMANDATION |
|---|---|
| Recommandations relatives au système *Gouvernements* | **4. Les gouvernements préparent des politiques et offrent des ressources afin de soutenir le leadership efficace.** |
| | 4.1 Les gouvernements établissent un poste de leader principal en soins infirmiers qui joue un rôle de conseiller en politiques auprès de toutes les provinces et de tous les territoires. |
| | 4.2 Les gouvernements établissent un mécanisme de liaison national pour ces rôles. |
| | 4.3 Les gouvernements mettent sur pied un conseil consultatif en soins infirmiers dans toutes les provinces et dans tous les territoires. |
| | 4.4 Les gouvernements mettent en œuvre un programme de recherche en leadership infirmier et le maintiennent. |
| Recommandations relatives au système *Chercheurs* | **5. Les chercheurs collaborent avec les gouvernements, les établissements d'enseignement et les organismes de services de santé afin de mener des recherches en leadership infirmier.** |
| | 5.1 Les chercheurs étudient les répercussions du leadership infirmier sur les infirmières, les patients et les résultats organisationnels et du système. |
| | 5.2 Les chercheurs développent, mettent en œuvre et évaluent une intervention de leadership basée sur le modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership. |
| | 5.3 Les chercheurs effectuent des recherches sur la planification des ressources humaines en santé pour les rôles de leadership infirmier. |
| | 5.4 Les chercheurs mènent des recherches sur l'enseignement et le développement du leadership infirmier. |
| Recommandations relatives au système *Organismes d'agrément* | **6. Les organismes d'agrément des services de santé et les établissements d'enseignement intègrent dans leurs normes les recommandations de soutien organisationnel contenues dans cette ligne directrice.** |
| Recommandations relatives à la formation | **7. Les programmes de formation offrent des possibilités de développement du leadership, formelles ou non, pour les infirmières.** |
| | 7.1 Les programmes de leadership infirmier intègrent des concepts clés du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership infirmier. |
| | 7.2 Les programmes de leadership infirmier offerts dans le cadre de l'enseignement universitaire au premier et cycle et au deuxième cycle, ainsi que dans les programmes de formation continue, incluent des possibilités formelles ou non d'expérience en leadership. |

# Sources et types de données probantes sur le développement et le maintien du leadership infirmier

## Sources des données probantes

Les résultats de la recherche de données probantes dans la documentation sur le leadership ont permis de trouver des métaanalyses, des études corrélationnelles descriptives, des études qualitatives et des opinions d'expert, mais peu d'études contrôlées. Cela correspond parfaitement au défi que représente le fait de mener des études contrôlées en établissements et ressemble à un récent examen de la documentation sur le leadership infirmier[G] mené par Patrick et White[50]. Même si ce document est rédigé à l'intention des infirmières de tous les milieux, la majorité des études trouvées ont été menées dans des hôpitaux en région urbaine. Les études menées dans d'autres milieux, notamment les soins de santé communautaires et ceux de longue durée, ont été incluent dans cette ligne directrice selon leurs disponibilités et leur pertinence; toutefois, il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches dans ces milieux de pratique.

### Sources comprises

- Une étude méthodique de la documentation sur le leadership jusqu'en décembre 2003 menée par le *Joanna Briggs Institute* (JBI) d'Australie.

  Le JBI a suivi un processus de sept étapes, dont la première est une recherche générale des termes et la mise en place d'un protocole, ainsi qu'une recherche plus approfondie des termes pour l'examen, validés par le président du comité. Grâce au processus de recherche, les études déterminées comme pertinentes à l'examen, selon leur titre et leur résumé, ont été relevées et leur pertinence a été évaluée à nouveau. Les études qui respectent les critères d'inclusion ont été regroupées selon le type d'étude (p. ex., qualitative, expérimentale) et ont été évaluées en vertu de leur qualité méthodologique par deux évaluateurs indépendants au moyen d'instruments d'évaluation cruciaux, choisis selon le type d'étude, à partir d'un ensemble d'instruments. Les instruments utilisés font partie intégrante du *System for Unified Management, Assessment and Review of Information*, un logiciel spécialement conçu pour gérer, évaluer, analyser et synthétiser les données (consultez l'annexe C pour obtenir plus de détails et pour connaître les résultats généraux de l'examen).

- Un compte rendu de la documentation sur le leadership de janvier 2004 à juillet 2005 mené par le comité en utilisant les mêmes critères de recherche et bases de données que lors de l'examen du JBI.

  L'évaluation de la pertinence des études précisées par le processus de recherche, selon leur titre et leur résumé, a été effectuée par une infirmière bachelière. Ces choix ont été validés par le président du comité. Ces études ont été extraites et leur pertinence a été évaluée de façon approfondie. On a retenu les études qui traitaient du leadership en soins infirmiers et si elles visaient des populations semblables d'équipes indépendantes ou de travailleurs de disciplines liées au savoir, ainsi que les études portant sur des relations basées sur les différents types de leadership. Les études jugées pertinentes ont été évaluées par l'infirmière bachelière pour leur qualité, à l'aide de méthodes, d'instruments, d'échantillons,

d'analyses et de conclusions en accord avec les constatations et la clarté de l'étude. Un sommaire des résumés, des constatations et des recommandations concernant l'inclusion ou l'exclusion des études pour la ligne directrice a été confirmé par le comité.

- De la documentation supplémentaire précisée par les membres du comité dont la pertinence et la qualité ont été examinées par les membres du comité.

## Classement des données probantes

La pratique actuelle dans le domaine de la création de lignes directrices pour la pratique exemplaire demande que les données probantes[51] soient qualifiées. Les systèmes courants de classement des données probantes considèrent les études méthodiques des essais contrôlés à répartition aléatoire comme l'exemple idéal[52]. Toutefois, ce ne sont pas toutes les questions pertinentes qui relèvent de ces méthodes, particulièrement si les sujets ne peuvent être répartis de façon aléatoire ou si les variables pertinentes existent déjà ou sont difficiles à isoler. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la recherche comportementale et organisationnelle au cours de laquelle les études contrôlées sont difficiles à concevoir en raison des structures et des processus organisationnels en perpétuel changement. Les professionnels de la santé ne se préoccupent pas seulement des relations de cause à effet : ils reconnaissent une vaste gamme d'approches permettant de générer la connaissance de la pratique. Les données probantes contenues dans le présent document ont été classées selon une adaptation des niveaux de la preuve traditionnels, utilisés par *Cochrane Collaboration*[53] et la ligne directrice du *Scottish Intercollegiate Guidelines Network*[54]. Une partie de cette adaptation comprend l'emploi de l'expression « type de données probantes » plutôt que « niveau » conformément à la nature et au sujet complets de cette ligne directrice.

### Tableau 1: Système de classement des données probantes

| Type de données probantes | Description |
|---|---|
| **A** | Données probantes tirées d'études contrôlées et de méta-analyses |
| **A1** | Étude méthodique |
| **B** | Données probantes tirées d'études corrélationnelles descriptives |
| **C** | Données probantes tirées d'études qualitatives |
| **D** | Données probantes tirées d'opinions d'experts |
| **D1** | Études d'intégration |
| **D2** | Comptes rendus |

*« Les directeurs devraient chercher des données probantes historiques provenant de recherches en gestion et à les mettre en pratique, comme le font leurs collègues cliniques. »*

*(traduction) Institute of Medicine* [48]

# Relatives à la pratique du leadership

| 1.0 | Les leaders en soins infirmiers utilisent la pratique de leadership transformationnel pour développer et maintenir des milieux de travail sains. |
|---|---|

**Les styles de leadership transformationnel et relationnel entraînent :**

- **Une amélioration de la satisfaction des infirmières[55-66]**
- **Une amélioration de la qualité de vie des leaders[56, 64, 66]**
- **Une amélioration de la qualité de vie des infirmières[67]**
- **Une augmentation de la responsabilisation des infirmières[62, 68, 69]**
- **Une réduction de l'absentéisme[70]**
- **Une augmentation de l'engagement envers l'organisation[57, 60, 70-72]**
- **Une augmentation du maintien en poste des infirmières[65, 70, 73, 75]**
- **Une augmentation de l'efficacité de l'unité[55, 63, 75]**
- **Une augmentation de la capacité à diriger différents effectifs[75]**
- **Une amélioration de la santé émotionnelle du personnel[64] et une réduction du taux d'épuisements professionnels des employés[76]**
- **Une amélioration de la qualité de vie des patients[76]**
- **Une amélioration de la satisfaction des patients[76]**
- **De meilleurs résultats chez les patients (notamment une baisse de l'utilisation de moyens de contention, un nombre moindre de fractures, une faible prévalence des complications causées par l'immobilité[77])**

## Discussion sur les données probantes[4]

Kemerer [78] a observé que ce qui importe, ce sont les comportements des leaders en soins de santé au-delà de leurs compétences, c'est-à-dire ce qu'ils disent et font en interaction avec les autres afin d'atteindre des résultats. Les infirmières (à la fois membre du personnel et leaders formels) montrent une préférence pour les styles de leadership axés sur les relations et les comportements compatibles avec le leadership transformationnel[64, 79-82]. Une étude portant sur les infirmières superviseures, menée en Ontario dans un établissement de soins de longue durée, a fait état de conclusions semblables. Le personnel non réglementé supervisé à la fois par les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées en plus des superviseurs eux-mêmes, a rapporté être plus satisfait et moins stressé au travail lorsqu'il se sent appuyé par leurs superviseurs[83].

Le type de leadership le plus souvent signalé dans les hôpitaux qui attire et retient le personnel infirmier est le leadership transformationnel[82]. Dans le cadre d'une étude qui intègre la documentation, Gasper[84] a découvert que ce style de leadership générait un niveau d'efficacité organisationnelle plus élevé et que les comportements influençaient les autres à agir de façon semblable dans un effet de cascade. Il a découvert

[4] Type de données probantes
Des données probantes de type « A » appuient l'établissement des rapports et d'une confiance en

que les personnes qui travaillent avec des leaders transformationnels avaient un plus grand sentiment d'appartenance et une meilleure stimulation intellectuelle. Le leader transformationnel était considéré comme plus accessible et les interactions étaient perçues comme étant de meilleure qualité.

Burns[85] a été la première personne à définir le style de leadership basé sur les relations auquel on réfère maintenant communément sous le nom de *leadership transformationnel.* Pielstick[86] a présenté une métaethnographie de la documentation portant sur le leadership transformationnel qui englobait les 20 années suivant la publication de Burns en 1978. L'œuvre publiée rassemble six domaines : la *communication* (écoute, établissement des attentes), la *création de relations interactives* (respect, gentillesse et soutien, prise de décision participative, gestion des conflits), la *communauté* (établissement d'une culture d'appartenance grâce à des relations basées sur des valeurs telles que la dignité, l'honnêteté, l'équité[G] et l'intégrité) et l'*encadrement* (possibilités d'apprentissage, modèles, mentorat, encadrement, raisonnement moral, planification stratégique et promotion du travail d'équipe); ils s'appuient tous sur une solide fondation de traits personnels (équité fondée sur les principes, intégrité, respect, passion et engagement envers l'apprentissage) afin de partager une vision. Levasseur[87] a effectué une métaanalyse des principales études de recherche portant sur le leadership transformationnel qui comprend 7 études expérimentales et 27 études corrélationnelles et confirme les relations positives entre le leadership transformationnel, l'amélioration du rendement et une hausse du degré de satisfaction du personnel.

Les styles de leadership transformationnel ont été liés à des résultats satisfaisants pour les infirmières[52]. Même si peu d'études examinent le rôle du leadership infirmier et les résultats auprès des patients[50], de plus en plus de preuves démontrent un lien entre la satisfaction des infirmières, ainsi que la pratique des soins infirmiers et l'amélioration des résultats auprès des patients[88].

D'après notre étude de la documentation, nous avons déterminé les cinq pratiques de leadership suivantes qui entraînent des résultats sains pour les infirmières, les patients, les organisations et les systèmes :

- établir des rapports et des liens de confiance;
- créer un milieu de travail habilitant;
- créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances;
- diriger et maintenir le changement;
- équilibrer les valeurs et les priorités contradictoires.

Nous avons lié chacune de ces pratiques de leadership à des comportements précis provenant de notre étude de la documentation.

> *« Il est important pour les leaders de modeler les valeurs par l'action, la communication ouverte, le fait d'être présente et d'utiliser la prise de décision participative. »*
>
> *(Traduction) Baird & St-Amand*[89]

## 1.1 Les leaders en soins infirmiers établissent des rapports et des liens de confiance.

**La confiance envers les leaders et les relations positives avec les leaders entraînent :**

- **Une perception accrue de la crédibilité du leader[71]**
- **Une satisfaction accrue des infirmières[90]**
- **Une baisse du taux d'épuisement affectif[90,91]**
- **Une perception accrue de la qualité des soins et du caractère adéquat de la dotation[90]**
- **Une augmentation de l'engagement envers l'organisation[71,90,92,93]**
- **Un meilleur rendement au travail,[91] une plus grande motivation et une meilleure volonté de travailler fort[70]**
- **Une réduction de l'absentéisme[71]**
- **Une réduction de l'intention de roulement[90, 92,94, 95]**
- **Une amélioration des résultats financiers[95]**
- **Une capacité à diriger différents effectifs[96]**

### Discussion sur les données probantes[5]

*« La confiance est la motivation humaine la plus importante. Elle permet de faire ressortir le meilleur de chaque personne. »*

*(Traduction) Stephen Covey [97 p. 178]*

La croyance voulant que l'établissement de la confiance soit une condition nécessaire à la réussite du leadership règne depuis au moins quatre décennies[92]. La confiance, l'équité et le respect sont des valeurs clés qui mènent à des organisations saines[32]. La confiance est grandement reliée aux styles de leadership transformationnel[92]. Le respect de la valeur d'autrui et l'équité sont des valeurs fréquemment mentionnées comme des traits de caractère des leaders transformationnels[79] et ont été liées à la confiance[98]. Lorsque les infirmières se sentent respectées, elles sont plus satisfaites; elles ont davantage confiance en la direction; elles souffrent moins d'épuisement professionnel, elles prodiguent des soins de meilleure qualité et la répartition du personnel est plus adéquate [90].

Shea[99] a observé que les soins de santé sont dans un état d'activité intense constant et que la confiance et les relations sont nécessaires dans les moments où il y a beaucoup d'ambiguïté, d'incertitude et de complexité. Les changements organisationnels affectent les bonnes relations de travail qui sont essentielles au bon déroulement des activités.

La confiance appuie les bonnes relations interpersonnelles[90, 100]. L'établissement de la confiance a été mis en relation avec les *capacités, l'influence perçue et l'intégrité* du leader et la mesure selon laquelle le leader *prouve que les intérêts des autres lui tiennent à cœur*[86], y compris la volonté d'aider les autres à croître sur le plan professionnel et personnel[100].

---

b Type de données probantes

Des données probantes de type « A » appuient l'établissement des rapports et d'une confiance en tant qu'élément essentiel des pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences essentielles et tous les comportements types ont été extraits d'une gamme de données probantes de niveau A à D, dont la majorité sont de type C et D.

Les infirmières s'identifient beaucoup à leur profession et la confiance envers les leaders reflète souvent le degré auquel le leader fait preuve d'engagement envers les valeurs des soins infirmiers[101]. Rousseau et Tijorwala[102] ont découvert que les infirmières soutenaient moins les changements organisationnels qu'elles croient engendrés par des raisons financières ou politiques, comparativement aux améliorations apportées aux soins des patients, et acceptaient davantage les changements lorsqu'elles avaient confiance en leur leader.

Des données probantes indiquent qu'il n'y a pas que les comportements individuels des leaders qui sont importants : la culture, le climat et les valeurs de l'organisation[90] jouent également un rôle. Une étude menée en 1995 auprès de neuf organisations repères[G] canadiennes a révélé l'importance des leaders qui transmettaient leurs valeurs par l'action et qui faisaient preuve d'une communication ouverte et d'une prise de décision participative, particulièrement dans les situations de conflit. Chaque organisation reconnaissait l'importance de la compétence chez l'infirmière et conséquemment l'importance d'offrir des programmes de formation afin d'établir des liens de confiance. La présence et l'accès aux leaders ont été désignés comme des éléments importants. Les conclusions de cette étude démontrent que l'établissement de la confiance n'est pas un processus simple ou rapide; il découle plutôt du fait d'être axé sur le client et sur la qualité, ainsi que d'être respectueux envers ses collègues[89].

### Comment perdre la confiance de quelqu'un

- Se contredire dans ses gestes et ses paroles
- Chercher à retirer des bénéfices personnels plutôt que communs
- Dissimuler des renseignements
- Mentir ou dire des demi-vérités
- Avoir l'esprit étroit

Lewicki & Bunker[103]

### Comment rétablir la confiance perdue

- Reconnaître que la confiance a été brisée
- Déterminer le sujet et la cause
- Admettre que cela s'est produit
- En accepter la responsabilité
- Faire amende honorable

Bowman[104]

*« Les leaders les plus efficaces, selon moi, ne disent jamais 'je'». Ce n'est pas parce qu'ils se sont entraînés à ne pas dire 'je'. Ils ne pensent pas 'je' : ils pensent 'nous'; ils pensent 'équipe'. Ils comprennent que leur travail est de faire fonctionner l'équipe. Ils acceptent les responsabilités et ne s'y dérobent pas, mais 'nous' en retirons le mérite... C'est ce qui crée la confiance, ce qui permet d'accomplir une tâche. »*

*(traduction) Peter Drucker[105 p. 14]*

## Tableau 1.1 Compétences essentielles[G] et comportements types[G] pour établir des rapports et des liens de confiance

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.1.1 Les leaders en soins infirmiers font preuve d'intégrité et d'équité et en sont un modèle[71, 81, 84, 87, 94 à 111] | • Ils réfléchissent sur leurs propres valeurs et objectifs et ils les partagent ouvertement[87, 94, 106 117 à 120]<br>• Ils définissent des normes de rendement élevées et claires[71, 87, 89, 100, 121]<br>• Ils assument leurs responsabilités et admettent ouvertement leurs erreurs[112 118]<br>• Ils respectent leurs engagements[58, 81, 100, 122]<br>• Ils font preuve d'un comportement éthique en tout temps[32, 94, 102, 106, 107]<br>• Ils recueillent des données et examinent les problèmes sous tous leurs angles[81]<br>• Ils préparent des politiques et des pratiques explicites et transparentes et les appliquent méthodiquement[122] |
| 1.1.2 Les leaders en soins infirmiers font preuve d'attention[84, 92, 108, 122,] de respect, [9, 32, 84, 106, 122] et d'intérêt envers les autres[32, 81, 84, 106, 113, 124, 125] | • Ils cherchent et reconnaissent les multiples points de vue et opinions[100, 107, 120, 122, 124, 126]<br>• Ils écoutent sans juger ou critiquer[124]<br>• Ils cherchent à comprendre ce qui importe aux autres[100, 117] et y réagissent comme il convient[32]<br>• Ils partagent ouvertement et honnêtement[82, 127] leur connaissance des enjeux du système, des points de vue[112] et des problèmes[58]<br>• Ils reconnaissent la valeur des autres et célèbrent leurs réussites[71, 81, 106, 112, 122, 128, 129]<br>• Ils développent et mettent en œuvre des politiques et des processus qui font la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être des infirmières.<br>• Ils respectent l'équilibre vie professionnelle-personnelle[81, 130, 121] et en sont un modèle. |
| 1.1.3 Les leaders en soins infirmiers créent un sentiment de présence et d'accessibilité[81, 82, 113, 117, 129, 129 à 131] | • Ils communiquent fréquemment[101, 125, 132] et assurent un contact personnel.<br>• Ils demeurent visibles et accessibles aux autres[82, 89, 117, 123, 127] |
| 1.1.4 Les leaders en soins infirmiers communiquent efficacement. | • Ils communiquent clairement, ouvertement, honnêtement et fréquemment[58, 113 à 115]<br>• Ils écoutent de façon interactive[82, 129, 132] et font preuve de compréhension envers les opinions des autres[100, 107, 117, 126]<br>• Ils développent et utilisent leurs capacités lors de communications interculturelles[13] |
| 1.1.5 Les leaders en soins infirmiers gèrent les conflits de façon efficace[74, 79, 101, 105, 119] | • Ils comprennent les effets constructifs et dévastateurs des conflits.<br>• Ils reconnaissent et traitent les conflits<br>• Ils développent et utilisent une gamme d'aptitudes de résolution de conflits[133] |
| 1.1.6 Les leaders en soins infirmiers bâtissent des relations de collaboration et encouragent le travail d'équipe[70, 82, 106, 111, 123, 128, 133 à 135] | • Ils cherchent et reconnaissent la participation de tous[95, 101, 114]<br>• Ils reconnaissent la légitimité des intérêts des autres[118] et discutent de la concordance des intérêts[122, 136]<br>• Ils explorent les incertitudes et les peurs[137]<br>• Ils forgent le consensus[G83, 137]<br>• Ils donnent et reçoivent de l'aide et de l'assistance[118]<br>• Ils évaluent l'efficacité du travail en collaboration[138] |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.1.7 Les leaders en soins infirmiers font preuve de passion et de respect envers la profession infirmière, ses valeurs[120] ses connaissances et ses réussites[36, 38, 81, 82, 100, 113, 123, 127, 129, 139] | • Ils font preuve d'un engagement exceptionnel envers les soins, la justice, l'honnêteté, le respect et l'intégrité[112].<br>• Ils préconisent les soins et les milieux de pratique de qualité[36, 38, 81, 82, 94, 112, 134, 140] et donnent la priorité aux patients[112, 140]<br>• Ils reconnaissent et encouragent la contribution des infirmières envers les patients, les organisations et les communautés[36, 81, 82, 100, 126, 140]<br>• Ils expriment clairement et avec assurance les questions touchant les soins infirmiers.<br>• Ils appuient le développement des connaissances en soins infirmiers |
| 1.1.8 Les leaders en soins infirmiers prouvent qu'ils sont compétents dans leur rôle[95, 120, 141] | • Ils entretiennent et appliquent les connaissances actuelles en sciences infirmières, en leadership et toutes autres connaissances[124, 131]<br>• Ils abordent les préoccupations et les problèmes[81, 87, 100, 130, 134, 142]<br>• Ils participent activement aux occasions de prise de décision.<br>• Ils prennent la responsabilité des gestes et des résultats.<br>• Ils communiquent les réussites afin d'insuffler la confiance[83, 122] |

## Planifier le succès – Suggestions de stratégies pour établir des rapports et des liens de confiance

### Stratégies individuelles

- Adopter une politique de « porte ouverte » et afficher les moments de disponibilité.
- Pratiquer la gestion en se promenant[127, 130, 143,] en passant du temps au sein de l'unité.[58, 144]
- Faire le point lors de réunions et de tribunes afin d'entendre les problèmes et les inquiétudes, de découvrir ce qui se passe dans la vie des gens dans le but d'encourager les relations et d'offrir un soutien.[145]
- Communiquer l'appui au personnel en déterminant et en clarifiant ce que le personnel attend des leaders.[146]
- Fournir une rétroaction sans cérémonie continue pour le travail bien fait.
- Bâtir un réseau de conseillers et d'informateurs qui fourniront un point de vue honnête et objectif lors de la recherche de renseignements et de conseils.[147]

### Stratégies à l'échelle de l'équipe, de l'unité, de l'organisation

- Créer un énoncé de vision et de valeurs collectif pour l'équipe, l'unité, l'organisation[120] et collaborer avec l'équipe afin de développer des normes de comportement qui reflètent cette vision.
- Concevoir des descriptions de rôles claires et accessibles, y compris celles du leadership.
- Concevoir des grilles de responsabilité détaillant les obligations et les niveaux de responsabilité (p. ex., participation comparativement à prise de décision[148]).
- Évaluer régulièrement le rendement.
- Concevoir des guides d'entrevue pour l'embauche de candidats à des postes de leadership qui intègrent les questions relatives au respect des individus et à la valeur des soins infirmiers.
- Mettre en place des programmes de reconnaissance formels tels que des certificats, des articles dans des bulletins mettant en vedette des infirmières qui ont fait preuve d'excellence dans leur pratique; des certificats de reconnaissance ou des événements de remises de prix tenus dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers afin de reconnaître les réussites.
- Mettre sur pied un conseil pour étudier et préparer des stratégies sur les questions touchant le recrutement et le maintien en poste, comme l'équilibre vie professionnelle-personnelle.
- Intégrer une formation sur les habiletés d'empathie aux programmes de développement du leadership.[125]

## Apprendre à gérer les conflits

- Encourager un libre échange des idées, des sentiments et des attitudes afin de cultiver une atmosphère de confiance.
- Clarifier les problèmes au sujet des valeurs, des objectifs et des buts.
- Se concentrer sur ce qui est possible, plutôt que sur ce qui est incorrect[149].
- Chercher des façons différentes de résoudre le problème.
- Étudier l'utilisation de l'interrogation appréciative.
- Demander de l'aide auprès de sources externes, si nécessaire.
- Établir des façons d'évaluer les solutions possibles.

## 1.2 Les leaders en soins infirmiers créent un milieu de travail habilitant.

**L'habilitation dans le milieu de travail entraîne :**

- **Une amélioration de la satisfaction des infirmières au travail**[150 à 156]
- **Une meilleure santé mentale professionnelle**[68, 151, 157 à 162]
- **Des perceptions accrues de l'autonomie et du contrôle des pratiques en soins infirmiers**[91, 152, 153, 162, 163]
- **Une plus grande motivation du personnel**[164, 165]
- **Une appréciation et un respect accrus envers le leader**[100]
- **Une augmentation de l'engagement envers l'organisation**[159, 165 à 171]
- **Un meilleur rendement et une meilleure efficacité au travail**[68, 153, 162, 165, 170, 172]
- **Un taux de maintien en poste plus élevé**[155, 166, 173 à 176]
- **De meilleurs résultats pour les patients**[44]

### Discussion sur les données probantes[viii]

La nécessité de créer et de maintenir des milieux de travail sains pour les infirmières est un sujet courant dans la documentation au sujet du leadership infirmier[155, 173 à 175] et il a été lié à la confiance[150]. On croit que l'habilitation se produit lorsqu'une organisation fait participer son personnel et répond progressivement à cet engagement en démontrant un intérêt et une intention mutuels à favoriser la croissance. L'habilitation est une façon d'être qui se produit avec le temps[177]. Elle part du principe que des facteurs tels que les caractéristiques organisationnelles et la culture sont plus utiles que les facteurs de personnalité lorsqu'il est question de comprendre les attitudes individuelles et l'efficacité au travail[151]. Le degré d'habilitation et de satisfaction au travail est directement lié aux circonstances vécues par l'employé au travail[151, 155].

L'habilitation est une combinaison de conditions organisationnelles et de style de leadership. Les structures sociales du milieu de travail influencent les attitudes et les comportements des employés[178]. Les facteurs structurels du milieu de travail tel que le fait d'avoir *accès à l'information, de recevoir du soutien, d'avoir accès aux ressources nécessaires pour faire le travail et d'avoir la chance d'apprendre et de grandir* sont le

viii Type de données probantes

Des données probantes de type A appuient la création d'un milieu de travail habilitant en tant qu'élément essentiel des pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences essentielles et les comportements types ont été extraits d'une gamme de données probantes de niveau A à D, dont la majorité sont de type B et C.

fondement de l'habilitation[178]. Manojlovich[179] a découvert une relation étroite et forte entre les perceptions des infirmières en ce qui concerne la capacité de leur gestionnaire à mobiliser les ressources nécessaires et l'habilitation qui résulte du fait d'avoir accès à ses ressources. L'étude a démontré qu'il existe un lien entre l'habilitation et l'amélioration de la pratique, lequel est affecté par les croyances des infirmières en leurs propres capacités lorsqu'un solide leadership infirmier est présent. Cette relation n'est pas présente lorsque le leadership infirmier est considéré faible.

Skelton Green[180] a découvert que les infirmières membres d'un comité d'hôpital ont fait état d'une plus grande satisfaction au travail et d'une baisse du roulement de l'effectif infirmier. Erickson et coll.[177] ont rapporté que le degré d'habilitation était plus élevé chez les infirmières membres d'un comité de gouvernance. Beaulieu et coll.[167] ont étudié l'habilitation et l'engagement du personnel infirmier et des gestionnaires des soins infirmiers dans deux établissements de soins prolongés en Ontario. Ils ont découvert que les gestionnaires qui participaient à l'étude étaient considérablement plus habilités et engagés envers leur organisation que les infirmières soignantes. Ils ont fait état d'un accès adéquat à l'information, au soutien et aux ressources. Dans une étude portant sur les gestionnaires des soins infirmiers en Finlande, Suominien et coll.[181] ont découvert une relation plutôt importante entre l'habilitation et de faibles niveaux de stress.

Les leaders transformationnels en soins infirmiers permettent l'habilitation[182, 183] en partageant leur vision et leurs valeurs dans le cadre d'un dialogue continu avec les infirmières. L'habilitation se produit lorsque la vision et les directives sont claires. Les leaders en soins infirmiers habilitent les autres en les motivant à partager la vision et à en faire une réalité[184]. Habiliter les leaders donne un but et une signification au travail des membres du personnel en valorisant les soins infirmiers et en créant un accès aux structures de pouvoir formelles et non formelles.

On a découvert que les *pouvoirs formels et non formels* sont des indices significatifs de l'accès aux structures d'habilitation en milieu de travail1[52, 154, 168, 183]. Les rôles de prise de décision discrétionnaire, de visibilité et de pertinence au sein de l'organisation permettent l'acquisition de *pouvoirs formels. Les pouvoirs non formels* naissent des alliances politiques et des interactions avec les pairs[178]. Les alliances avec les pairs, les supérieurs et les subordonnés au sein de l'organisation influencent davantage l'habilitation[174].

Les leaders habilités créent les conditions structurelles nécessaires à l'efficacité au travail et à l'habilitation en désignant des rôles qui permettent de prendre part à la prise de décision de même qu'en maximisant l'autonomie et la croissance personnelle et professionnelle du personnel[178]. Le personnel habilité a été associé aux améliorations en ce qui a trait à l'approche vis-à-vis de la clientèle, à la qualité des produits et des services, à la concurrence organisationnelle et à la qualité de vie au travail[159].

> *« Mon but personnel est d'offrir aux infirmières les outils dont elles ont besoin pour bien faire leur travail. Je ne m'occupe pas des patients : elles s'en occupent. Mon travail est de prendre soin d'elles afin qu'elles puissent prendre soin des patients. »*
>
> *(Traduction) Upenieks*[109 p. 630]

## Tableau 1.2 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu de travail habilitant

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.2.1 Les leaders en soins infirmiers comprennent et mettent en pratique les concepts et les principes des comportements habilitants. | • Ils ont un regard critique sur l'utilisation personnelle de comportements habilitants.<br>• Ils cherchent à obtenir une rétroaction sur leurs propres comportements.<br>• Ils partagent les pouvoirs avec les autres. |
| 1.2.2 Les leaders en soins infirmiers maximisent les occasions d'autonomie et de croissance personnelle et professionnelle des infirmières. | • Ils créent un milieu d'apprentissage qui permet la pratique réflexive[G] et le partage des responsabilités.<br>• Ils démontrent de la confiance envers les autres en déléguant de façon efficace[58, 81, 100, 119, 134, 185].<br>• Ils encadrent, agissent à titre de mentor et guident[38, 80, 81, 134, 136, 186].<br>• Ils donnent, de façon constructive, autant de rétroaction négative que positive [118, 121, 129].<br>• Ils utilisent l'expérience comme une possibilité d'apprentissage[134, 187, 188].<br>• Ils favorisent le développement des connaissances, des aptitudes et du jugement[81, 84, 100, 113, 124, 128, 131, 187].<br>• Ils offrent des expériences afin de développer leur jugement, la prise de risque et l'innovation[109, 189].<br>• Ils préparent des politiques et des processus qui permettent l'élargissement du champ d'activité de la pratique[57]. |
| 1.2.3 Les leaders en soins infirmiers maximisent l'accès aux données et aux renseignements nécessaires pour fonctionner efficacement[109] et favorisent leur mise en pratique. | • Ils partagent la vision et les valeurs personnelles de même que la vision et les valeurs organisationnelles[87, 94, 100, 106, 113 à 116, 119].<br>• Ils partagent l'information au sujet des initiatives en cours et des plans futurs[109, 127].<br>• Ils appliquent de façon critique les connaissances fondées sur la théorie et la recherche en soins infirmiers[36, 109, 126, 134].<br>• Ils favorisent le développement, le partage et l'application des connaissances et des stratégies fondées sur les données probantes[38, 126, 190].<br>• Ils partagent l'expertise et facilitent l'accès à l'expertise des autres[48]. |
| 1.2.4 Les leaders en soins infirmiers créent les conditions propices pour que les infirmières aient accès aux soutiens, à la rétroaction et aux conseils des supérieurs, des pairs et des subordonnés et qu'elles les mettent en pratique. | • Ils cherchent à comprendre les styles de pensée, d'apprentissage et de travail d'autrui[80, 126].<br>• Ils adaptent les styles de leadership aux individus et aux situations[80, 113, 191].<br>• Ils créent des structures et des processus qui permettent les interactions.<br>• Ils soutiennent les infirmières affectées par des expériences ou des événements survenus au travail. |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.2.5 Les leaders en soins infirmiers facilitent l'accès des infirmières aux ressources comme les documents, l'argent, les fournitures, l'équipement, leur permettent de les mettre en pratique de manière adéquate et leur donnent le temps nécessaire pour remplir leur rôle. | • Ils minimisent les contraintes bureaucratiques afin d'accéder aux ressources[42, 94, 109, 192].<br>• Ils écartent les obstacles à l'atteinte des résultats[81].<br>• Ils offrent et utilisent l'aide budgétaire, la formation[193], le temps et les outils d'aide à la décision nécessaires afin d'atteindre les buts et les objectifs[38, 81, 109, 113, 119, 123, 134].<br>• Ils établissent des mécanismes afin de contrôler et d'obtenir des charges de travail raisonnables.<br>• Ils répondent aux priorités et aux besoins changeants. |
| 1.2.6 Les leaders en soins infirmiers renforcent la signification du travail infirmier. | • Ils promeuvent la contribution des soins infirmiers en ce qui a trait aux résultats pour les patients et l'organisation[36, 81, 100, 109].<br>• Ils conçoivent des rôles dans le cadre desquels la prise de décision discrétionnaire et la visibilité sont pertinentes aux processus organisationnels clés[178].<br>• Ils créent l'accès au réseau d'alliances tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. |
| 1.2.7 Les leaders en soins infirmiers permettent aux autres de participer à la prise de décision[94, 100, 113, 177, 180, 194, 195]. | • Ils sollicitent la participation générale des autres[94, 100, 113].<br>• Ils créent des structures et des processus qui permettent de participer à la prise de décision.<br>• Ils respectent les décisions en y apportant leur soutien[194]. |

## Planifier le succès – Stratégies suggérées pour créer un milieu de travail habilitant

### Stratégies individuelles

- Réfléchir au moyen d'un journal personnel.
- Chercher à obtenir une rétroaction détaillée afin de comprendre comment les autres perçoivent les comportements.
- Étudier la documentation sur le leadership transformationnel.
- Embaucher un accompagnateur professionnel ou trouver un mentor et le rencontrer régulièrement.

### Stratégies à l'échelle de l'équipe, de l'unité

- Établir des rôles de leadership formel et non formel à l'échelon de la pratique, tels que les ressources cliniques ou le chef de projet.
- Faciliter la rotation des rôles de responsabilité.
- Permettre la participation des infirmières aux conférences et aux comités sur les soins aux patients.
- Permettre l'accès aux programmes d'aide aux employés, aux groupes de soutien, aux groupes de discussion après un incident.
- Offrir des possibilités de croissance qui permettent l'apprentissage et la visibilité, par exemple assister aux réunions du conseil d'administration ou du comité[196] ou à des cours et des conférences sur le développement du leadership.
- Organiser des groupes de discussion afin de partager les expériences et les stratégies de leadership.
- Bâtir la croyance d'autrui en leurs capacités grâce à des programmes d'orientation, à de la formation axée sur les compétences, à un modèle à suivre et à de la rétroaction positive[179].
- Mettre sur pied des équipes d'amélioration de la qualité afin de répondre aux préoccupations du personnel.
- Partagerles données probantes des soins infirmiers relatives aux résultats positifs pour les soins aux patients.
- Partager les données sur la charge de travail valides et fiables et agir conformément.
- Prévoir régulièrement des déjeuners d'affaires et des réunions pause-café avec le gestionnaire, le directeur ou le vice-président.
- Tenir des séances de discussion ouvertes[197].
- Effectuer régulièrement des évaluations du rendement et mettre sur pied un processus d'évaluation par les pairs.

### Stratégies à l'échelle de l'organisation

- Simplifier les structures et les processus de prise de décision.
- Considérer la complexité du travail, la diversité des groupes de travail et le nombre de personnes au moment de déterminer le ratio infirmière-leader pour la composition des groupes de travail.
- Établir des structures et des processus de gouvernance partagés tels que des conseils de pratique des soins infirmiers et des conseils d'unité afin de régir le champ de pratique des infirmières[198].
- Nommer des infirmières soignantes aux comités d'examen des produits.
- Communiquer le travail des comités de pratique des soins infirmiers au moyen de bulletins, de discussions ouvertes[144], de technologies offertes sur le Web.
- Offrir une diversité de programmes de formation, de soutien et de responsabilisation à toutes les infirmières.
- Mettre sur pied des programmes de mentorat et de préceptorat[198].
- Offrir des externats aux infirmières-stagiaires.
- Offrir des internats aux nouveaux diplômés et aux infirmières expérimentées.

## 1.3 Les leaders en soins infirmiers créent une culture qui appuie le développement des connaissances et l'intégration.

**Créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances entraîne :**

- **Une amélioration de la satisfaction des infirmières au travail[160, 107, 199]**
- **Une augmentation de l'efficacité au travail[107, 155, 200]**
- **Une habilitation[113, 171, 199] et une autonomie[113] accrues**
- **Une meilleure qualité de la pratique et des soins ainsi qu'une responsabilisation[107] accrue**
- **Un plus grand progrès sur les plans personnel et professionnel pour les membres du personnel[124, 131, 201] et du leadership clinique[38]**
- **Un plus grand désir de poursuivre la formation[81]**
- **De meilleures relations au sein du personnel[100]**
- **Une confiance accrue envers le leader[170, 188] et l'organisation[186]**
- **Une hausse du taux de réussite des changements prévus[119, 193]**
- **Un plus grand engagement envers l'organisation[107]**
- **Une diminution de l'intention de quitter[128, 199]**

### Discussion sur les données probantes[7]

L'acquisition continue et la gestion des connaissances ont été définies comme des caractéristiques intrinsèques des organisations à haut rendement[186]. Les organisations apprenantes possèdent l'aptitude d'acquérir et de diffuser des connaissances tout en modifiant les comportements de façon à refléter les nouvelles connaissances[186, 187]. Senge[202] définit une organisation apprenante comme « un endroit où les employés peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats voulus, où des modes de pensée novateurs et créatifs sont mis au point, où les aspirations collectives ont libre cours, où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble » (traduction, p. 3). Afin que cela se produise, les organisations doivent découvrir la façon d'utiliser l'engagement des gens et leur capacité à apprendre, et ce, à *tous* les niveaux.

Dans une étude portant sur les hôpitaux, Tucker et Edmondson[170] ont clairement démontré l'influence des comportements de leadership sur la volonté à signaler les erreurs. Les leaders transformationnels affectent considérablement les valeurs d'apprentissage organisationnelles en créant une atmosphère d'ouverture et de sécurité psychologique, deux facteurs essentiels à l'apprentissage organisationnel efficace[170, 203]. La création d'un apprentissage organisationnel exige d'abord un engagement organisationnel envers l'apprentissage par l'intermédiaire de l'établissement d'un milieu propice à la création, au partage et à l'utilisation des connaissances[186, 204]. DeLong et Fahey[186] ont étudié la façon dont 24 entreprises ont amorcé et géré des projets liés aux connaissances. Leur étude a permis de découvrir que la culture façonnait les hypothèses concernant l'importance des connaissances, définissait les relations entre les niveaux de connaissances, créait un contexte d'interaction sociale et façonnait la création et l'adoption de nouvelles connaissances. La première étape consistait à évaluer les différents aspects de la culture les plus

b Type de données probantes

Des données probantes de type B appuient la création d'un milieu de travail qui appuie le développement et l'intégration des connaissances en tant qu'élément essentiel des pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences essentielles et tous les comportements types ont été extraits d'une gamme de données probantes de niveau B à D, dont la majorité sont de type C et D.

susceptibles d'influencer les comportements liés aux connaissances, notamment les attitudes à l'égard de la propriété des connaissances, les changements nécessaires afin de favoriser l'utilisation plus collective des connaissances et les modèles de communication internes. Donaldson et Rutledge[204] ont examiné six projets entrepris afin de mettre l'accent sur l'utilisation et la diffusion de la recherche en soins infirmiers. Parmi les facteurs qui influencent la capacité à adopter de nouvelles connaissances dans le cadre de la pratique, on trouve la participation à la formation professionnelle continue, l'accès à l'information et à la documentation, le temps consacré à la recherche et la disponibilité des collègues possédant une éducation supérieure afin de faciliter la transformation des connaissances[204].

Les organisations apprenantes profitent de toutes les sources de connaissances, notamment la créativité interne, les experts au sein de l'organisation, les pratiques exemplaires des autres organisations et les experts externes. La recherche systématique de nouvelles connaissances et la mise à l'essai s'effectuent au moyen d'une méthode scientifique afin de générer des gains progressifs sur le plan de l'accès aux connaissances[188]. Les connaissances se propagent rapidement et efficacement dans toute l'organisation. Les idées qui ont le plus de répercussions sont largement partagées et transférées dans plusieurs directions afin d'améliorer l'application, notamment les rapports écrits et verbaux et les programmes d'enseignement et de formation. La motivation à créer, à partager et à utiliser les connaissances est un indicateur de succès essentiel accru par les mesures incitatives à long terme liées à l'évaluation générale et à la structure salariale de l'organisation[190].

Les établissements de santé importants prennent des décisions en se basant sur des données probantes qui ne sont pas recueillies ou évaluées de façon systématique[205]. Comme l'indique Berwick[206], mesurer aide à savoir si une innovation précise doit être conservée, modifiée ou rejetée. Cependant, la plupart des organisations ne donnent que peu de temps à la réflexion sur le travail. Les coopératives de gestion basées sur les données probantes existent afin de créer les organisations au niveau du système de santé qui rassemblent les gestionnaires, les conseillers et les chercheurs autour de la mission commune d'améliorer la gestion des soins de santé, les bases de données et le rendement organisationnel. Une équipe de professionnels est réunie afin de mieux comprendre les problèmes qu'occasionne la gestion des soins de santé et de préparer des approches plus efficaces pour la gestion des systèmes de santé. Cela crée une culture basée sur les données probantes qui appuie et encourage l'innovation, l'expérimentation, la collecte et l'analyse des données, ainsi que le développement de techniques d'évaluation critique chez les gestionnaires[207].

> *« Afin d'avoir confiance, les infirmières doivent continuellement apprendre. Pour un professionnel, cela signifie faire progresser sa pratique grâce à une formation professionnelle continue, à de la recherche, ainsi qu'à la participation à des conférences professionnelles et nationales. La recherche est extrêmement importante afin que la profession d'infirmière demeure professionnelle. »*
>
> *(Traduction) Upenieks[109 p 630]*

Tableau 1.3 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.3.1 Les leaders en soins infirmiers favorisent les normes et les pratiques qui appuient la participation générale au développement, au partage et à la diffusion des connaissances. | • Ils cultivent un milieu de travail qui encourage activement l'innovation et l'évaluation[189].<br>• Ils favorisent les occasions de penser et d'apprendre[170].<br>• Ils encouragent le partage, entre les infirmières, de l'expertise clinique et du leadership.<br>• Ils donnent aux employés l'occasion d'évaluer les systèmes de travail actuels et d'en concevoir de nouveaux[170].<br>• Ils encouragent et appuient la conduite de la recherche en soins infirmiers.<br>• Ils encouragent et appuient le développement et l'utilisation de lignes directrices basées sur les données probantes[208, 209].<br>• Ils reconnaissent la valeur des différents modes de production et de mise en œuvre des connaissances.<br>• Ils harmonisent des mesures incitatives afin de renforcer et de faciliter la mise en œuvre des pratiques de gestion des connaissances[190].<br>• Ils gèrent la croissance personnelle en défiant de façon objective les comportements et les croyances[136]. |
| 1.3.2 Les leaders en soins infirmiers offrent une infrastructure technique, informationnelle et éducative pour appuyer l'apprentissage[82, 189, 190, 210]. | • Ils appuient le perfectionnement et l'apprentissage professionnel continus[189, 211].<br>• Ils créent des partenariats organisationnels qui facilitent la formation continue.<br>• Ils cherchent des experts, tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur[212], et ils font appel à leurs connaissances.<br>• Ils donnent accès à une variété de documents et de renseignements[209].<br>• Ils encouragent l'utilisation d'outils d'aide à la décision. |
| 1.3.3 Les leaders en soins infirmiers créent un milieu de communication ouverte et de travail d'équipe qui valorise la contribution des autres[189]. | • Ils examinent les modèles de communication interne[186].<br>• Ils reconnaissent les différences culturelles en matière de communication et l'influence que les perceptions de la hiérarchie ont sur la communication.<br>• Ils encouragent la résolution de problème collective[36, 186].<br>• Ils établissent des structures et des processus afin d'encourager la discussion des problèmes ou des idées[189].<br>• Ils favorisent la circulation de l'information et des idées à divers échelons au moyen de pratiques formelles et non formelles.<br>• Ils mettent les réussites en évidence. |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.3.4 Les leaders en soins infirmiers insufflent une approche d'apprentissage pour une amélioration continue de la qualité[G]. | • Ils fournissent une rétroaction efficace[38, 81, 113, 124, 134, 136, 187].<br>• Ils expriment clairement, examinent d'un œil critique, produisent et valident les connaissances à partir d'une réflexion critique sur la pratique[206, 213].<br>• Ils inspirent la pensée créatrice.<br>• Ils engagent la direction et le personnel dans l'amélioration de la qualité des soins et assurent une attribution efficace des ressources[189].<br>• Ils permettent aux infirmières d'agir.<br>• Ils insufflent un sentiment fort de responsabilité personnelle en matière de contrôle de la qualité.<br>• Ils accordent du temps pour discuter et aborder les causes sous-jacentes aux problèmes.<br>• Ils utilisent la réflexion critique pour produire et valider des connaissances. |
| 1.3.5 Les leaders en soins créent des mécanismes afin d'assurer un contrôle continu des changements et des processus organisationnels. | • Ils favorisent l'utilisation de mesures de rendement à l'égard des soins infirmiers et des résultats auprès des patients dans le cadre d'analyses comparatives[189].<br>• Ils appuient l'engagement du personnel de première ligne en matière d'analyses comparatives et de préparation de pratiques exemplaires[189, 199].<br>• Ils utilisent les cadres de données et de qualité lors du contrôle et de la prise de décision.<br>• Ils étudient les pratiques exemplaires des autres organisations et professions[214].<br>• Ils suivent de près les résultats des changements et établissent des mécanismes de responsabilité.<br>• Ils font un compte rendu et consignent les réussites et les échecs organisationnels passés[167]. |

## Planifier le succès — Stratégies suggérées pour créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances

### Stratégies individuelles

- S'engager personnellement au moyen de perfectionnement personnel continu par l'étude de recherches, d'articles de revue pertinents et par la participation à des conférences.
- Diriger des discussions sur des articles de recherche, des études de cas et des expériences cliniques dans le cadre de réunions d'équipe.
- Conduire et mettre en commun des résultats de recherche afin de résumer les observations sur des sujets de clinique et de gestion choisis[207].
- Mettre sur pied des tables rondes ou des groupes de discussion sur des sujets comme le leadership et les expériences[207].
- Défier votre propre apprentissage en écrivant un article à publier ou en présentant une conférence.

### Stratégies à l'échelle de l'équipe, de l'unité

- Mettre sur pied des conseils et des équipes d'amélioration de la qualité.
- Établir des équipes de projets interprofessionnelles afin de favoriser l'apprentissage et la communication[186].
- Encourager la mise en commun des renseignements en prévoyant des réunions d'équipe[215] régulières; en tenant des discussions ouvertes, des conférences et des réunions[186, 188].
- Favoriser la mise en commun de l'expertise interprofessionnelle au sein des visites d'unité.
- Encourager le personnel à poursuivre son perfectionnement professionnel grâce à un horaire flexible et à des rencontres favorisant l'échange de résumés de documentation.
- Encourager le personnel à écrire un article de groupe à publier ou à présenter une conférence.
- Effectuer une évaluation des besoins et préparer un régime d'enseignement pour l'unité.
- Instaurer l'utilisation de plans d'apprentissage annuels.

### Stratégies à l'échelle de l'organisation

- Offrir l'accès aux services de bibliothèque, à Internet et aux moteurs de recherche[209].
- Offrir un soutien pour les frais de scolarité et des politiques d'horaires flexibles afin de permettre la formation professionnelle continue.
- S'associer avec des programmes universitaires afin d'offrir des cours sur place et s'engager dans des projets de recherche coopérative[216].
- Tenir régulièrement des groupes de discussion et effectuer des sondages de façon à faire un suivi des processus et des résultats de la pratique infirmière[212].
- Créer des processus disciplinaires pour le signalement des erreurs et des accidents évités de justesse.
- Utiliser les lignes directrices pour la pratique exemplaire.
- Créer ou modifier les outils de mesure de la charge de travail afin d'allouer du temps à la réflexion et à l'apprentissage.
- Intégrer la participation à la recherche aux descriptions des rôles et à la planification stratégique des soins infirmiers[216] et la mettre à profit.
- Mettre sur pied un comité de recherche en soins infirmiers et s'engager à utiliser les données probantes et la recherche des comités existants[216].
- Publier un rapport annuel des soins infirmiers ou un bulletin détaillant les réussites des infirmières.
- Développer et offrir un libre accès à un rapport sur les soins infirmiers de qualité qui rassemble des données sur les indicateurs qui tiennent compte des infirmières[217].

## 1.4 Les leaders en soins infirmiers dirigent et maintiennent le changement.

**Le leadership efficace dans le cadre de la gestion des changements entraîne :**

- **Une meilleure acception des changements par les employés**[102, 115, 218, 219]
- **Une hausse du taux de réussite des changements souhaités**[71, 81, 193, 211]
- **Des équipes plus perfomantes**[64, 71, 107, 220]
- **Un meilleur rendement**[71, 107]
- **Une baisse du taux d'absentéisme**[71, 107]
- **Un plus grand engagement envers le travail**[102, 115, 218, 219]
- **Un plus grand engagement envers l'organisation**[60, 107]
- **Une augmentation de la motivation du personnel et une plus grande volonté à travailler fort**[60, 107]
- **Une plus grande satisfaction à l'égard du travail**[60, 64, 107, 220]

### Discussion sur les données probantes[8]

Les leaders en soins infirmiers jouent un rôle clé dans la mise en œuvre réussie des changements au sein des organisations. Dans une étude canadienne portant sur les effets de la restructuration des hôpitaux, les infirmières ont rapporté moins d'effets négatifs lorsqu'elles avaient l'impression que leurs leaders utilisaient un style démocratique basé sur les relations[64]. Une étude menée aux États-Unis par Gullo et Gerstle[69] a démontré que lorsque les gestionnaires intermédiaires affichaient des caractéristiques de leadership transformationnel pendant la restructuration, les infirmières autorisées avaient rapporté un sentiment d'habilitation supérieur à la moyenne[G]. Ils n'ont découvert aucun lien entre le style transformationnel et la satisfaction au travail pendant la restructuration et ont suggéré la nécessité de mener d'autres études sur la façon de guider les infirmières lors des changements. Une étude portant sur les équipes hospitalières effectuée par Gil et coll., en Espagne[220], a permis de découvrir que le leadership orienté vers le changement (styles de leadership transformationnel et charismatique) est fortement corrélé à la satisfaction au travail et au rendement de l'équipe, et influençait la confiance de l'équipe en sa propre efficacité.

Le processus de changement commence par le leader en soins infirmiers qui développe une vision pour le changement dérivée d'une évaluation rapide du milieu. Le leader en soins infirmiers défie les suppositions, les structures et les processus existants au sein de l'organisation[71, 81, 99, 221, 222]. Une vision est développée puis mise en commun avec les autres intervenants[G] afin de rassembler la masse critique de soutien pour le changement[129, 211, 223].

Un changement réussit lorsque les leaders en soins infirmiers engagent le personnel en offrant des structures et en donnant l'occasion de prendre part à toutes les phases du processus de changement[200, 224]. Les leaders qui démontrent un engagement sincère envers le changement[222, 225] et donnent l'exemple en matière de prise de risque et d'innovation, sont davantage en mesure d'atteindre les buts du changement[71, 81, 211].

Un corps de recherche souligne la nécessité d'une communication continue à tous les échelons de l'organisation[48, 102, 115, 225]. La communication ouverte peut entraîner l'acception des changements par les

employés et une hausse de l'engagement envers le travail[102, 115, 218, 219]. Les stratégies de communication efficaces incluent la sollicitation de rétroaction auprès des employés et de leurs perceptions par rapport au changement[115, 224, 226]. L'information doit être mise en commun de façon à être pertinente au contexte unique aux différents individus de tous les échelons de l'organisation[81, 125]. Le besoin d'information inclut la communication des buts mesurables et des rapports d'étape de façon périodique[119].

Strebel[193] suggère que les leaders sous-estiment souvent les besoins d'apprentissage nécessaires pour appuyer le changement. Si les ressources, les possibilités et le moment sont bien négociés, il est plus probable que la qualité et l'efficacité des services seront maintenues[119, 136, 225]. Les ressources nécessaires pour atteindre les buts de l'initiative de changement devraient concorder avec l'ampleur des changements prévus à la pratique, au processus ou à la culture[119, 222]. Les employés sont davantage en mesure d'accepter les changements lorsque les leaders en soins infirmiers établissent une confiance et offrent un soutien continu[227] en étant présents et visibles à l'échelon où le changement se produit[99], et en écoutant et en répondant aux émotions et aux réactions du personnel[228, 229]. Afin que le changement entre en vigueur et soit maintenu, il faut disposer de stratégies pour sceller la nouvelle initiative au sein des opérations continues de l'organisation.

### Tableau 1.4 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu qui appuie le développement et l'intégration des connaissances

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.4.1 Les leaders en soins infirmiers créent une vision commune du changement continu en collaboration avec les intervenants et les experts[38, 71, 107, 211, 221]. | • Ils réfléchissent sur les attitudes personnelles et les aptitudes en ce qui concerne le changement et la gestion du changement.<br>• Ils questionnent le statu quo et défient les suppositions, les valeurs, les structures et les processus[71, 81, 221].<br>• Ils étudient le milieu afin de déterminer les changements qui se produisent à l'extérieur de l'organisation[99, 128] en matière de démographie et de politiques.<br>• Ils recueillent activement des renseignements qui supposent de nouvelles approches[222].<br>• Ils appliquent les données probantes aux initiatives de changement.<br>• Ils établissent des liens avec des partenaires pouvant contribuer à élargir la pensée et les approches utilisées au sein de l'organisation[222]. |
| 1.4.2 Les leaders en soins infirmiers engagent les autres en partageant la vision de changement continu. [38, 71, 96, 107, 221] | • Ils bâtissent des relations et des partenariats stratégiques[128].<br>• Ils établissent des coalitions porteuses de changement[220] en accumulant suffisamment d'appuis au sein d'une masse critique de personnes[99].<br>• Ils transforment le changement causé par une crise en une occasion de changement plutôt qu'une menace[222].<br>• Ils démontrent un engagement envers le changement[228, 231]. |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.4.3 Les leaders en soins infirmiers font participer les intervenants et les experts à la planification, à la conception et à la modification du changement. | • Ils cherchent à obtenir la participation du personnel et du syndicat tôt dans le processus.<br>• Ils rassemblent des personnes de différents niveaux afin de parler des buts communs et de s'assurer qu'ils concordent[221].<br>• Ils font participer au processus les personnes touchées par le changement[64, 230, 231].<br>• Ils définissent clairement les comportements attendus.<br>• Ils engagent les intervenants à s'approprier le changement[224].<br>• Ils identifient les personnes qui appuient, qui influencent et qui embrassent le changement[222].<br>• Ils font preuve de respect et de reconnaissance envers l'expertise et les talents individuels qui ont contribué au changement[224].<br>• Ils encouragent la croyance selon laquelle les changements peuvent être accomplis et créent une occasion de possibilité[86].<br>• Ils encouragent le fait de considérer la prise de risque et l'innovation et ils en donnent l'exemple[71, 81, 123, 134, 211, 222].<br>• Ils examinent les leçons apprises indépendamment des résultats. |
| 1.4.4 Les leaders en soins infirmiers négocient l'aide budgétaire nécessaire pour les processus éducatifs[136, 193, 226], l'aide à la décision et les autres ressources nécessaires à l'atteinte des buts de l'initiative de changement[113, 119]. | • Ils investissent le temps et les ressources nécessaires au changement ainsi qu'aux changements connexes afin de créer le changement de culture, de stratégie, de processus et de politique[222].<br>• Ils quantifient les nouveaux besoins en matière de connaissances et les exigences en matière de comportement afin d'appuyer le changement[193].<br>• Ils mettent en œuvre les possibilités d'apprentissage afin de répondre aux besoins en matière de connaissances à différents moments. |
| 1.4.5 Les leaders en soins infirmiers offrent une communication continue tout au long du processus de changement. | • Ils interprètent les questions en matière de soins infirmiers afin de communiquer efficacement avec les individus au sein de chaque contexte (p. ex., clinique, exécutif, académique et politique)[81, 125] et de les influencer.<br>• Ils tiennent régulièrement à jour les divers intervenants[218, 219].<br>• Ils incluent des renseignements concernant les facteurs économiques et politiques qui motivent le changement[225].<br>• Ils offrent des renseignements appropriés afin d'aider la prise de décision pendant le changement.<br>• Ils présentent des rapports sur les progrès en cours en ce qui concerne l'initiative de changement[225]. |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.4.6 Les leaders en soins infirmiers développent et mettent en œuvre des mécanismes de rétroaction, de mesure et de modification en cours de changement[119, 232]. | • Ils définissent les buts mesurables et les mécanismes de suivi des progrès[119, 231].<br>• Ils sollicitent la rétroaction et les perceptions des employés en ce qui concerne le changement, formellement et informellement[115, 224, 226].<br>• Ils dosent les changements planifiés et établissent les priorités des activités modifiées afin d'allouer suffisamment de temps à l'adaptation[115].<br>• Ils créent des occasions de rétroaction (formelle ou non) et ils utilisent des techniques d'écoute active.<br>• Ils négocient et modifient légèrement les solutions aux problèmes qui surgissent au cours du processus de changement.<br>• Ils écartent les obstacles à l'atteinte des résultats et assument la responsabilité des résultats[80].<br>• Ils développent des plans d'urgence afin de gérer les défis inattendus au projet de changement.<br>• Ils gèrent les conflits pouvant être engendrés par le changement.<br>• Ils abordent les conflits de rôles et l'ambiguïté et discutent de la façon dont les rôles et les responsabilités changeront[115, 233].<br>• Ils revoient les tactiques et modifient le projet de changement selon les résultats et la rétroaction à toutes les phases de l'initiative de changement.<br>• Ils célèbrent l'atteinte de jalons[115, 222]. |
| 1.4.7 Les leaders en soins infirmiers appuient, encadrent et agissent à titre de mentor auprès d'autrui afin de réussir la mise en œuvre du changement. | • Ils établissent des liens de confiance et offrent du soutien afin d'accroître l'action collective par rapport au changement[227].<br>• Ils évitent la surenchère et la surcompensation.<br>• Ils disent la vérité au sujet des ambivalences personnelles, des réserves et de l'engagement envers le changement[99].<br>• Ils restent près de l'expérience des partisans, à proximité de l'endroit où les changements ont lieu[99]. |
| 1.4.8 Les leaders en soins infirmiers soutiennent la motivation vis-à-vis de l'initiative de changement, et ce, à toutes les étapes du changement[234]. | • Ils mettent la nouvelle initiative en œuvre au sein des opérations continues[119].<br>• Ils évaluent les problèmes et les activités continus du leader et du partisan et déterminent le moment où une intervention est nécessaire[99].<br>• Ils parlent honnêtement du changement – les choses ne vont pas se « tasser » puisque d'autres changements sont toujours à venir[99]. |

## Planifier le succès – Stratégies suggérées pour diriger et maintenir le changement

### Stratégies individuelles

- Comprendre et reconnaître que l'intérêt pour le changement varie d'une personne à l'autre.
- Travailler avec les collègues des ressources humaines, des finances et de l'amélioration de la qualité afin d'obtenir l'accès aux données nécessaires au suivi des résultats du changement.
- Effectuer une analyse des intervenants afin de déterminer qui peut promouvoir ou freiner le changement[99, 223].
- En apprendre davantage sur l'opinion de chaque intervenant et sur ce que le changement signifie pour elle ou lui.[23].
- Être patient et ouvert aux occasions de progrès du changement[235].
- Développer un réseau de soutien afin de maintenir l'énergie personnelle tout au long du processus de changement[236].

### Stratégies à l'échelle de l'équipe, de l'unité

- Engager les infirmières à bâtir une vision.
- Partager à la fois la vision et les tactiques du changement en organisant des discussions ouvertes et en utilisant la technologie[236].
- Bâtir la confiance de l'équipe en sa capacité à gérer le changement au moyen de formation axée sur les compétences pour les nouvelles tâches, le travail d'équipe[220] et en se concentrant sur les forces.
- Discuter des initiatives semblables qui ont échoué pour déterminer ce qui aurait pu être fait différemment[236].

### Stratégies à l'échelle de l'organisation

- Communiquer régulièrement en utilisant diverses méthodes et stratégies[102, 115, 231].
- Lier les plans de changement aux objectifs stratégiques de l'organisation[231].
- Planifier des stratégies de communication telles que des bulletins, des réunions, des discussions ouvertes et des réunions individuelles entre le personnel et les leaders, tout au long du processus de changement[119].
- Consulter le personnel et le syndicat tôt et souvent.
- Offrir des ateliers de gestion du changement qui abordent les habiletés de délégation et de gestion[119], de même que la promotion du travail d'équipe[115, 136].
- Utiliser les manuels de mise en œuvre[236] tout au long du processus afin d'accroître la constance[234].
- Utiliser les données d'évaluation des sondages menés auprès des employés afin de faire un suivi des processus et des résultats et de prendre des décisions éclairées[231].

### Aider les autres à faire face aux effets du changement

- Écouter leurs préoccupations et être compréhensif plutôt que de porter des jugements.
- Aborder les préoccupations personnelles et professionnelles des individus.
- Se concentrer sur l'événement et sur les émotions qui y sont associées.
- Aider les individus à s'approprier ces sentiments et ne pas les dépersonnaliser en les intellectualisant.
- Verbaliser la confiance envers le fait que l'action de l'individu est possible et l'aider à développer un sentiment de confiance et d'espoir[230].
- Offrir de l'encouragement et des remerciements en envoyant une carte ou des fleurs[235].

## 1.5 Les leaders en soins infirmiers équilibrent les valeurs et les priorités contradictoires.

**Équilibrer les valeurs contradictoires et les priorités entraîne :**

- **Une réduction du stress pour les infirmières**[237]
- **Une meilleure perception de leur valeur**[127, 130, 136, 238] **et de leur image**[239, 240]
- **Une meilleure satisfaction des infirmières et leurs leaders**[130, 136, 218]
- **Une réduction du désengagement envers le travail**[240, 241]
- **Une diminution de l'intention de quitter l'organisation ou la profession**[239, 242, 243]
- **Une confiance accrue envers les leaders**[130, 136]

### Discussion sur les données probantes[9]

Les infirmières et leurs leaders doivent souvent faire face à une vaste gamme de priorités et de demandes contradictoires, y compris les besoins des individus, des familles, des professionnels et de l'ensemble de l'organisation[239, 244]. En fin de compte, il faut choisir ce qui doit avoir la préséance et le plan d'action à suivre. Cela peut créer un dilemme éthique pour les infirmières et les leaders en soins infirmiers, particulièrement lorsque les décisions sont influencées par les attentes professionnelles, la politique organisationnelle et les structures de pouvoir hiérarchiques. Splane et Splane[245] ont constaté que les infirmières qui occupent des rôles de haut niveau en politique étaient mises au défi de façon semblable par des « considérations contradictoires » (traduction, p. 158). Posner, Kouzes et Schmidt[246] ont découvert que la congruence des valeurs entre les gestionnaires et leur organisation était liée à la perception du succès personnel, de l'engagement envers l'organisation et le comportement éthique, et créait un climat de discussion des problèmes fondée sur les valeurs.

La société des infirmières croit au fait d'offrir les meilleurs soins à chacun des patients[247] et en la valeur de leurs connaissances professionnelles afin de contribuer aux résultats positifs pour les patients. Lageson[248] a découvert un important lien entre l'objectif du gestionnaire de première ligne qui consiste à répondre aux besoins des patients et le besoin de satisfaction au travail des infirmières. Le manque de congruence entre les valeurs et les croyances des infirmières et les valeurs et les décisions organisationnelles peuvent mener à une détresse éthique[G249].

Équilibrer les coûts et la qualité des soins, comme c'est le cas avec la dotation et la rationalisation des ressources, est un problème majeur pour les leaders en soins infirmiers[112, 127, 140, 189, 238, 239, 242]. On s'attend à ce que les leaders en soins infirmiers parlent au nom de la profession et fassent respecter ses valeurs, préconisant à la fois les patients et le personnel, en dépit des compressions budgétaires[36, 38, 94, 100, 134, 113, 187]. Lorsque les infirmières ont l'impression que l'organisation et ses leaders accordent davantage d'importance à la réduction des coûts qu'à la prestation de soins de qualité, il en résulte une baisse de la confiance envers le leadership, une baisse de la satisfaction au travail[127, 130, 136, 218], une hausse du stress[237], une diminution de la perception de la valeur, une baisse de la loyauté envers l'organisation et une augmentation de l'intention de quitter[127].

Les relations avec les médecins, les administrateurs et les autres membres de l'équipe de soins de santé peuvent être une source de conflit dans les organisations où un traitement de faveur est accordé aux médecins et où il y a un manque de respect envers les infirmières et leurs connaissances. Le soutien au dialogue franc[140, 250], de la gouvernance de l'organisation[239], est aussi important que plusieurs des problèmes liés aux relations.[244]

Les valeurs et les croyances peuvent varier également un peu au sein de l'équipe de soins infirmiers. De toutes les infirmières autorisées qui travaillaient au Canada en 2002, 6,9 % avaient reçu leur diplôme à l'étranger[251]. Les infirmières appartenant à différentes générations et à différents contextes ethnoculturels ont une éthique de travail et des attitudes différentes[110]; elles doivent cependant travailler ensemble en tant qu'équipe unie afin d'atteindre des résultats positifs pour les patients[112]. Cronkhite[238] a découvert que les leaders en soins infirmiers qui s'identifient aux patients et aux infirmières vivaient davantage de conflits dans leurs relations avec l'échelon supérieur de l'organisation et que ceux qui étaient perçus comme des porte-parole organisationnels vivaient davantage de conflits avec les infirmières plus jeunes.

Le rôle du leader en soins infirmiers est de promouvoir et de créer un milieu de pratique qui équilibre les demandes et les perspectives multiples afin que les infirmières puissent offrir des soins de qualité. On dit des leaders transformationnels qu'ils ont une grande considération morale[252]. On s'attend à ce que les leaders en soins infirmiers soient des « repères moraux », soulevant des préoccupations[140] lorsque des demandes contradictoires sont susceptibles d'avoir un effet négatif sur la qualité des soins des patients. Ils doivent d'abord réfléchir sur leurs propres valeurs[112, 140, 239, 241, 250] avant de pouvoir reconnaître les valeurs et l'éthique sous-jacentes aux situations et de s'occuper de façon efficace du problème[250]. Il est essentiel d'obtenir de l'information et d'évaluer la situation[112, 127, 253] puisque de nombreux problèmes tirent leur origine du contexte[244]. Storch[140] décrit l'importance de savoir quand s'arrêter, de comprendre quand poursuivre et quand se retenir.

Communiquer la raison des actions choisies, jouer un rôle actif afin de s'assurer d'avoir les ressources nécessaires[250] et de faire un suivi des effets de la décision font partie du rôle de leader. Les leaders aident les autres à voir les situations non seulement comme un choix entre deux opposés, mais plutôt comme des décisions entre ces choix qui doivent être optimisées avec le temps en modifiant la démarche et l'action au besoin. Par exemple, de temps en temps, les leaders en soins infirmiers peuvent décider d'affecter des ressources aux postes d'infirmière enseignante afin d'aider les infirmières à améliorer leur pratique; d'autres moments, ils peuvent choisir d'ajouter des postes de soins directs.

## Tableau 1.5 Compétences essentielles et comportements types pour équilibrer les valeurs et les priorités contradictoires

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.5.1 Les leaders en soins infirmiers définissent et reconnaissent les valeurs et les priorités[112, 140, 239, 240, 250]. | • Ils se servent de la clarification des valeurs afin de déterminer leurs propres valeurs, celles des autres et de l'organisation[110, 112, 140, 238, 239, 253].<br>• Ils séparent les valeurs personnelles des responsabilités professionnelles[239].<br>• Ils partagent et communiquent clairement la vision, les valeurs et les priorités[38, 87, 110, 112, 238, 255].<br>• Ils définissent un processus pour définir les valeurs et la vision des soins infirmiers au sein d'une organisation[140].<br>• Ils comprennent que les valeurs évoluent avec le temps en réponse aux expériences de la vie[256]. |
| 1.5.2 Les leaders en soins infirmiers reconnaissent et intègrent les nombreuses perspectives à la prise de décision[112, 253-255]. | • Ils réunissent de l'information provenant de sources multiples.<br>• Ils utilisent des outils d'aide à la décision[136].<br>• Ils définissent et communiquent les valeurs qui sont à la base de la décision[112].<br>• Ils font preuve de sensibilité face aux pressions multiples, notamment les finances, le pouvoir et la politique[253].<br>• Ils déterminent les conséquences de mettre l'accent sur une perspective plus que sur une autre[250, 255].<br>• Ils utilisent les connaissances cliniques et professionnelles au moment de la prise de décision[112, 257].<br>• Ils déterminent les problèmes éthiques et moraux[140].<br>• Ils savent quand parler et quand se taire[140, 129]. |
| 1.5.3 Les leaders en soins infirmiers aident les autres à comprendre les points de vue et les décisions contradictoires. | • Ils reconnaissent et nomment les points de vue contradictoires[140, 254, 255] et définissent leurs interdépendances[254].<br>• Ils aident les autres à clarifier les valeurs et à exprimer leurs valeurs et opinions[112, 140, 239, 249].<br>• Ils comprennent que la diversité culturelle influence les points de vue.<br>• Ils discutent de la raison pour laquelle une personne est choisie plutôt qu'une autre[255].<br>• Ils créent le partage de la responsabilisation et forgent des liens de collaboration[112, 134, 253-255].<br>• Ils aident les autres à comprendre les aspects commerciaux des soins de santé[112].<br>• Ils se familiarisent avec les ressources limitées (équipement, personnel) et communiquent l'information. |
| 1.5.4 Les leaders en soins infirmiers emploient des stratégies afin de faire progresser les initiatives prioritaires tout en maintenant les autres initiatives et perspectives importantes. | • Ils développent des pratiques flexibles afin d'être en mesure de répondre aux priorités changeantes[254].<br>• Ils encouragent et récompensent la flexibilité et l'innovation liées au fait d'atteindre un équilibre[254].<br>• Ils se concentrent sur les buts et sur ce qui peut être accomplis[239].<br>• Ils explorent d'autres façons d'aborder les défis[134] comme l'utilisation de la technologie ou la modification[112]. |

| COMPÉTENCES ESSENTIELLES | COMPORTEMENTS TYPES |
|---|---|
| 1.5.5 Les leaders en soins infirmiers recommandent les ressources nécessaires afin d'atteindre les buts et les objectifs[250]. | • Ils fournissent des données pour faire état du besoin de ressources.<br>• Ils fournissent le personnel, le soutien, le temps et l'équipement nécessaires[38, 81, 123, 134, 155].<br>• Ils harmonisent les ressources aux priorités et aux normes professionnelles à long terme[81, 250]. |
| 1.5.6 Les leaders en soins infirmiers font preuve de responsabilité et assument la responsabilité des résultats. | • Ils surveillent les effets des décisions sur les patients et le personnel[130, 253] et sur l'affectation et la qualité des ressources[112, 255].<br>• Ils définissent et surveillent les indicateurs de déséquilibre[254].<br>• Ils identifient les personnes les plus sensibles aux effets[254] négatifs et cherchent à obtenir fréquemment leur rétroaction.<br>• Ils encouragent la responsabilisation d'autrui. |

## Planifier le succès – Stratégies pour équilibrer les valeurs et les priorités contradictoires

### Stratégies individuelles

- Utiliser l'autoréflexion afin de déterminer les valeurs personnelles.
- Utiliser les cadres éthiques pour aider au moment de la clarification et de la prise de décision.
- Se concentrer sur les études de recherche, les données des résultats auprès des patients et la documentation actuelle afin d'appuyer la dotation, les ensembles d'aptitudes et les heures de soin[109].
- Éduquer les membres du conseil d'administration et les autres membres de l'équipe de gestion sur le lien entre les milieux de travail et les résultats des patients, y compris les niveaux de dotation et les résultats des patients[48, 140].
- Former des alliances avec des groupes et des individus aux vues similaires.
- Vérifier la relation entre la philosophie personnelle et les croyances de l'organisation avant d'accepter le rôle[128].

### Stratégies à l'échelle de l'équipe, de l'unité, de l'organisation

- Développer et soutenir une philosophie et un énoncé de mission qui parlent de la valeur des soins infirmiers et placent les patients en tête de liste.
- Établir des modèles de gouvernance partagée afin d'encourager la mise en commun des renseignements et la prise de décision partagée.
- Mettre sur pied des comités d'examen de l'utilisation afin d'aborder la répartition des ressources[258].
- Mettre sur pied des forums de discussion sur les questions d'éthique, y compris les tables rondes, les discussions formelles et non formelles et les comités d'éthique[140, 239, 258, 259].
- Développer des politiques de divulgation[198].

# Recommandations relatives à l'établissement

| 2.0 | Les organismes de services de santé soutiennent le leadership efficace. |
|---|---|

**Parmi les soutiens organisationnels pour un leadership efficace, on trouve[156, 173]:**

- **La culture organisationnelle qui respecte et soutient les soins infirmiers.**
- **L'accès à l'autorité formelle – autorité liée au poste; accès aux ressources, aux renseignements et à l'autonomie de la pratique.**
- **L'accès à l'autorité non formelle – réseaux et relations.**
- **Les possibilités d'avancement – soutien à la croissance et au perfectionnement professionnel et les possibilités de leadership.**
- **Le travail d'équipe respectueux et fait en collaboration.**

## Discussion sur les données probantes[10]

Même si Pearson et coll.[52] ont rapporté qu'il y a un nombre limité de recherches de qualité sur l'effet direct des milieux de travail sur le développement et le maintien du leadership infirmier, il y a des données probantes sur le sujet. Les participants à une étude canadienne menée par Jeans et Rowat[260], qui comptait des infirmières en chef, des gestionnaires et des membres du personnel, ont rapporté que les déclencheurs et les obstacles à l'acquisition des compétences en leadership incluent des milieux de travail favorables, des attentes claires et raisonnables, un équilibre vie professionnelle-personnelle, une charge de travail raisonnable et l'accessibilité aux programmes de formation en gestion.

Certaines recherches ont permis de découvrir des liens entre l'habilitation en milieu de travail et le leadership infirmier efficace[151, 155, 261]. Laschinger et Shamian[234] ont remarqué un solide lien entre la perception qu'ont les infirmières gestionnaires de l'habilitation et l'autoefficacité du leadership.

Dans une étude comparant les leaders en soins infirmiers dans les établissements qui attirent et retiennent le personnel infirmier et dans les autres établissements, Upenieks[82] a défini des facteurs organisationnels précis qui appuient les leaders en soins infirmiers et qui encouragent le leadership clinique en permettant aux infirmières d'utiliser leur expertise, leurs connaissances et leurs aptitudes dans le cadre de soins cliniques. Même si les leaders en soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier et ceux des autres établissements s'entendent sur l'importance de ces soutiens, les leaders en soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier ont rapporté être davantage en mesure de les offrir[155]. De façon similaire, dans une étude menée dans un établissement de soins de longue durée, McGilton et coll.[58] ont découvert que la capacité des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées à utiliser le leadership de soutien était affectée par les soutiens tels que les fournitures, le financement et la dotation, les descriptions de rôle claires, le personnel administratif suffisant et le soutien des cadres supérieurs.

Boyle et Kochinda[262] ont découvert que la perception des médecins et des infirmières en ce qui a trait au leadership infirmier et à la résolution de problèmes entre les groupes augmentait de façon considérable à

la suite d'une intervention qui met à contribution une formation en communication collaborative à laquelle participent les infirmières leaders et les médecins leaders dans une unité de soins intensifs. Krugman[263] a rapporté qu'un climat de gestion participative caractérisé par une prise de décision en groupe, une communication interactive et un contrôle décentralisé améliorait l'image et la conscience professionnelles des leaders en soins infirmiers. Ces soutiens sont compatibles aux éléments de l'habilitation structurelle de Kanter[156] et aux attributs des milieux de pratique professionnelle qui ont été liés aux résultats positifs pour les patients-clients et les infirmières[43, 89, 264].

**2.1** Les organismes de services de santé font preuve de respect envers les infirmières en tant que professionnelles et envers leur contribution aux soins.

## Discussion sur les données probantes[11]

De nombreuses études et plusieurs rapports ont démontré que les infirmières perçoivent un manque de respect dans le milieu de travail[1, 9, 140, 238]. Une marque de respect envers les infirmières et l'équité en milieu de travail ont été liés à l'habilitation[90] et se soldent par de meilleures relations interpersonnelles et en une confiance plus grande envers les leaders[90], améliorant par le fait même l'efficacité des leaders. La contribution des infirmières aux soins aux patients[112], particulièrement celle des cadres supérieurs[64], se traduit par une baisse de l'épuisement affectif, une meilleure santé émotionnelle et le fait d'être davantage en mesure d'être au service des besoins importants des patients.

> *«Les organismes doivent transmettre le message selon lequel 'les infirmières sont l'avantage le plus important, et les soins aux patients sont le résultat le plus important'.*
>
> *(Traduction) Upenieks[81 p. 462]*

Devine et Turnbull[265] ont mené une série de groupes de discussion dans quatre grands centres du Canada où ils demandaient aux infirmières de définir ce qui, pour elles, constitue un milieu respectueux. Voici quelques-uns des nombreux indicateurs mentionnés :

- ne pas s'attendre à ce que les infirmières travaillent « partout », sans tenir compte de leur formation et de leur expérience;
- des niveaux de dotation suffisants qui correspondent à la charge de travail;
- l'inclusion des infirmières dans la prise de décision organisationnelle;
- les infirmières dirigées par des personnes qui ont reçu une formation en soins infirmiers;
- la tolérance zéro en matière d'abus envers les infirmières;
- des possibilités de perfectionnement professionnel.

**Stratégies pour arriver à faire preuve de respect envers les infirmières en tant que professionnelles**

2.1a. **Nommer une infirmière dans un poste de cadre supérieur.**
2.1b. **Embaucher des infirmières en tant que gestionnaires de première ligne.**
2.1c. **Embaucher des leaders en soins infirmiers qui possèdent la formation et les attestations appropriées.**
2.1d. **Appuyer la stabilité du leadership infirmier.**
2.1e. **Reconnaître les contributions des infirmières en ce qui concerne les résultats auprès des patients et de l'organisation.**

## 2.1a Nommer une infirmière dans un rôle de cadre supérieur au niveau de la direction de l'organisation

### Discussion sur les données probantes[12]

Les leaders en soins infirmiers jouent un rôle important dans la conception des systèmes de prestation de soins qui permettent la participation à la prise de décision clinique et organisationnelle, ce qui se traduit par une meilleure pratique et de meilleurs soins aux patients[36, 43]. Les systèmes de prestation qui ne satisfont pas les fournisseurs et les patients ont été définis comme un facteur important dans deux pénuries de personnel infirmier nationales aux États-Unis à la fin des années 1980[36].

De nombreux auteurs et rapports portant sur les soins infirmiers ont recommandé de nommer des infirmières leaders à un poste de leadership au niveau de la direction qui ont la responsabilité des opérations et de la pratique infirmière et qui contribuent au niveau de la gouvernance[1, 36, 48, 123, 266, 267]. Dans la province de Québec, la législation provinciale exige que dans tous les organismes de soins de santé, le poste de directeur des soins infirmiers soit occupé par une infirmière et qu'il y ait un conseil d'infirmières qui relève du conseil d'administration dans chaque établissement qui compte cinq infirmières ou plus[268]. En Ontario, les organismes de gouvernance doivent adopter des règlements qui établissent les procédures pour la nomination d'une infirmière en tant qu'infirmière en chef des soins infirmiers[G] de l'hôpital, ainsi que la fonction et les responsabilités associées à ce rôle[269]. Dans une étude portant sur le progrès des recommandations mentionnées dans le rapport du Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers[1] *Notre santé, notre avenir : un milieu de travail de qualité pour les infirmières canadiennes*, Maslove et Fooks[270] ont rapporté que même si de nombreuses organisations nomment des infirmières aux postes de leadership, ces personnes ne font pas toujours partie de l'équipe de direction générale.

Il a été démontré que le leadership, les ressources suffisantes et le contrôle sur le milieu de pratique sont annonciateurs de la satisfaction au travail et du maintien en poste des infirmières et mènent à des soins de meilleure qualité[271]. La participation d'une infirmière à l'échelon le plus élevé de la prise de décision organisationnelle est une caractéristique des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier et constitue une condition d'admissibilité à l'agrément Magnet[266]. Lorsque l'infirmière qui occupe un poste de cadre supérieur est hautement visible et accessible au personnel, cela encourage la reconnaissance envers le travail des infirmières et leur permet d'exprimer leurs opinions[36]. Le Revised Nursing Work Index Instrument[272], une mesure des caractéristiques des milieux de pratique des soins infirmiers, comprend des

questions sur la présence d'une infirmière en chef supérieure « hautement visible et accessible au personnel » et « dont le pouvoir et l'autorité équivalent à ceux des décideurs de haut niveau de l'hôpital ».

Le rapport de l'Institute of Medicine[48] lie les milieux de travail des infirmières à la sécurité des patients et recommande que les organisations comptent des leaders en soins infirmiers à tous les niveaux de la direction, sur le plan de l'organisation et des soins aux patients. Les auteurs de ce rapport indiquent que même s'ils n'ont pas trouvé de données probantes pour appuyer une structure organisationnelle précise pour le leadership infirmier, ils recommandent « un leadership infirmier clinique bien préparé à la plupart des niveaux de direction supérieurs », (traduction, p. 134). Clifford[36] soutient la nécessité pour une infirmière en chef supérieure d'avoir libre accès aux rôles de leader en soins infirmiers partout dans l'organisation afin d'être en mesure de définir une direction commune pour les soins infirmiers. Le rôle de ce leader est de participer aux décisions administratives, de représenter le personnel infirmier, de faciliter la communication avec les infirmières, de faciliter la participation des infirmières à la conception des processus de travail et du déroulement des opérations et de fournir les ressources nécessaires au soutien des connaissances infirmières et au besoin d'information[48]. Clifford[36] a exprimé le besoin du personnel clinique d'être en mesure de communiquer avec toute l'organisation par l'intermédiaire de l'infirmière qui occupe un poste de cadre supérieur en chef en raison de la perte des services infirmiers traditionnels. Cela est particulièrement vrai dans les organisations qui ont adopté une structure de gestion de programme.

Clifford[36] a constaté que l'infirmière qui occupe un poste de cadre supérieur doit avoir accès aux partenaires appropriés tels que les médecins, le président-directeur général et le directeur financier. Burner[273] a découvert que la présence d'une infirmière en chef des soins infirmiers dans l'organisation a eu un effet sur les relations infirmière-médecin de même que sur la sécurité et la compétence des soins infirmiers. Crossley[274] a rapporté que le niveau de conflit de rôles et d'ambiguïté de rôle a connu une baisse constante chez les leaders en soins infirmiers lorsqu'il y avait un lien étroit avec les instances dirigeantes de l'organisation.

**2.1b** Embaucher des infirmières en tant que gestionnaires de première ligne là où l'accent principal est mis sur la prestation de soins infirmiers.

## Discussion sur les données probantes[13]

Plusieurs rapports ont recommandé qu'une infirmière occupe le poste de gestionnaire de première ligne là où l'accent principal de la prestation des services est d'offrir des soins infirmiers ou lorsque la masse critique de personnel est constituée d'infirmières[1, 9, 123, 267]. Les soins infirmiers sont une discipline de pratique, une profession appuyée par des normes, par une formation de nouveaux praticiens, par la conduite de recherches et par l'application de données probantes. Le leadership dans le contexte des valeurs et des croyances infirmières de base est nécessaire pour appuyer la pratique des soins infirmiers[38]. Nightingale croyait que « seules les personnes formées pour être infirmières sont qualifiées pour diriger ou former d'autres infirmières »[275].

La restructuration et les structures de gestion de programme dans les organisations ont entraîné la disparition des structures infirmières départementales habituelles[38] et identifiables du leader en soins infirmiers. Clifford[36] a découvert que les changements substantiels en cours dans les organisations de soins de santé et les charges de travail considérables ont affecté le personnel clinique qui se tourne vers l'avis des

leaders et vers un leader qui peut surveiller à la fois la qualité des soins et les besoins en perfectionnement du personnel. Il ajoute que lorsque les infirmières gestionnaires se rapportaient à des gestionnaires non cliniques, leur travail était plus complexe puisqu'elles devaient expliquer des aspects de leur rôle à des personnes qui ne possèdent pas de formation clinique. Dans une série de six groupes de discussion effectués dans trois grandes villes canadiennes, les infirmières soignantes ont rapporté que les gestionnaires qui n'œuvrent pas en soins infirmiers ne comprenaient pas ou n'étaient pas conscients de leurs inquiétudes en ce qui concerne les soins aux patients et les problèmes opérationnels[265]. Baumann et coll.[9] ont constaté que sans un leadership professionnel, la mauvaise pratique des soins infirmiers peut passer inaperçue.

**2.1c** Embaucher des leaders en soins infirmiers qui possèdent la formation, l'expérience et les attestations appropriées pour le rôle.

## Discussion sur les données probantes[14]

L'American Association of Colleges of Nursing[267] recommande d'embaucher des personnes pour des rôles de leadership infirmier qui ont une formation et des attestations appropriées (p. ex., agrément requis ou études supérieures préparatoires) nécessaires pour leur rôle. Plusieurs études ont constaté que les leaders en soins infirmiers qui ont fait des études supérieures étaient considérés plus efficaces dans leur rôle[55, 75, 80, 112, 276].

**2.1d** Reconnaître et promouvoir l'importance de la stabilité en soins infirmiers.

## Discussion sur les données probantes[15]

La stabilité du leadership infirmier appuie les relations personnelles, la confiance, la communication ouverte entre les leaders et le personnel de même qu'entre les leaders et leurs collègues[277, 278,] ce qui se traduit par une mise en commun des connaissances[278]. Le pouvoir non formel des leaders en soins infirmiers, qui a été lié à l'habilitation[178] et à l'efficacité du leader en soins infirmiers, provient de la crédibilité et des alliances auprès des membres de l'organisation[109], qui se développent tous deux au fil du temps. Une étude méthodique des études de recherche qui examinaient les effets de la restructuration sur les infirmières a démontré une baisse de satisfaction face au superviseur, causée par les changements au niveau de la relation et une perte de confiance en l'administration[279].

Le roulement fréquent du leadership infirmier au sein de l'organisation est perturbant pour le personnel[280] et est probablement le signe d'un milieu de travail malsain. L'engagement d'une organisation envers la stabilité du leadership indique un engagement envers les soins infirmiers et une confiance de la direction supérieure envers les leaders en soins infirmiers en ce qui concerne la gestion des soins infirmiers. Cet engagement peut être perçu comme un filet de sécurité par les leaders en soins infirmiers lorsque vient le moment de prendre des risques. Un leadership constant améliore la capacité du leader en soins infirmiers à connaître davantage son personnel et ses collègues, ainsi que les problèmes en matière de soins aux patients, en plus d'accroître la capacité de l'organisation à lancer des stratégies pluriannuelles et à les mener à bonne fin[280].

p Type de données probantes
Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

Dans une étude portant sur les maisons de soins de longue durée, Anderson et coll.[281] ont découvert que le mandat du directeur des soins infirmiers était un bon indice du faible roulement parmi les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées. Cette observation permet de suggérer que plus le leader occupe son poste longtemps, plus il est en mesure d'entrer en relation avec le personnel, de favoriser l'engagement envers le travail et d'en apprendre davantage au sujet de l'organisation et des infirmières afin de gérer de façon plus efficace. Une étude connexe a découvert que la permanence du leader en soins infirmiers entraînait une amélioration des résultats auprès des patients[78]. Étant donné la nature dynamique et les fréquents changements de personnel et de structures au sein des organisations, des stratégies sont nécessaires pour y maintenir la continuité du leadership.

### Planifier le succès – Stratégies de réussites suggérées

- Établir des modèles de leadership communs comme la gouvernance partagée[282].
- Créer des équipes de professionnels qui travaillent dans le cadre d'une matrice dynamique[283].
- Développer un plan de relève en matière de leadership des soins infirmiers[282].
- Tirer parti des occasions d'aborder l'importance d'un environnement stable en soutien à la capacité des infirmières à donner des soins de qualité.

**2.1e** Reconnaître et valoriser les contributions des infirmières en ce qui concerne les résultats auprès des patients et de l'organisation.

## Discussion sur les données probantes[16]

Une culture organisationnelle[G] qui a à cœur la qualité des soins et qui valorisent les infirmières et leurs contributions aux soins constitue un appui important pour les leaders en soins infirmiers[112]. Turnbull et Devine[265] ont rapporté que la reconnaissance des contributions des infirmières est un indicateur de respect pour les infirmières. Dans une étude comparative au sujet des leaders qui, au sein de leurs organisations

### Stratégies de réussite

- Établir et maintenir une infrastructure en soutien à la pratique telle que : comités de gouvernance en soins infirmiers, rôles de pratique avancée, infirmières scientifiques, rôles désignés avec responsabilité distincte pour l'exercice professionnel[267].
- Différencier les rôles de pratique des infirmières selon l'expérience, la formation et les certifications (échelles cliniques[155, 267]).
- Maximiser le champ de pratique des infirmières et réduire les tâches non liées aux soins infirmiers[1, 270].
- Créer des systèmes de rémunération et de récompenses qui reconnaissent la distinction entre les rôles et qui reflètent l'expérience, la formation, les titres supérieurs, la responsabilité et le rendement[198. 265, 267].
- Reconnaître les titres professionnels et académiques sur les insignes et les rapports[267].
- Inclure les infirmières dans les événements médiatiques, les annonces qui relèvent des relations publiques, la planification stratégique[267].
- Offrir des récompenses pour des réussites exceptionnelles et organiser des cérémonies de remise de prix afin de reconnaître la réussite.
- Publier un rapport annuel sur les soins infirmiers ou mettre en vedette les soins infirmiers dans le rapport annuel de l'organisation[267].

q Type de données probantes
Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

respectives, constituent un pôle d'attraction et des autres leaders, 86 % des leaders en soins infirmiers dans les hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier avaient fait état d'un fort appui administratif à l'égard des infirmières. Les équipes de direction principales de ces établissements ont reconnu l'importance du rôle des infirmières, particulièrement la valeur de l'observation étroite et des soins aux patients. Les leaders en soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier ont mentionné l'influence positive qu'ils avaient obtenue dans leurs établissements, alors que les leaders en soins infirmiers des autres établissements ont rapporté qu'ils consacraient beaucoup d'énergie à exprimer clairement l'importance des soins infirmiers pour l'organisation[81].

## 2.2 Les organismes de services de santé respectent les infirmières en tant qu'individus.

### Discussion sur les données probantes[17]

Le respect des infirmières dans le milieu de travail a été lié à l'autonomie[90]. Le manque de respect a été lié au stress et à une diminution de la satisfaction au travail[90]. Les infirmières ont déclaré qu'il est irrespectueux de s'attendre à ce qu'elles soient disponibles à faire des heures et des quarts supplémentaires en dépit de circonstances personnelles[265]. La moyenne d'âge des infirmières au Canada est de 44,5 ans et une infirmière sur trois est âgée de 50 ans ou plus[284]. Duxbury et Higgins[285] ont découvert que les employés qui ont des personnes à charge avaient fait état d'une moins bonne santé physique et mentale que ceux qui n'ont pas à prendre soin d'enfants ou de personnes âgées. Ces personnes font partie de la génération 'sandwich'; elles doivent s'occuper de leurs parents vieillissants tout en ayant des enfants à la maison. Les organisations doivent trouver des façons créatives d'encourager les infirmières plus âgées à demeurer sur le marché du travail et à être disponibles pour partager leur expertise clinique, à agir à titre de mentor et à encourager les infirmières plus jeunes.

On s'inquiète du fait que la nouvelle main-d'œuvre pourrait ne pas être attirée par les postes de leadership en soins de santé[1, 110, 285]. Les travailleurs plus jeunes décrivent le souhait d'un équilibre vie professionnelle-personnelle[110]. Les postes de leadership tendent à être caractérisés par une augmentation des exigences de l'emploi[255] et de longues heures de travail sans soutien administratif adéquat[1, 258]. Duxbury et Higgins[285] ont rapporté que les gestionnaires et les professionnels de sexe féminin étaient plus susceptibles de rapporter des niveaux élevés d'épuisement professionnel que les femmes qui occupent d'autres postes. Wieck et coll.[110] ont constaté l'importance de favoriser le développement des jeunes puisqu'ils deviendront les leaders en soins infirmiers de demain.

Le respect pour la main-d'œuvre comprend la diversité dans son sens le plus large, y compris la diversité culturelle et ethnique. Hemman[287] a découvert que l'ethnisme était mal documenté, même si Redmond[287] a rapporté que 70 % des infirmières en chef étaient euro-américaines et 3 % étaient afro-américaines. Dans une enquête portant sur les infirmières hispaniques aux États-Unis menée par Villarruel et Peragallo[288], les répondantes ont mentionné l'importance des modèles et des mentors dans le développement et le soutien des aptitudes de leadership. Bien que l'importance des mentors hispaniques et non hispaniques ait été constatée, l'importance d'avoir un mentor qui reflète l'ethnisme d'une personne a été soulignée non

r Type de données probantes
Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

seulement dans cette étude, mais aussi par des participants à une étude canadienne menée par Tucker Scott[129]. Elle a remarqué que les minorités raciales et ethniques continuent d'être sous-représentées dans les programmes d'enseignement en sciences infirmières et, par conséquent dans la main-d'œuvre, particulièrement au niveau de la supervision. Dans d'autres études, les gestionnaires de couleur ont rapporté un degré de satisfaction moindre en ce qui concerne la qualité des possibilités et des relations interpersonnelles en milieu de travail[289, 290, 292].

### Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Développer des conditions de travail différentes[285], y compris un horaire flexible, des politiques d'horaires variables et le télétravail.
- Offrir des quarts de travail de durées variées (p. ex., 8, 10 et 12 heures).
- Offrir des services de garde d'enfants.
- Offrir un nombre limité de jours de congé payés par année pour prendre soin des enfants, des personnes âgées ou pour régler des problèmes personnels[285].
- Étudier la « compétence culturelle » organisationnelle et les obstacles au leadership des minorités visibles – consultez les Lignes directrices pour la pratique exemplaire sur la diversité culturelle dans le milieu de travail (publication prévue pour 2006).
- Adapter la programmation du perfectionnement professionnel à une variété de besoins en matière d'apprentissage.
- Utiliser la technologie pour offrir un perfectionnement professionnel et des séances sur place tout au long de la journée.
- Offrir de l'accompagnement et du mentorat afin de renforcer la confiance du personnel plus jeune et moins expérimenté[111].

## 2.3 Les organismes de services de santé offrent des occasions de croissance, d'avancement et de leadership.

### Discussion sur les données probantes[18]

Les occasions de croissance et d'avancement ont été jugées aussi importantes non seulement pour le leadership professionnel et clinique, mais également pour le perfectionnement de personnes qui occupent un poste de leadership formel[264]. Des liens ont été rapportés entre les occasions de croissance et l'habilitation[155, 156, 174]. Les occasions de croissance et de perfectionnement ont été définies comme des aspects importants des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier[43, 88, 156, 264]. Upenieks[155] a découvert que les leaders des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier et ceux des autres hôpitaux se concentraient sur des éléments semblables tels que la visibilité, la prestation de services de dotation et d'équipement, alors que les leaders des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier se concentraient davantage sur les services éducatifs supplémentaires.

s Type de données probantes
Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

## Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Prévoir du temps pour la formation et pour la dotation en personnel de remplacement dans le budget des soins infirmiers.
- Instaurer des programmes d'orientation et de préceptorat[198, 267].
- Appuyer la formation professionnelle continue grâce à un soutien aux frais de scolarité et à une dotation flexible[198, 267].
- Établir des relations avec des établissements d'études supérieures afin de développer des unités d'enseignement clinique, de la formation continue sur place et de la recherche coopérative[267].
- Offrir des internats aux nouveaux diplômés[267].
- Appuyer la pratique basée sur les données probantes grâce à un accès à la bibliothèque, à Internet et aux lignes directrices pour la pratique exemplaire.
- Faire participer les infirmières à la planification des programmes de perfectionnement professionnel[198].
- Appuyer la planification de carrière à l'aide d'outils et de processus d'évaluation du rendement.
- Favoriser et appuyer l'adhésion à des organismes spécialisés en soins infirmiers.
- Encourager la certification par spécialité de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada.

## 2.4 Les organismes de services de santé appuient une culture de responsabilisation afin de permettre aux infirmières d'être responsables et d'être en mesure de répondre de leur pratique professionnelle.

### Discussion sur les données probantes[19]

*L'autonomie et la participation à la prise de décision* ont été liées à l'habilitation du personnel et du leader et aux résultats positifs pour les patients et les infirmières[38, 88, 112, 141, 156, 195, 197, 264]. L'autonomie, le contrôle et la collaboration ont été liés à la confiance envers la direction[292] et associés à la satisfaction au travail et à la perception de la qualité des soins aux patients[271]. Les leaders en soins infirmiers ont mentionné que la participation à la prise de décision est fondamentale à l'établissement d'un leadership infirmier dans toute l'organisation[109]. Dans une étude portant sur les gestionnaires intermédiaires d'hôpitaux en Irlande, Carney[293] a découvert que les structures organisationnelles horizontales ont facilité leur participation à la préparation de stratégies organisationnelles et qu'elles ont amélioré la communication. Cela a entraîné la perception d'une meilleure cohésion des gestionnaires et d'une communication plus efficace de la part des infirmières gestionnaires qui se rapportent à eux. Les gestionnaires intermédiaires qui se sentaient exclus de la participation stratégique ont dit se sentir contrôlés et isolés. Les travaux de DunhamTaylor[74] ont découvert un nombre croissant de comportements de leadership positifs au fur et à mesure que les organisations deviennent plus participatives. Dans une étude portant sur les établissements qui attirent et retiennent le personnel infirmier, les leaders en soins infirmiers ont mentionné l'importance de soutenir les décisions des infirmières[155], mais les leaders des autres établissements affirment être moins au courant du degré de contrôle que les infirmières devraient avoir dans le cadre de la prise de décision[81].

*La gouvernance partagée* est une stratégie qui peut être utile lorsqu'il s'agit de soutenir le leadership et la participation du personnel à la prise de décision. À la suite d'une étude d'intégration de la documentation qui s'étendait sur 10 ans (de 1988 à 1998), O'May et Buchan[294] ont conclu que même si la gouvernance partagée n'est pas une solution miracle (p. 296), elle entraîne de nombreux résultats positifs, y compris une

t Type de données probantes
Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

meilleure perception de l'efficacité de la direction, un perfectionnement accru du personnel, une croissance accrue des aptitudes, une meilleure expertise du personnel et du développement professionnel. Ils soulignent la nécessité d'offrir de la formation et du soutien, du mentorat et du temps libre au personnel afin qu'il participe à la prise de décision et établisse les limites de la latitude des groupes et des comités consultatifs. Upenieks[295] a effectué une analyse critique de nombreux essais sur le terrain publiés de 1994 à 1997 en utilisant les modèles de gouvernance partagée et a conclu que la mise en œuvre d'une gouvernance partagée améliorait la satisfaction au travail, augmentait le pouvoir personnel, la responsabilisation des infirmières et améliorait le milieu de travail. Song et coll.[296] ont découvert que la gouvernance partagée entraînait une plus grande satisfaction au travail chez les infirmières. Dans une étude d'intervention cas témoin menée dans un service d'urgence, Gokenbach[176] a constaté qu'une intervention d'habilitation sous la forme d'un conseil infirmier, dont les limites de la prise de décision sont claires, a entraîné une baisse et une stabilisation considérables du roulement des infirmières.

### Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Concevoir des structures organisationnelles horizontales qui décentralisent la prise de décision[144, 267, 293].
- Introduire la représentation des soins infirmiers au sein des organismes décisionnaires qui régissent les politiques et les opérations, y compris ceux qui embauchent le nouveau personnel[176, 265, 267], et particulièrement ceux qui touchent à la finance, à la planification stratégique et à l'amélioration de la qualité[267, 297].
- Mettre en place une gouvernance partagée[294 à 296].
- Ériger des structures pour les infirmières qui jouent des rôles de soins directs afin d'offrir une participation dans le cadre d'une structure axée sur la discipline, tel qu'un conseil infirmier[198].
- Offrir de la formation, du soutien et des limites claires en ce qui concerne les décisions afin de permettre la participation aux structures de prise de décision.
- Instituer des politiques et des protocoles qui permettent aux infirmières d'aborder les problèmes concernant l'éthique et le dénonciation[198].
- Établir des politiques et des procédures qui permettent aux infirmières d'aborder les problèmes de pratique professionnelle[198].
- Maximiser le champ de pratique des infirmières dans tous les rôles de l'organisation[198].
- Tenir régulièrement des forums de discussion[187]

**2.5** Les organismes de services de santé offrent un accès opportun aux renseignements, aux systèmes efficaces d'information et d'aide à la décision[G] et aux ressources nécessaires dans le cadre des soins aux patients.

## Discussion sur les données probantes[20]

*Les outils d'aide à la décision* tels que les outils d'examen de l'utilisation et les systèmes d'analyse des processus et des problèmes de pratique, des résultats pour les patients-clients, des inquiétudes concernant la sécurité des patients, de la documentation informatisée et des outils de mesure de la charge de travail, constituent d'importants soutiens à la pratique et au leadership infirmier[267].

u Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

*L'accès à l'information,* est un indice d'être au courant[162] et le fait de détenir de l'information opportune sur les décisions organisationnelles et les changements relatifs à la politique est lié à l'habilitation[144, 162]. Les leaders en soins infirmiers ont rapporté l'importance de disposer de suffisamment de renseignements pour s'acquitter des responsabilités de leur rôle[109].

Offrir les ressources nécessaires pour les soins aux patients est un signe considérable de respect envers les infirmières et leur contribution à l'organisation[187, 298]. Les ressources en équipement, en fournitures, en aide et en technologie d'aide sont nécessaires pour appuyer la qualité des soins et le leadership clinique. Laschinger et coll.[156] ont découvert un rapport entre les ressources, l'habilitation et l'autonomie. La mesure dans laquelle un leader en soins infirmiers est capable d'offrir aux infirmières les outils nécessaires pour faire leur travail est fonction de l'efficacité du leader en soins infirmiers et de son autorité[187].

Il est essentiel de disposer de *ressources humaines* nécessaires qui tiennent compte de la complexité des soins[267] afin d'offrir des soins de qualité aux patients et du soutien au développement des aptitudes de leadership clinique. Il a été démontré que l'accès aux ressources en personnel adéquates prédisait la satisfaction au travail des infirmières, augmentait le maintien en poste et améliorait la qualité des soins[271]. Upenieks[81] a découvert que les établissements qui attirent et retiennent le personnel infirmier présentaient un rapport de personnel professionnel supérieur à celui des autres établissements.

### Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Instaurer des mécanismes afin de communiquer les initiatives infirmières et organisationnelles, notamment un bulletin sur les soins infirmiers, des extraits vidéo sur l'intranet.
- Utiliser les systèmes de courriel et la technologie sur le Web afin de fournir de l'information opportune et à jour sur les initiatives et les événements touchant les soins infirmiers et l'entreprise.
- Tenir des discussions ouvertes afin de partager l'information.
- Offrir un soutien technique et administratif aux infirmières gestionnaires et aux leaders afin qu'ils puissent travailler avec le personnel, les patients et les familles[260].
- Faire participer le personnel au développement et à l'entretien continu des outils de mesure de la charge de travail, discuter régulièrement des données au cours de réunions et consulter les Lignes directrices pour la pratique exemplaire sur la charge de travail et la dotation en soins infirmiers (publication prévue pour 2006).

## 2.6 Les organismes de services de santé favorisent et appuient la collaboration.

### Discussion sur les données probantes[21]

La collaboration au sein des organisations accroît la confiance[71] et l'habilitation[162] qui influencent le développement et le maintien du leadership infirmier. Les leaders en soins infirmiers peuvent rehausser leur propre crédibilité auprès de leurs collègues en discutant et en bâtissant des relations afin de mieux comprendre les défis auxquels ils font face, individuellement et collectivement[112, 140, 244].

v Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Les relations positives avec les médecins sont une caractéristique des établissements qui attirent et retiennent le personnel infirmier[89]. La collaboration avec les médecins peut mener au respect mutuel des connaissances et à la mise en commun des connaissances[144], ce qui contribuera finalement à l'habilitation et à l'amélioration du leadership clinique[144]. Upenieks[144] a découvert que le travail d'équipe prévalait davantage dans les hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier; les leaders des autres établissements ont rapporté des relations infirmière-médecin légèrement plus négatives.[81]

Upenieks[109] a mentionné l'importance d'une gestion d'équipe collaborative au sein des soins infirmiers pour appuyer le développement et le maintien du leadership infirmier. Un groupe qui offre une coopération créative, une communication compréhensive, une compréhension et une collaboration a été considéré un soutien important pour atteindre des buts organisationnels et un leadership efficace. Disch et coll.[135] ont rapporté que la collaboration entre les administrateurs des soins infirmiers et les leaders cliniques en soins infirmiers pouvaient constituer un partenariat inestimable afin d'améliorer le leadership clinique parmi les infirmières.

Les leaders en soins infirmiers ont indiqué que les relations de travail fondées sur la collaboration dans toute l'organisation, ainsi que de la part de l'équipe principale, amélioraient leur efficacité[109].

## Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Créer des conseils de pratique interprofessionnelle[198].
- Prévoir du temps pour la collaboration dans la planification de la charge de travail[48].
- Tenir des réunions et des tables rondes interprofessionnelles[109] et faire une rotation en ce qui concerne la responsabilité de l'animation et de l'enseignement.
- Préparer un code de conduite et un processus de communication pour l'équipe interprofessionnelle.
- Concevoir et mettre en œuvre des plans de soins standard et des cheminements cliniques[48].
- Développer des processus de révision par les pairs au sein de l'équipe interprofessionnelle pour les événements indésirables liés aux soins des patients[267].
- Offrir une formation sur le règlement de conflit et la communication interculturelle afin d'accroître la collaboration[135].
- Mettre sur pied des forums de gestion des soins infirmiers pour une résolution mutuelle des problèmes et une mise en commun de l'information.
- Concevoir des espaces de travail où on trouve des salons communs afin d'encourager l'interaction sans cérémonie et d'offrir des endroits privés pour la consultation[48].
- Collaborer avec une vaste gamme de partenaires comme des groupes de recherche, des établissements d'enseignement, d'autres fournisseurs ou organisations professionnelles.
- Consulter les Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains de l'AIIAO portant sur la collaboration entre les équipes de soins infirmiers (publication prévue en 2006).

| 2.7 | Les organismes de services de santé établissent des champs de responsabilité et de responsabilisation qui permettent des pratiques de leadership efficaces. |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[22]

Parmi les stratégies de réduction des coûts communes se trouve la réduction des postes de gestion, malgré les observations faites par The Gallup Organization[299] sur une période de 25 ans, qui démontrent que la relation gestionnaire-employé est importante pour l'engagement et le maintien en poste des employés. En 1956, Urwick[300], dans un article pour le *Harvard Business Review*, a constaté que lorsqu'un leader dispose d'un vaste contrôle[G], les personnes qui cherchent à entrer en contact avec lui seront déçues et concluront que le leader est trop occupé pour tenter d'apprendre à les connaître et de comprendre leurs inquiétudes. Dans une étude portant sur 14 hôpitaux en cours de réingénierie, Walston et Kimberley[119] ont découvert que l'ampleur accrue du contrôle entraînait une baisse de la participation du personnel à la planification et à la conception du changement, une réduction de la quantité de renseignements sur la conception du changement et une baisse en ce qui concerne l'atteinte du changement visé.

Mullen et coll.[301] ont découvert que plus le contrôle des superviseurs grandissait, plus les leaders se concentraient sur les tâches plutôt que sur les relations, et que les membres de l'équipe étaient plus susceptibles d'être insatisfaits. Une étude menée par l'industrie chimique[302] a démontré que des contrôles plus vastes entraînaient moins de surveillance par les superviseurs et des taux plus élevés de comportements non sécuritaires et d'accidents. Dans l'industrie du transport aérien, Gittell[303] a découvert qu'une étendue moindre du contrôle renforçait la résolution de problème, le respect mutuel, les connaissances et les buts communs, et la communication plus opportune entre les membres du groupe.

McCutcheon[65] a découvert que plus le contrôle des gestionnaires en soins infirmiers était vaste, plus le taux de roulement du personnel de l'unité était élevé; pour chaque augmentation de 10 à l'ampleur du contrôle, le taux de roulement du personnel prévu augmentait de 1,6 %. De plus, au fur et à mesure que l'étendue du contrôle augmente, les effets positifs des styles de leadership empreint de sollicitude (transformationnel et transactionnel) sur la satisfaction au travail des infirmières diminuaient et les effets négatifs des styles de leadership non empreints de sollicitude augmentaient.

Cathcart et coll.[304] ont découvert que les résultats en ce qui concerne l'engagement des employés diminuaient proportionnellement à l'augmentation de l'ampleur du contrôle. Ces observations ont été faites dans toutes les catégories de facteurs démographiques testés, y compris le mandat, la situation d'emploi (temps plein, temps partiel, occasionnel), le type de contrat (syndiqué, non syndiqué), le poste (gestionnaire, exécutant) et le type de travail (soins aux patients ou non). Les résultats en ce qui concerne l'engagement ont chuté en particulier lorsque les groupes de travail comptaient plus de 15 personnes et davantage encore lorsqu'ils comptaient 40 personnes ou plus. L'organisation a créé des postes de gestion supplémentaires dans quatre secteurs où les infirmières gestionnaires avaient la responsabilité directe de plus de 80 employés, et un an plus tard, un changement positif dans les résultats concernant l'engagement a été observé.

---

w Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

| 2.8 | Chaque organisme de soins de santé dispose d'un plan stratégique pour le développement du leadership infirmier. |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[23]

Le manque d'occasions de développement du leadership peut être un facteur du roulement des infirmières et de leurs leaders[280]. Antrobus et Kitson[126] ont suggéré qu'il y a très peu de mesures incitatives offertes aux futurs leaders en soins infirmiers à demeurer dans la pratique directe si on compare au fait de jouer un rôle de leadership plus visible au sein du milieu universitaire, de la direction ou de la politique. Ils ont constaté la nécessité de préconiser les cheminements de carrière en pratique directe qui comprennent le développement du leadership clinique. Les mêmes auteurs ont souligné l'importance de développer les compétences politiques et organisationnelles afin de donner aux infirmières les moyens de travailler sur un pied d'égalité et de se faire entendre.

Même si de nombreuses études[200, 305 à 310] ont rapporté des résultats positifs associés aux programmes de développement du leadership formel, plusieurs auteurs[112, 200, 306, 307, 310, 312] ont insisté sur le fait que les nouveaux leaders devaient aussi avoir l'occasion d'appliquer leurs nouvelles compétences. Les résultats positifs ont été démontrés lors d'un court essai pilote sur le terrain d'un programme d'orientation qui est fondé sur les compétences pour les nouveaux diplômés et qui intègre des stratégies d'apprentissage multimédia de même que l'occasion d'appliquer de nouvelles compétences lors de la direction de colloques et de tables rondes[312]. Les participants au groupe d'intervention se sont avérés prêts plutôt à assumer leurs rôles de leadership et ont fait preuve de meilleures compétences en leadership.

Dans une étude portant sur le programme de leadership pour les infirmières soignantes[306], les soutiens nécessaires ont été définis, notamment la masse critique de collègues participant au programme, les mentors et les comportements de leadership modelés par les gestionnaires, les infirmières cliniciennes spécialisées et d'autres collègues. Parmi les obstacles définis, on trouve la charge de travail, le roulement, le manque de responsabilités, l'établissement insuffisant de buts avec la direction, le fait d'être nouveau et la rétroaction négative à la suite de l'essai de nouveaux comportements.

De nombreux auteurs ont déterminé la nécessité d'une planification de la relève[G196, 200, 307 à 309, 311,] notamment le fait de diriger des infirmières vers des expériences de gestion et des postes de leadership formel[1]. Les leaders en soins infirmiers ont rapporté que les diverses occasions de leadership telles que la participation à des comités et la latitude dans la prise de décision étaient importantes pour le développement du leadership[187].

x Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

## Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Préparer un plan de relève qui dirige les infirmières vers des expériences de leadership[196, 200, 308 à 310,312].
- Offrir des programmes de développement du leadership[313] qui comprennent l'évaluation des besoins et les objectifs de formation qui visent à abolir les obstacles au sein de l'organisation[314].
- Fournir l'accès aux programmes de leadership externes[260].
- Intégrer des modèles en direct ou enregistrés aux programmes de leadership[311].
- Renforcer les nouveaux comportements grâce à de la rétroaction positive[306].
- Effectuer des évaluations du rendement qui intègrent la rétroaction détaillée[313].
- Donner l'occasion d'interagir avec des leaders d'au moins deux grades supérieurs[311].
- Mettre en place des programmes de mentorat et d'encadrement[260, 308, 313] y compris l'accès à des encadreurs formels.
- Créer des rôles de leadership pour les infirmières tels qu'enseignante ou chef de projet[109].
- Promouvoir à l'interne[109].
- Encourager les infirmières à participer aux groupes de travail et aux comités, à l'interne comme à l'externe[163, 196, 313].
- Collaborer avec les établissements d'enseignement afin d'offrir des programmes de leadership et des possibilités aux étudiants[314].

y Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

# Reccomandations relatives aux ressources personnelles

| 3.0 | Les leaders en soins infirmiers développent continuellement leurs ressources personnelles pour un leadership efficace. |
|---|---|

Dans un examen de la littérature spécialisée, plusieurs études ont défini de nombreuses ressources personnelles afin de soutenir les pratiques de leadership efficaces. Il est important pour les organisations de comprendre et d'apprécier les ressources personnelles que les infirmières apportent au milieu de pratique et de trouver des façons créatives d'offrir du soutien. De la même façon, les infirmières doivent être conscientes de ces forces afin d'être en mesure de les évaluer, de les façonner et de s'en inspirer. Les ressources personnelles comprennent *l'identité professionnelle*[G] du leader en soins infirmiers; *les caractéristiques individuelles*[G] telles que l'identité ethnoculturelle[G], l'intelligence émotionnelle, la capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation et la flexibilité; *l'expertise en leadership*[G], y compris les connaissances, les années d?expérience et la préparation, les études supérieures formelles; et les *soutiens sociaux*[G] qui comprennent les mentors, les collègues, les amis et la famille.

Wood-Allen[315] a déterminé facteurs qui déterminent le leadership : la confiance en soi, les qualités de leader innées, la progression de l'expérience, l'influence des autres et les facteurs de vie personnelle.

Strasen[317] aborde le « moi psychologique professionnel », ou l'identité professionnelle, en tant qu'ensemble des croyances et des images tenues pour vraies à la suite d'une socialisation professionnelle. Il remarque qu'il est basé sur le moi psychologique individuel, et que l'un affecte l'autre. Strader et Decker[318] décrivent les caractéristiques individuelles qui indiquent un moi psychologique positif, y compris la capacité à affronter les déceptions, l'orientation future et le quotient émotionnel[G].

| 3.1 | Les leaders en soins infirmiers font preuve d'une forte identité professionnelle. |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[24]

Apker et coll.[197] ont découvert que même si le soutien du gestionnaire prédisait l'engagement des infirmières envers l'organisation, il ne prédisait pas l'engagement envers la profession. Cela contraste avec le soutien des collègues qui prédisaient l'engagement professionnel. Ils expliquent que les gestionnaires de l'hôpital étudié semblaient représenter davantage l'hôpital que leur profession, compte tenu de l'attention qu'ils portaient aux tâches administratives.

Les leaders en soins infirmiers efficaces se passionnent pour les soins infirmiers[155]. Ils comprennent clairement ce que signifie être une infirmière et membre de la profession infirmière. Cette identité évolue grâce à la formation, au processus de socialisation du travail et à l'influence de mentors[319, 320]. Le processus

de socialisation exige le développement de valeurs critiques, y compris l'engagement envers des soins et un milieu de pratique de qualité[35, 38, 81, 95, 112, 134, 140] tout en plaçant les patients-clients au premier plan[112, 140]. Les autres valeurs incluent l'engagement envers les soins, la justice, l'honnêteté, le respect, l'intégrité[102], l'éducation, l'autonomie professionnelle et le respect d'autrui[319]. Ce sont des traits semblables à ceux attribués aux leaders transformationnels[86].

Les leaders en soins infirmiers montrent leur passion et leur respect envers la profession infirmière, ses valeurs, les connaissances et les réussites[36, 38, 80, 88, 100, 113, 123, 129, 139, 155] en abordant la question de la contribution des soins infirmiers aux résultats auprès des patients-clients[126, 140]. Les leaders en soins infirmiers efficaces apprécient et utilisent leurs connaissances cliniques et professionnelles en soins infirmiers lors de la prise de décision[112, 257]. Ils sont actifs au sein des organisations professionnelles en matière de soins infirmiers. [88, 129, 140, 263]

> *« Je suis une infirmière dans un rôle de leadership. (traduction) Tucker Scott, p.[101129] »*

**3.2** Les leaders en soins infirmiers réfléchissent au sujet de leurs qualités, de leurs aptitudes et de leurs compétences de leadership individuelles et les développent.

## Discussion sur les données probantes[25]

Lorsque l'on demande aux infirmières et à leurs leaders de définir les qualités des leaders efficaces, *les aptitudes de communication et d'écoute* sont constamment mentionnées[52, 88, 107, 113, 131, 260]. Les leaders en soins infirmiers efficaces font preuve de *capacité d'adaptation, de persistance et de robustesse*[48, 82, 100, 189, 285, 322,] des termes utilisés pour décrire les caractéristiques des leaders transformationnels[83] et liés à l'estime de soi et à la confiance[322]. Dans une étude portant sur les infirmières gestionnaires intermédiaires, Judkins[322] a découvert qu'une grande robustesse indiquait de faibles niveaux de stress et a constaté que la robustesse pouvait être apprise. Sullivan et coll.[324] a découvert que la capacité d'adaptation et l'emploi d'humour aidaient à préserver l'engagement du leader et évitaient l'apathie dans les moments difficiles. Les capacités à pratiquer l'*autoréflexion* et à posséder une *connaissance de soi* sont des ressources personnelles critiques nécessaires au soutien du leadership efficace[48, 82, 107, 325, 326].

Les leaders en soins infirmiers efficaces affichent un degré de *flexibilité* [48, 81,] sont *à l'aise avec l'ambiguïté, l'incertitude et la complexité*[82, 112, 327, 328] et sont prêts à *prendre des risques* [80, 82, 250]. Les infirmières efficaces ont été décrites comme positives et accessibles[48]. Les leaders en soins infirmiers ont déterminé l'importance de travailler à partir d'un cadre moral, d'une force interne et d'une confiance en ses propres valeurs et convictions[112, 239, 250] plutôt que d'être guidés par la sécurité, le pouvoir et le prestige[112, 140]. Ils font preuve *d'intégrité morale*, qui se reflète dans les gestes qui correspondent aux convictions[81, 82, 86, 106, 112, 239]. Plusieurs auteurs mentionnent l'importance du courage et de la prise de risque[112, 140, 250].

---

z Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Upenieks[144] remarque que les infirmières cliniciennes ont rapporté qu'elles préféraient travailler avec des gestionnaires puissants. Le pouvoir formel et non formel est l'élément constitutif de l'habilitation[178, 329] et du pouvoir personnel[151]. Dans une étude portant sur les leaders en soins infirmiers, les participants ont affirmé que leur rôle leur donnait beaucoup de pouvoir. Cependant, ils ont aussi rapporté que le pouvoir se trouve en chacun de nous et qu'il est obtenu par la confiance en soi et la force intérieure[109]. La confiance en soi a été définie comme une caractéristique des leaders efficaces[109, 316].

Une étude menée par Weick et coll.[110] dans le cadre de laquelle il faisait correspondre l'opinion des membres d'une nouvelle main d'œuvre en soins infirmiers (moins de 35 ans) avec celui des membres âgés de plus de 35 ans, a démontré que les deux groupes appréciaient, pour la plupart, des caractéristiques semblables chez les leaders, toutes liées au leadership transformationnel. Les deux groupes appréciaient l'honnêteté, les aptitudes à la communication, l'attitude positive et l'accessibilité. Parmi les différences, mentionnons la tendance chez les travailleurs plus jeunes à chercher des leaders présents, motivants, cultivés, qui renforcent la confiance et qui sont doués pour la promotion du travail d'équipe.

Plusieurs des caractéristiques attribuées aux leaders en soins infirmiers efficaces, telles que la connaissance de soi, la communication, l'établissement de relations, la capacité d'adaptation, l'optimisme[330] et la vision[82, 88, 324] sont en harmonie avec le quotient émotionnel (QE)[G]. Ce concept a été décrit au départ par Salovey et Mayer[331] comme une capacité à reconnaître la signification des émotions et des relations, et à s'en servir pour raisonner et résoudre les problèmes[332]. Le QE a été davantage décrit par Goleman et coll.[333] comme supposant *la conscience de soi, l'autogestion, la conscience sociale* et *la gestion des relations*. Goleman[327] a découvert que le QE était deux fois plus important que les aptitudes techniques et les capacités cognitives en ce qui concerne l'excellence du leadership. Goleman et coll.[333], comme Salovey et Mayer[331] suggère que le QE peut être développé. Les lignes directrices pour instaurer des programmes de formation sur le QE sont disponibles[333].

D'autres études ont démontré que le QE est positivement associé au leadership transformationnel[298] et lié au leadership efficace[48, 84, 114, 328]. Cummings et coll.[63] ont découvert que les styles de leadership compatibles avec le QE (qualifiés de styles résonants) ont atténué les effets de la restructuration des hôpitaux chez les infirmières, alors que les styles dissonants en intensifiaient les effets. Les styles résonants ont entraîné considérablement moins d'épuisement affectif et de symptômes psychosomatiques, une meilleure santé émotionnelle, une meilleure collaboration au sein des groupes de travail et un meilleur travail d'équipe avec les médecins, une plus grande satisfaction au travail et un nombre moindre de besoins non satisfaits des patients que dans le cas des infirmières travaillant avec des leaders dissonants.

> *« Les leaders en soins infirmiers sentaient que leurs tendances innées avaient façonné leur style de leadership. »*
>
> *(traduction) Upenieks[144 p. 188]*

aa Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

**3.3** Les leaders en soins infirmiers sont responsables de la croissance et du développement de leur propre expertise en leadership et agissent à titre de mentor pour développer une expertise en leadership.

## Discussion sur les données probantes[26]

Blais et coll.[319] constatent que les infirmières qui s'améliorent offrent un rendement plus efficace et, en retour, donnent une image plus positive des soins infirmiers. Le développement de l'expertise en leadership a été décrit comme un processus[74] consistant à développer, au fil du temps, des compétences et des comportements grâce à la formation, au préceptorat et au mentorat[50]. Les participants à des études où on demandait aux infirmières et à leurs leaders d'énumérer les qualités des leaders efficaces ont mentionné que les années d'expérience[52, 80, 117], les études supérieures en soins infirmiers [71, 75, 112, 129, 276] et l'ampleur des connaissances étaient importantes[52, 57]. Altieri[55] a découvert que les directrices ou chefs des soins infirmiers qui avaient reçu un enseignement de deuxième cycle universitaire obtenaient des résultats transformationnels plus élevés que celles qui avaient reçu une formation de niveau inférieur. Gelinas et Manthey[136] ont constaté que les leaders en soins infirmiers sont responsables de la gestion de leur propre perfectionnement professionnel et ont établi la nécessité pour les leaders en soins infirmiers d'être capables de diriger en franchissant les limites de l'unité de travail et les limites culturelles, et de faciliter le travail d'équipe et le changement.

De nombreuses études et plusieurs auteurs traitent du perfectionnement professionnel continu nécessaire pour accroître l'expertise en leadership. Un accent particulier est placé sur le fait que les leaders en soins infirmiers possèdent des connaissances fondées sur les soins infirmiers cliniques[126, 129, 276] afin d'avoir de la crédibilité auprès des collègues et de comprendre le contenu et le contexte des soins, des systèmes et des organisations[38]. Antrobus et Kitson[126] ont insisté sur le besoin de posséder des connaissances en soins infirmiers comme élément central des programmes de développement du leadership afin que les leaders en soins infirmiers puissent non seulement perfectionner la pratique des soins infirmiers, mais également être en mesure d'expliciter les connaissances dans ce domaine.

Dans le cadre d'une étude finlandaise, des infirmières gestionnaires[181] ont affirmé qu'il est nécessaire de recevoir une formation afin d'accroître leurs aptitudes en recherche, en leadership et en travail de groupe afin de résoudre des problèmes. De la même façon, dans une étude portant sur les gestionnaires canadiens, les participants ont rapporté que des besoins en matière d'apprentissage sont liés à la recherche[209]. De nombreux auteurs ont mentionné l'importance d'un bon sens des affaires[126, 136] et le fait d'être en mesure d'utiliser des données quantitatives pour justifier la dotation et pour être considérés crédibles par les autres membres de l'équipe de leadership[109]. Les gestionnaires intermédiaires et de première ligne ont rapporté que lorsque les leaders en soins infirmiers qui occupent un poste de cadre supérieur possédaient ces aptitudes, ils développaient la capacité à utiliser les données financières dans leur propre prise de décision[109].

---

bb Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

cc Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

**Les leaders en soins infirmiers doivent posséder des connaissances générales dans les domaines suivants :**

- **soins infirmiers**[38, 52, 117, 131, 307]
- **leadership**[38, 113, 117, 131, 260, 307]
- **philosophie**[52]
- **éthique et documentation sur le sujet**[140, 259]
- **processus de groupe**[52] **et promotion du travail d'équipe**[136]
- **développement humain et moral**[52]
- **connaissances en affaires et en gestion**[112, 126, 136, 155, 257, 307]
- **gestion du changement**[136]
- **promotion du travail d'équipe**[260]
- **direction d'une main-d'œuvre variée**[334]
- **recherche et utilisation de la recherche**[209]

## 3.4 Les leaders en soins infirmiers cultivent les soutiens professionnels, personnels et sociaux.

### Discussion sur les données probantes[27]

Taylor et coll.[335] ont constaté que les personnes qui croyaient avoir accès aux soutiens sociaux de la part des autres vivaient des vies plus saines et étaient en mesure de faire face au stress de façon plus efficace. Les leaders en soins infirmiers ont indiqué que les mentors constituaient des soutiens importants au développement et au maintien de leur capacité de leadership[82, 112, 129, 201, 189, 238, 239, 336]. Dans une étude portant sur les infirmières gestionnaires occupant des postes de cadres, Madison[201] a découvert que 97 % des répondants attribuaient les changements dans leur vie professionnelle ou personnelle au fait d'avoir un mentor, 74 % un changement en ce qui concerne la confiance en soi et 65 % un changement en ce qui concerne la conscience de soi. D'autres changements rapportés incluent la hausse de la prise de risque, une pensée globale accrue, une meilleure estime de soi et une plus grande valorisation du travail, une croissance professionnelle et une amélioration du rendement en tant que gestionnaire. Une métaanalyse[G] menée par Allen et coll.[337] a démontré que le mentorat lié à l'apprentissage au sujet de l'organisation et l'exposition aux possibilités et au mentorat offrant un soutien interpersonnel ont entraîné des résultats positifs sur les plans de la rémunération, des promotions et de la satisfaction en ce qui concerne la carrière et le travail. Dans une étude sur le personnel menée par Walsh et Clements[336], les participants ont rapporté une hausse de la confiance et de l'estime de soi à la suite d'une relation de mentorat. Les infirmières soignantes incluent l'accès aux mentors parmi les cinq plus importants soutiens au développement des compétences en leadership[260].

---

dd Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

ee Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

Scott et coll.[88] et Storch et coll.[140] ont constaté l'importance d'une participation active aux organismes professionnels en soins infirmiers, laquelle est susceptible d'être utile non seulement pour demeurer au fait des questions actuelles en soins infirmiers, mais aussi afin d'avoir accès au soutien des pairs. Dans une étude portant sur les leaders établis[129], les participants ont mentionné l'importance des mentors et de la participation aux organismes et aux réseaux professionnels non seulement pour demeurer informés des questions et des tendances, mais aussi pour développer des aptitudes politiques.

Les leaders en soins infirmiers ont souligné l'importance du soutien des amis, des conjoints, des familles et des collègues[82, 238 239, 241,] particulièrement des collègues qui possèdent des qualités transformationnelles[82]. Lindholm et coll.[237] ont étudié la relation entre les réseaux professionnels, les ressources psychosociales et l'état de santé autodéclaré. L'étude a démontré que les infirmières gestionnaires dont les exigences de l'emploi sont élevées, les réseaux professionnels sont faibles, la participation sociale ou le soutien émotionnel sont faibles, étaient davantage porter à autodéclarer un état de santé plus faible. En revanche, les infirmières gestionnaires dont les exigences de l'emploi sont particulièrement élevées avaient plus de chance d'autodéclarer un état de santé faible en dépit du niveau de soutien psychosocial et des réseaux professionnels. Ces auteurs suggèrent que les exigences de l'emploi des infirmières gestionnaires sont telles qu'aucun niveau de soutien n'est disponible et qu'il est nécessaire d'explorer davantage les facteurs qui contribuent à un état de santé autodéclaré faible.

Upenieks[109] a fait état de l'importance des équipes de soins de santé cohésives (qui partagent les mêmes buts, se consacrent à l'organisation et aux autres et travaillent de façon interdépendante en équipe) en tant que soutien au leadership infirmier.

ff Type de données probantes
Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

# Recommandations relatives au système

## Recommandations aux gouvernements

**4.0** Les gouvernements préparent des politiques et offrent des ressources afin de soutenir le leadership efficace.

4.1 **Les gouvernements établissent un poste de leader en soins infirmiers qui joue un rôle de conseiller en politiques auprès de toutes les provinces et de tous les territoires.**
4.2 **Les gouvernements établissent un mécanisme de liaison national pour ces rôles.**
4.3 **Les gouvernements mettent sur pied un conseil consultatif en soins infirmiers dans toutes les provinces et tous les territoires.**

### Discussion sur les données probantes [4.1, 4.2, 4.3][28]

Le rapport de l'Institute of Medicine intitulé, *Keeping Patients Safe: Transforming the Work Environments of Nurses*[48] recommande la présence d'un leader en soins infirmiers à l'échelon le plus élevé des organisations pour des raisons de sécurité pour les patients et parce que les infirmières ont des aptitudes d'intégration des soins cliniques au sein de l'institution. Le rôle du leader en soins infirmiers supérieur n'est pas moins important au niveau de la prise de décision gouvernementale et de la préparation des politiques en matière de santé. Deux importants rapports sur les soins infirmiers au sujet du milieu de travail des infirmières, intitulés *Commitment and Care*[9] et *Notre santé, notre avenir : un milieu de travail de qualité pour les infirmières canadiennes*[1] ont recommandé de compter des leaders en soins infirmiers parmi les rôles supérieurs en matière de politiques dans tout le pays. Lors du rapport des progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations faites par le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers, Maslove et Fooks[270] ont constaté qu'au moment de la publication (juillet 2004), 8 des 10 provinces avaient un poste de chef provincial des soins infirmiers.

Splane et Splane[245] ont effectué une étude internationale sur les chefs des soins infirmiers et ont reconnu l'importance de ces rôles dans les juridictions infranationales, comme les provinces et les états. Ils ont aussi effectué un rappel historique du rôle national grâce à un examen de la littérature spécialisée et à des discussions avec des informateurs internationaux clés. Ils ont conclu que le rôle s'était révélé efficace dans les domaines suivants : l'influence dans le cadre de la préparation de politiques, la promotion de l'utilisation optimale des infirmières, la promotion des normes et de la formation en soins infirmiers afin d'améliorer les soins aux patients, la promotion de la recherche en soins infirmiers, la communication publique afin d'éduquer les gens au sujet des soins infirmiers, la promotion des droits de la personne et de l'importance des politiques qui supportent les déterminants de la santé, et l'évolution des soins infirmiers en tant que service humain respecté. Ils ont aussi constaté qu'il est important que ce leader supérieur ait des rapports avec les syndicats nationaux, les organisations professionnelles et un dialogue avec les infirmières de tous les milieux. Selon eux, même si la majorité des politiques établies ont un rapport avec les normes des soins infirmiers, la formation et la recherche, le recrutement et le maintien en poste des

gg Type de données probantes
Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

infirmières et les conditions du lieu de travail des infirmières, il y a eu une influence considérable sur les politiques liées aux déterminants de la santé telle que l'universalité du programme de santé et du statut socioéconomique.

Même si le public fait confiance aux infirmières[338,] la profession n'est pas bien comprise[126] et les infirmières ont fréquemment décrit avoir le sentiment de ne pas être écoutées[140, 239, 339]. Clifford[36] a invariablement découvert que les infirmières exprimaient le besoin de compter sur quelqu'un qui comprend leur pratique au plus haut niveau de l'organisation, appuyant ce qu'elles font pour les patients et les familles. Un leader en soins infirmiers dans un poste gouvernemental supérieur est bien placé pour développer des stratégies afin d'informer le public et le gouvernement au sujet du rôle et de la contribution des infirmières aux résultats auprès des patients et du système[88, 245]. Les infirmières ont affirmé qu'il est essentiel de fournir ce type de formation pour accroître le respect envers les infirmières[265]. Le fait qu'un leader en soins infirmiers joue un rôle en matière de politiques constitue une occasion pour les gouvernements de faire preuve d'un appui visible envers les soins infirmiers et d'agir à titre de modèle pour les autres organisations en maintenant ce poste[245].

En outre, un leader en soins infirmiers actif en matière de politiques constitue une occasion pour les décideurs de mieux comprendre les problèmes relatifs aux soins aux patients et d'obtenir la participation d'experts en soins infirmiers sur l'administration des politiques en matière de santé et les programmes pour les patients. Splane et Splane[245] ont remarqué que cela est particulièrement important étant donné le nombre croissant d'administrateurs « généralistes » des soins de santé (p. 163) qui possèdent des connaissances en administration des affaires et en administration publique, mais qui n'ont pas de connaissances spécialisées au sujet des programmes pour les patients, des valeurs professionnelles et des méthodes grâce auxquelles les buts du programme sont atteints. Deux études[126, 245] ont rapporté que les leaders en soins infirmiers supérieurs jouaient un rôle en traduisant la terminologie, les priorités et les effets possibles dans le contexte politique afin de combler le fossé entre les deux domaines causé largement par les différences philosophiques et linguistiques. Cette situation est semblable au rôle essentiel que les leaders en soins infirmiers supérieurs jouent dans l'interprétation et l'intégration des soins infirmiers à l'administration supérieure et au corps administratif des organisations. Antrobus et Kitson[126] ont constaté que ce rôle d'interprétation est largement assumé par les leaders en soins infirmiers individuels et suggèrent que les coopératives sous la forme de groupes de politiques en soins infirmiers pourraient être très utiles au moment d'analyser et d'éclairer les politiques en matière de santé.

Les problèmes concernant les soins infirmiers ne sont pas nécessairement perçus comme une priorité sur le plan des politiques[112] et le programme politique peut avoir préséance[126, 245]. Plusieurs données probantes font correspondre les milieux de travail des infirmières et les effets sur la qualité des soins aux patients. Les politiques en matière de santé affectent les lieux de pratique et, en définitive, les résultats auprès des patients-clients et du système. À l'aide de la participation d'un leader en soins infirmiers qui occupe un poste de cadre supérieur, les résultats en matière de santé peuvent être améliorés si les points de vue des infirmières sont intégrés aux décisions budgétaires et politiques pouvant avoir un effet sur la santé des patients. Il est essentiel de compter sur les services d'un expert en soins infirmiers disponible et en mesure d'offrir des conseils sur les effets possibles des décisions en matière de politique sur les soins aux patients[245]. Splane et Splane[245] ont constaté que les infirmières qui occupaient des rôles supérieurs en matière de

hh Type de données probantes
Des données probantes de type A, C et D appuient cette recommandation.

politique jouaient un rôle aussi important dans la prévention du développement de politiques négatives que dans la mise en place de politiques positives et l'appui à la mise en œuvre des politiques existantes la manière la plus favorable pour les soins aux patients. Scott et coll.[88] ont découvert que les leaders en soins infirmiers jouent un rôle critique dans le processus de restructuration. Splane et Splane[245] ont observé que le recrutement d'infirmières pour des rôles supérieurs au gouvernement, dans le secteur bénévole et en tant que candidat au parlement reflètent la reconnaissance de la valeur des aptitudes de leadership, de résolution de problèmes et des compétences en gestion des infirmières.

Le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers[1] et le Comité consultatif des ressources humaines en santé[340] ont recommandé la création de groupes consultatifs de soutien pour les infirmières qui occupent ces rôles en matière de politiques. Ces groupes sont importants pour obtenir la contribution d'une vaste gamme d'intervenants dans le but d'offrir des conseils à l'infirmière en chef et au gouvernement afin de commencer à façonner les politiques. De plus, les comités consultatifs discutent du lieu de travail, des problèmes de main-d'œuvre, des stratégies et de la planification des ressources humaines. Maslove et Fooks[270] ont rapporté que toutes les provinces canadiennes ont un comité consultatif sur les soins infirmiers dont les stratégies infirmières sont financées.

Le Bureau fédéral de la politique des soins infirmiers (BPSI) au Canada est chargé de renforcer la présence de la profession infirmière au sein de Santé Canada en contribuant à la création des politiques et à la conception des programmes dans l'ensemble du ministère, et en travaillant aussi étroitement avec le milieu des soins infirmiers afin de développer des conseils à l'intention du gouvernement[341]. Le BPSI offre un mécanisme de liaison pour les infirmières en chef provinciales et territoriales en coordonnant des réunions afin de discuter des questions prioritaires en soins infirmiers. Ensemble, les leaders en soins infirmiers supérieurs fédéraux et juridictionnels discutent des nouvelles données probantes et les lient aux questions prioritaires en soins infirmiers afin de recommander des politiques et des stratégies basées sur les meilleures données probantes possibles.

**4.4** Les gouvernements mettent en œuvre un programme de recherche en leadership infirmier et le maintiennent.

## Discussion sur les données probantes[29]

Les données probantes qui sont facilement accessibles et peuvent être directement mises en pratique présentent un important défi pour la recherche en science de la santé[342]. Les interventions abordées dans le cadre d'études individuelles dans des conditions précises peuvent ne pas être vues par les utilisateurs finaux comme étant applicables dans tous les milieux. Par conséquent, on a suggéré qu'elles soient reproduites dans les populations et les milieux[342]. Daly et coll.[343] laissent entendre que pour que les études de recherche soient significatives, il faut tenir compte de tous les éléments du milieu de pratique. Ils recommandent que la meilleure façon d'y arriver soit d'effectuer des études séquentielles qui se fondent et se développent à partir des résultats des études précédentes, comme cela se produirait dans un programme de recherche.

À l'aide d'une série d'études cliniques, Daly et coll.[343] ont découvert qu'un programme d'étude offrait un aperçu plus général des variables d'intérêt. Ils ont remarqué que le fait de commencer par une étude descriptive pour passer à une étude d'intervention dans le cadre d'un programme de recherche permettait l'évaluation des hypothèses à l'aide des variables et des mesures appropriées mentionnées dans les études descriptives précédentes. Ils ont découvert que lorsque leur équipe de recherche se concentrait sur un domaine cible, elle pouvait parfaire sa compréhension des phénomènes d'intérêt, des mesures valides et de la documentation pertinente, et de découvrir des considérations pratiques pour la conception d'études ultérieures. Ils ont rapporté que, dans le cas de la recherche, l'approche de type programme a entraîné une hausse de la confiance face aux observations et a aidé à éviter l'attribution incorrecte de la cause à une variable lorsqu'elle était étudiée dans un seul contexte.

Antrobus et Kitson[126] ont reconnu la nécessité d'un programme de recherche en soins infirmiers. Ils ont constaté que l'étude du leadership soulevait des questions internes sur la nature et l'objectif du leadership et sur les caractéristiques de leadership et le développement des besoins des futurs leaders. Ils recommandent un examen des facteurs sociopolitiques plus généraux qui influencent le leadership et de la façon dont les leaders en soins infirmiers façonnent les politiques.

## Recommandations aux chercheurs

| 5.0 | Les chercheurs collaborent avec les gouvernements, les établissements d'enseignement et les organismes de services de santé afin de mener des recherches en leadership infirmier. |
|---|---|

La Fondation canadienne de la recherche sur les services de soins de santé (FCRSS)[344] a déclaré que la gestion des ressources humaines en soins infirmiers et les autres questions liées au lieu de travail sont d'une importance capitale pour les soins infirmiers. Elle a mentionné qu'une consultation récente auprès d'infirmières a établi la nécessité de compter sur des stratégies pour aborder les différences générationnelles liées aux exigences en ce qui concerne l'équilibre vie professionnelle-personnelle, l'emploi à temps plein, la formation et le mentorat, afin d'appuyer la transition des nouvelles infirmières vers le milieu de travail. Elle a aussi remarqué que le fondement du leadership infirmier, des thèmes des politiques et de la recherche en soins infirmiers réfléchit l'importance de la contribution des infirmières aux soins de santé. Le fonds de recherche en sciences infirmières a été créé en réponse au lobbying des infirmières et des groupes infirmiers. Il est conçu pour appuyer la recherche sur le recrutement et le maintien en poste, la gestion et les problèmes découlant de la restructuration. La FCRSS et l'Institut de recherche en santé Canada (IRSC) financent des projets de recherche, des bourses, des chaires de recherche, des centres de formation et des synthèses de politiques sur les problèmes de ressources humaines en soins infirmiers[270]. Un rapport récent sur le progrès des recommandations du Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers a mentionné la nécessité de faire davantage d'études relatives aux résultats économiques et à la santé et à la traduction des données probantes en un langage que les décideurs dans des rôles administratifs et en matière de politique comprendront, tout comme le public[270].

| 5.1 | Ils effectuent des recherches sur les répercussions du leadership infirmier sur les infirmières, les patients et les résultats organisationnels et du système. |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[30]

Le leadership est essentiel au milieu de travail des infirmières et de leurs leaders qui subissent une pression constante quant au rendement puisque les organisations mettent davantage l'accent sur la gestion des coûts[48, 83]. Patrick et White[50] ont mentionné la nécessité de faire davantage de recherches sur la relation entre les comportements de leadership infirmier et les résultats auprès des patients et des infirmières afin d'obtenir la reconnaissance de la contribution des soins infirmiers aux soins aux patients-clients. Ils ont constaté que la majorité des travaux publiés sont descriptifs et qu'il n'y a que peu d'études expérimentales.

| 5.2 | Ils développent, mettent en œuvre et évaluent une intervention de leadership basée sur le modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership (Figure 2, p. XX). |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[31]

Même si le rapport de l'Institute of Medicine[48] en 2004 affirme que les gestionnaires, tout comme leurs collègues cliniques, devraient « tenter de trouver et d'appliquer les données probantes empiriques provenant de la gestion de la recherche de leur pratique », il mentionne de nombreux obstacles. La nature de la gestion de la prise de décision est telle que les décisions sont souvent prises par les groupes et supposent des négociations ou des compromis et des contraintes organisationnelles[207]. De plus, la formation à l'intention des gestionnaires sur l'utilisation des données probantes n'est pas aussi constante qu'elle ne l'est pour les professionnels de la santé[207, 345]. Dans une étude du rôle de l'infirmière gestionnaire dans le cadre d'une pratique basée sur les données probantes menée par Udod et Care[209], les participants ont indiqué un fossé entre leurs connaissances liées à la recherche et l'utilisation de la recherche.

Non seulement la recherche sur la gestion des soins de santé est-elle limitée par le financement reçu comparativement à la gestion de la recherche dans d'autres industries, mais de nombreuses organisations n'ont pas la taille ni les ressources suffisantes, ni les systèmes de données adéquats, pour effectuer et évaluer la recherche appliquée[119, 205]. La recherche financée par d'importants systèmes de santé a été considérée privée et n'a pas fait l'objet d'un partage à grande échelle[205]. En fin de compte, les données probantes sur les pratiques de gestion efficaces sont difficiles à trouver, à examiner et à synthétiser en raison d'une mauvaise indexation[205].

**5.3** Ils effectuent des recherches sur la planification des ressources humaines en santé pour les rôles de leadership infirmier.

## Discussion sur les données probantes[32]

La planification efficace des ressources humaines en santé est d'une importance capitale dans le milieu de changement actuel[346]. La suppression des postes de gestion qui a eu lieu entre 1994 et 2002 au Canada[33] à 35 a entraîné un contrôle plus vaste pour les leaders en soins infirmiers et moins d'appuis pour les infirmières[9, 284]. La planification des ressources humaines doit inclure la planification des rôles de leadership infirmier basée sur des données valides. La Nursing Workforce Study[340] a fait état de nombreuses faiblesses dans les bases de données nationales, notamment le fait que plusieurs questions sur les politiques concernant la pénurie d'infirmières sont toujours sans réponse. De plus, ils ont recommandé que les recherches sur la planification des ressources humaines aillent plus loin que les modèles de dotation et examinent une variété de besoins au sein des juridictions afin de permettre la planification du système. Cette recommandation a été réitérée par Baumann et coll.[9] qui ont recommandé le développement de bases de données du marché du travail et d'outils de prévision pour les ressources humaines.

**5.4** Ils mènent des recherches sur l'enseignement et le développement du leadership infirmier.

## Discussion sur les données probantes[33]

Des données probantes démontrent que les relations des infirmières avec le superviseur immédiat sont un indice important de la satisfaction au travail et de l'intention de rester en poste[347 à 349]. Thomson et coll.[349] ont constaté « qu'au moment où les infirmières ont le plus besoin de leadership, le cadre se resserre; laissant les infirmières avec peu de soutien quotidien et un accès réduit à ceux qui occupent un poste favorable dans la hiérarchie pour parler en leur nom » (traduction, p. 26). Même si Patrick et White[50] indiquent qu'il est difficile de mettre en pratique les théories sur le leadership, ils concèdent que les interventions éducatives peuvent accroître les comportements de leadership. Tourangeau et coll.[306] ont découvert qu'un programme de leadership résidentiel concentré peut renforcer les comportements de leadership chez les leaders en soins infirmiers, tant chez ceux qui sont en poste que chez les nouveaux.

Dans une métaanalyse de la recherche au sujet des effets des programmes de développement du leadership de direction, Collins et Holton[316] ont découvert qu'il y avait une tendance émergente en ce qui concerne le leadership transformationnel, mais ils n'ont pratiquement rien trouvé en ce qui concerne la formation ou les résultats. De plus, ils ont constaté que peu d'études empiriques évaluent les résultats des interventions telles que l'encadrement, le mentorat ou la rétroaction sur les interventions. Ces auteurs reconnaissent la nécessité de faire un suivi du rendement des investissements des programmes de développement du leadership. Davantage de recherches dans ce domaine doivent aborder les soutiens et les obstacles à l'intérêt et au succès des rôles de leadership, ainsi que les outils d'évaluation qui touchent le leadership en soins infirmiers et le rendement.

## Recommandations aux organismes d'agrément

| | |
|---|---|
| **6.0** | Les organismes d'agrément des services de santé et les établissements d'enseignement intègrent dans leurs normes les recommandations relatives au soutien organisationnel contenues dans cette ligne directrice |

### Discussion sur les données probantes[34]

Il a été prouvé que la qualité du leadership infirmier détermine la qualité des milieux de travail dans lesquels les infirmières offrent des soins[36, 88, 264]. Clifford[36] reconnaît la nécessité de définir les devoirs et les responsabilités du rôle de leader principal en soins infirmiers au sein des organismes de services de santé en tant que fonction définie et standard, notamment la responsabilité des soins infirmiers au niveau de la direction. Le fait de pouvoir compter sur une infirmière dans un rôle influent et supérieur au sein d'une organisation de services de santé est un critère à l'agrémentation des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier; ce critère a été associé à des résultats positifs dans de nombreuses études. La Joint Commission on Accreditation of Health care Organizations, aux États-Unis, exige que les services de soins infirmiers soient dirigés par une infirmière en chef qui a fait des études supérieures et qui possède de l'expérience en gestion, qui a la responsabilité d'instaurer et d'approuver les normes de la pratique, les politiques et les procédures en soins infirmiers et qui participe aux activités d'amélioration à l'échelle de l'organisation[350].

## Recommandations relatives à la formation

| | |
|---|---|
| **7.0** | Les programmes de formation offrent des possibilités de développement du leadership, formelles ou non, pour les infirmières. |

### Discussion sur les données probantes[35]

Les compétences en leadership sont nécessaires dans tous les domaines et les rôles des soins infirmiers. Le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers[1] a remarqué qu'il n'y a pas assez d'infirmières promues à des postes de gestion et de leadership. Traditionnellement, les leaders en soins infirmiers étaient promus à partir des rangs du personnel auxiliaire, généralement en se basant sur un rendement clinique supérieur et en mettant moins l'accent sur la capacité à diriger. Après avoir étudié les caractéristiques souhaitées chez les leaders auprès d'une population d'infirmières et d'étudiants âgés de moins de 35 ans, Wieck et coll.[110] ont conclut qu'à cause de l'accent mis sur les occasions d'affaires, l'emploi à court terme et l'équilibre vie professionnelle-personnelle, ces personnes peuvent ne pas être attirées par de longues carrières en soins de santé et particulièrement par des postes de leadership en soins infirmiers. Ces auteurs laissent entendre la nécessité d'établir les comportements de leadership privilégiés qui peuvent être mis en application dans les modèles de pratique exemplaire pour les éducateurs et les gestionnaires des infirmières plus jeunes. Même si les infirmières plus jeunes ont des attentes différentes des leaders, on remarque une cohérence avec le point de vue des infirmières plus âgées, ce qui signifie que le mentorat des futurs leaders en soins infirmiers par les leaders en soins infirmiers expérimentés demeure une stratégie viable. De nombreux rapports ont reconnu qu'il est nécessaire de disposer de plus de possibilités de développement du

leadership pour les infirmières[1,9]. Maslove et Fooks[271] ont constaté que même si des programmes de développement du leadership étaient disponibles pour les infirmières une fois qu'elles sont gestionnaires, peu de programmes sont disponibles pour le personnel de première ligne.

L'article de synthèse de Kilty[46] sur le développement du leadership infirmier au Canada détaille les ressources et les programmes disponibles liés au développement du leadership infirmier. L'article rapporte que plusieurs programmes de premier cycle en soins infirmiers incluent des cours spécifiques au leadership ou des cours de gestion, généralement donnés en troisième ou quatrième année. Alors que peu d'universités offrent des certificats ou des programmes postscolaires en leadership et en gestion à l'intention des infirmières et des autres leaders en soins de santé, on compte peu d'universités qui mettent un accent spécifique sur le leadership infirmier au niveau de la maîtrise. Actuellement, seul le Dorothy M. Wylie Nursing Leadership Institute aborde le développement du leadership infirmier au Canada[351].

Un programme de leadership pour les infirmières soignantes, étudié sur une période de quatre ans, qui utilisait le jeu de rôles, la rétroaction et les mentors et qui a été lié aux objectifs personnels et à l'examen du rendement, a démontré des changements positifs dans les comportements de leadership des infirmières. Les patients-clients et les familles ont rapporté une plus grande confiance et davantage de satisfaction face aux soins. Les infirmières ont affirmé avoir obtenir une croissance personnelle, une confiance en soi et une assurance accrues. Elles se perçoivent comme plus efficaces, mieux organisées et plus habilitées. Elles ont rapporté percevoir de meilleures relations avec les collègues et un meilleur travail d'équipe, des aptitudes de négociation accrues de même qu'une responsabilisation et une conscience améliorées du système de santé en général[307].

Cunningham et Kitson[309, 310] ont évalué un programme de développement du leadership clinique dont l'objectif est pratique, expérientiel et basé sur le travail, et où l'accent est mis sur l'acquisition de compétences et d'attitudes, des valeurs et des comportements nécessaires au développement de leaders. Le leadership transformationnel a été choisi comme le style de leadership le plus approprié. Les résultats du programme ont démontré une hausse de la capacité du leadership grâce à l'autoévaluation et aux rapports de fin de service du personnel, à une meilleure approche des soins axée sur les patients et à une confiance accrue envers les leaders.

| 7.1 | Les programmes de leadership infirmier intègrent des concepts clés du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership infirmier (Figure 2, p. 16). |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[36]

Selon la documentation étudiée pour cette ligne directrice et l'opinion générale du groupe d'experts, les concepts clés suivants sont des éléments constitutifs essentiels au développement et au maintien du leadership en soins infirmiers.

**Au niveau du système en général :**

- **Le système de santé canadien, y compris les facteurs sociaux, économiques et politiques qui influent sur ce système à l'échelon national, provincial et régional;**
- **Le processus politique, y compris la persuasion politique et l'influence des infirmières à tous les niveaux de la gouvernance;**
- **Le développement historique des professions reliées à la santé dans leurs interactions avec le développement de la profession infirmière et dans leur influence;**
- **La mise en place de politiques en matière de santé et de politiques sociales[126] et la réforme au niveau national, provincial et local;**
- **Les approches actuelles des modèles de prestation de services de santé (p. ex., soins gérés, concurrence gérée);**
- **Les rôles des organisations professionnelles et leur influence sur les infirmières et la prestation du service;**
- **Les problèmes actuels et émergents ainsi que les priorités et les politiques en matière de soins de santé.**

**Au niveau organisationnel :**

- **La théorie organisationnelle et son application aux systèmes de prestation des services de santé;**
- **Les systèmes de prestation des services de santé, y compris les soins gérés et la concurrence gérée;**
- **Les modèles de gouvernance, particulièrement la gouvernance partagée et l'habilitation;**
- **Les modèles de charge de travail en soins infirmiers et l'amélioration continue de la qualité;**
- **Les modèles de prise de décision, y compris les cadres éthiques[239];**
- **Le cadre légal pour la pratique des soins infirmiers;**
- **Les concepts financiers et budgétaires;**
- **Les influences culturelles sur les styles de leadership.**

**Au niveau du point de service :**

- **La relation entre l'acquisition et la diffusion des connaissances et l'habilitation;**
- **La communication efficace avec les individus, les groupes, les familles et les stratégies de promotion du travail d'équipe.**

| 7.2 | Les programmes de leadership infirmier qui sont offerts dans le cadre de l'enseignement de premier cycle, de deuxième cycle et de la formation professionnelle continue incluent des possibilités formelles ou non d'expérience en leadership. |
|---|---|

## Discussion sur les données probantes[37]

Les programmes de développement du leadership formels ont fait état de résultats positifs. Collins[200] a effectué une métaanalyse des programmes de leadership de direction de 1982 à 2002 et a découvert que la formation formelle était efficace sur le plan des résultats concernant les connaissances, mais que les effets des résultats organisationnels ne sont pas connus. Dans le cadre de l'évaluation d'un programme de leadership d'infirmière gestionnaire, Wolf[308] a trouvé des résultats semblables et a reconnu que les participants doivent avoir davantage d'occasions de mettre leurs nouvelles compétences en application et qu'il faut définir les résultats organisationnels à long terme.

### Planifier le succès – Stratégies suggérées

- Soutenir les demandes et l'attribution des bourses de recherche en pratique et clinique avancée de l'AIIAO.
- Inclure une composante de stage en leadership dans l'enseignement de base, postscolaire et de deuxième cycle universitaire.
- Concevoir des séances de formation en leadership et faire en sorte qu'un mentor et une personne encadrée y participent ensemble.
- Planifier des groupes de discussion et de soutien à l'intention des nouveaux leaders ou des nouvelles personnes qui participent aux changements ou aux nouveaux projets et au sein desquels les leaders expérimentés partagent leurs stratégies et idées.

# Processus de mise à jour et de révision des lignes directrices pour les milieux de travail sains

**L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario** propose de mettre à jour les Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains en procédant comme suit :

1. Chaque ligne directrice sur la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains sera révisée par une équipe de spécialistes du domaine (équipe de révision) tous les cinq ans suivant la dernière série de révisions.

2. Pendant la période entre la préparation et la révision, le personnel affecté au programme des Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains de l'AIIAO effectuera un suivi régulier des examens systématiques et des essais contrôlés aléatoires dans le domaine.

3. Selon les résultats obtenus, le personnel affecté au programme peut recommander de devancer la date de la période de révision. Une consultation adéquate auprès d'une équipe formée de membres du groupe original et d'autres spécialistes du domaine apportera leur point de vue afin de prendre la décision d'examiner et de réviser, ou non, la ligne directrice avant l'échéance de cinq ans.

4. Six mois avant l'échéance de révision de cinq ans, le personnel affecté au projet commencera la planification du processus de révision comme suit :

   a) Invitation de spécialistes du domaine à se joindre à l'équipe de révision qui sera formée de membres du groupe original et d'autres spécialistes recommandés.
   b) Compilation des commentaires reçus, des questions rencontrées pendant l'étape de diffusion, ainsi que d'autres commentaires et expériences provenant des sites de mise en place.
   c) Compilation de la documentation pertinente.
   d) Établissement d'un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.

5. La nouvelle version des lignes directrices sera diffusée selon les structures et les processus établis.

# Évaluation et surveillance du développement et du maintien de la ligne directrice sur le leadership infirmier

**Nous encourageons les établissements qui mettent en place les recommandations** de la ligne directrice *sur le maintien et le développement et le maintien du leadership infirmier* à tenir compte de la façon dont la mise en place et ses influences seront surveillées et évaluées. Le tableau suivant, inspiré du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership (tableau 2, p. 22), présente des exemples d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation. Plusieurs d'entre eux peuvent être mesurés à l'aide d'une ou de plusieurs mesures de concepts liées au modèle de leadership tel qu'énoncé dans l'inventaire de ces mesures à l'annexe D.

| NIVEAU DE L'INDICATEUR | STRUCTURE | PROCESSUS | RÉSULTAT | MESURE |
|---|---|---|---|---|
| Objectifs | Évaluer le soutien organisationnel qui permet aux infirmières de développer et de mettre en application des pratiques de leadership efficaces, et aux patients d'en expérimenter les effets. | Évaluer les processus de leadership organisationnel et les comportements de leadership liés aux cinq pratiques de leadership. | Évaluer les influences de la mise en place des recommandations de la ligne directrice sur tous les plans. | Mesurer et surveiller les indicateurs de structure, les processus et les résultats. |
| Organisation – service | Projets spécifiques au sein de l'organisation pour la mise en place de la ligne directrice sur le leadership<br><br>Les structures conformes aux recommandations liées au soutien organisationnel sont évidentes dans l'organisation, notamment :<br>• Une infirmière dans un poste de cadre supérieur référence 2.2.a<br>• Infirmières qui occupent un rôle de gestionnaire de première ligne là où on prodigue des services primaires en soins infirmiers<br>• Ampleur du contrôle des gestionnaires<br>• Exercice du pouvoir partagé par l'entremise des comités d'exercice de gouvernance partagée des soins infirmier<br>• Programmes d'orientation et de préceptorat qui sont complets et qui sont adaptés aux besoins des nouvelles infirmières | Mettre en place et utiliser des mécanismes de communication comme :<br>• Lettres d'information<br>• Discussions ouvertes<br>• Accès aux courriels<br><br>Outils de mesure de la charge de travail en place et utilisés de façon appropriée pour planifier la dotation<br><br>Systèmes de suivi des résultats du leadership efficace mis en place et en pratique, par exemple :<br>• Satisfaction des infirmières<br>• Congés pour maladie<br>• Rotation du personnel<br>• Durée de vacance<br><br>Formation continue favorisée par le soutien à la scolarité et les effectifs conciliants<br><br>Planification de la relève pour rendre le leadership possible | Résultats organisationnels tels que :<br>• Taux de roulement<br>• Congés pour maladie<br>• Stabilité du leadership du personnel<br>• Taux de conservation | Statistiques sur les ressources humaines, ligne de départ et tendances au fil du temps en fonction du nombre d'infirmières gestionnaires par rapport au nombre de membres du personnel, du taux de roulement, des congés pour maladie dans tous les rôles<br><br>Échelle du roulement prévu (Hinshaw et Atwood)<br><br>Sondage sur l'évaluation des soins infirmiers (Maehr et Braskamp)<br><br>Outil d'évaluation culturel des soins infirmiers de l'unité (Coeling et Simms)<br><br>Indice du travail infirmier (Aiken et Patrician)<br><br>Le modèle de l'Hôpital d'Ottawa sur les indicateurs de l'étendue des responsabilités des gestionnaires cliniques en |

| NIVEAU DE L'INDICATEUR | STRUCTURE | PROCESSUS | RÉSULTAT | MESURE |
|---|---|---|---|---|
| Organisation – service | • Accès aux programmes de développement du leadership<br>• Partenariats avec des établissements de formation pour fournir le perfectionnement en leadership<br>• Descriptions des rôles qui comprennent les attentes concernant les comportements de leadership | | | matière de prise de décisions (Hôpital d'Ottawa)<br><br>Nombre de personnes aux études supérieures<br><br>Financement de la formation continue<br><br>Échelle NWI du milieu de pratique (Lake)<br><br>Échelle du milieu de pratique professionnelle (Erickson et coll.)<br><br>Indice des milieux de travail canadiens (Estabrooks et coll.)<br><br>Milieu de travail infirmier perçu (Choi et coll.) |
| Leaders en soins infirmiers | Disponibilité de la formation et du soutien aux infirmières gestionnaires et aux infirmières gestionnaires postulantes dans tous les rôles<br><br>Nombre d'infirmières qui ont accès à des possibilités de leadership<br><br>Nombre d'infirmières qui ont accès au soutien et à la formation en leadership | Les infirmières, peu importe leur rôle, montrent des compétences en leadership liées aux cinq pratiques en leadership attestées par les comportements associés tel que décrit par la ligne directrice.<br><br>Évaluer régulièrement le rendement, incluant l'auto-évaluation.<br><br>Les comportements de leadership sont évalués dans le cadre de l'évaluation du rendement. | Résultats auprès des infirmières tels que :<br>• Satisfaction des infirmières<br>• Épuisement<br>• Motivation<br>• Engagement envers l'organisation<br><br>Résultats auprès des étudiantes tels que :<br>• Évaluation de la qualité de l'expérience d'apprentissage<br>• Satisfaction concernant les soins infirmiers et l'apprentissage | • Questionnaire sur la description du climat organisationnel des infirmières (Duxbury et coll.)<br>• Questionnaire de description du comportement de leadership (Stogdill)<br>• Inventaire des pratiques de leadership (Kouzes et Posner)<br>• Styles de leadership de soutien – Échelle de soutien de l'infirmière responsable et échelle de soutien du gestionnaire du service (McGilton et coll.)<br>• Échelle à six dimensions (6D) du rendement infirmier (Schwirian)<br>• Inventaire de l'épuisement professionnel de Maslach (Maslach et Jackson)<br>• Indice de la satisfaction au travail des infirmières (Stamps et Piedmonte)<br>• Questionnaire sur l'engagement envers l'organisation (Porter et coll.)<br>• Échelle de satisfaction au travail des infirmières (Hinshaw et Atwood) |

| NIVEAU DE L'INDICATEUR | STRUCTURE | PROCESSUS | RÉSULTAT | MESURE |
|---|---|---|---|---|
| Patient-client | Les programmes d'amélioration de la qualité sont en place. | Surveillance continue des effets des décisions des gestionnaires sur les patients-clients, de l'attribution des ressources et de la qualité.<br><br>Les processus en ce qui concerne la rétroaction des clients au sujet des résultats sur les soins sont expliqués aux patients et sont accessibles, | Satisfaction du patient concernant les soins infirmiers<br><br>Rétroaction du patient au sujet des soins infirmiers documentée.<br><br>Nombre de problèmes non résolus concernant les patients | Questionnaire sur la satisfaction en ce qui concerne les soins de santé (Eriksen) |
| Finances | | | Économies – recrutement et maintien en poste<br><br>Économies – congés pour maladie<br><br>Économies – temps supplémentaire | |

# Références numérotées

1. Canadian Nursing Advisory Committee. (2002). *Our health, our future: Creating quality workplaces for Canadian nurses.* Ottawa, ON: Advisory Committee on Health Human Resources.

2. Registered Nurses Association of Ontario and the Registered Practical Nurses Association of Ontario. (2000). *Ensuring the care will be there – Report on nursing recruitment and retention in Ontario*. Toronto, ON: Author.

3. Griffin, P., El-Jardali, F., Tucker, D., Grinspun, D., Bajnok, I., & Shamian, J. (2004). *Healthy work environments: Building a conceptual model.* Submitted for publication.

4. Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (2000). First Minister's Meeting Communiqué on Health. News Release. First Ministers' Meeting Ottawa, ON: September 11, 2000.

5. Health Canada 2003 First Ministers' Accord on Health Care Renewal. Retrieved May 5, 2005 from: www.healthservices.gov.bc.ca/ bchealth care/publications/health_accord.pdf

6. First Ministers' Meeting on the Future of Health Care (2004). Retrieved from Nov 2004 – June 2005: http://www.hc-sc.gc.ca/english/hca2003/fmm/index.html

7. Council of Ontario University Programs in Nursing. (2002). *Position statement on nursing clinical education*. Toronto, ON: Author.

8. Canadian Nurses Association. (2002). *Planning for the future: Nursing human resource projections.* Ottawa, ON: Author

9. Bauman, A., O'Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., et al. (2001). *Commitment and care – The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients and the system.* Ottawa, ON: Canadian Health Services Research Foundation and The Change Foundation.

10. Association of Colleges of Applied Arts and Technology. (2001). *The 2001 environmental scan for the Association of Colleges of Applied Arts and Technology of Ontario*. Toronto, ON: Author.

11. Nursing Task Force. (1999). *Good nursing, good health: An investment for the 21st century*. Toronto, ON: Ontario Ministry of Health and Long-Term Care.

12. Shindul-Rothschild, J. (1994). Restructuring, redesign, rationing and nurses' morale: A qualitative study of the impact of competitive financing. *Journal of Emergency Nursing,* 20(6), 497-504.

13. Grinspun, D. (2000). Taking care of the bottom line: Shifting paradigms in hospital management. In D.L. Gustafson (Ed.), *Care and consequences.* Halifax, NS: Fernwood Publishing.

14. Grinspun, D. (2000). *The social construction of nursing caring*. Doctoral dissertation proposal. Toronto, ON: York University.

15. Dunleavy, J., Shamian, J., Thomson, D. (2003). Workplace pressures: Handcuffed by cutbacks. *Canadian Nurse,* 99(3), 23-26.

16. Dugan, J., Lauer, E., Bouquot, Z., Dutro, B., Smith, M., & Widmeyer, G. (1996). Stressful nurses: The effect on patient outcomes. *Journal of Nursing Care Quality,* 10(3), 46–58.

17. Lundstrom, T., Pugliese, G., Bartley, J., Cos, J., & Guither, C. (2002). Organizational and environmental factors that affect worker health and safety and patient outcomes. *American Journal of Infection Control,* 30(2), 93-106.

18. Estabrooks, C., Midodzi, W., Cummings, G., Ricker, K., & Giovannetti, P. (2005). The impact of hospital nursing characteristics on 30-day mortality. *Nursing Research,* 54(2), 74-84.

19. Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M., & Zelevinsky, K. (2002). Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. *New England Journal of Medicine,* 346(22), 1715–1722.

20. Person, S., Allison, J., Kiefe, C., Weaver, M., Williams, O., Centor, R., & Weissman, N. (2004). Nurse staffing and mortality for medicare patients with acute myocardial Infarction. *Medical Care,* 42(1), 4–12.

21. Blegen, M., & Vaughn, T. (1998). A multi-site study of nurse staffing and patient occurrences. *Nursing Economic$,* 16(4), 196–203.

22. Sasichay-Akkadechanunt, T., Scalzi, C., & Jawad, A. (2003). The relationship between nurse staffing and patient outcomes. *Journal of Nursing Administration,* 23(9), 478–85.

23. Tourangeau, A., Giovannetti, P., Tu, J., & Wood, M. (2002). Nursing-related determinants of 30-day mortality for hospitalized patients. *Canadian Journal of Nursing Research*, 33(4), 71-88.

24. Needleman, J., & Buerhaus, P. (2003). Nurse staffing and patient safety: Current knowledge and implications for action.(editorial). *International Journal for Quality in Health Care,* 15(4), 275-77.

25. American Nurses Association. (2000). *Nurse staffing and patient outcomes in the inpatient hospital setting*. Washington, DC: American Nurses Publishing.

26. Kovner, C., & Gergen, P. (1998). Nurse staffing levels and adverse events following surgery in US hospitals. *Image: Journal of Nursing Scholarship,* 30(4), 315-321.

27. Sovie, M., & Jawad, A. (2001). Hospital restructuring and its impact on outcomes. *Journal of Nursing Administration,* 31(12), 588–600.

28. Yang, K. (2003). Relationships between nurse staffing and patient outcomes. *Journal of Nursing Research,* 11(3), 149–58.

29. Cho, S., Ketefian, S., Barkauskas, V., & Smith, D. (2003). The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality and medical costs. *Nursing Research,* 52(2), 71–79.

30. Aldana, S. (2001). Financial impact of health promotion programs: A comprehensive review of the literature. *American Journal of Health Promotion*, 15(5), 296-320.

31. United States Agency for Health care Research and Quality. (2003). *The effect of health care working conditions on patient safety.* Summary, evidence report /technology assessment. Number 74. Rockville, MD

32. Lowe, G. (2004*). Thriving on healthy: Reaping the benefits in our workplaces.* Keynote presentation at the RNAO 4th Annual International Conference – Healthy Workplaces in Action 2004: Thriving in Challenge. 17 November 2004, Markham, ON

33. Canadian Institute for Health Information. (2001). *Supply and distribution of Registered Nurses in Canada, 2000.* Ottawa, ON: Author.

34. Canadian Institute for Health Information. (2002). *Supply and distribution of Registered Nurses in Canada, 2001.* Ottawa, ON: Author.

35. Canadian Institute for Health Information. (2002). *Workforce trends of Registered Nurses in Canada, 2002*. Ottawa, ON: Author.

36. Clifford, J. (1998). *Restructuring: The Impact of hospital organization on nursing leadership.* San Francisco, CA: American Hospital Association.

37. *Foley, R., & Wurmser, TA. (2004). Culture Diversity/A Mobile Workforce Command Creative Leadership, New Partnerships, and Innovative Approaches to Integration. Nursing Administration Quarterly. Reconstructing Healthcare in a Global Marketplace. 28(2) 122-128.*

38. Ferguson-Paré, M., Mitchell, G., Perkin, K., & Stevenson, L. (2002). Academy of Canadian Executive Nurses (ACEN) background paper on leadership. *Canadian Journal of Nursing Leadership, 15(3), 4-8.*

39. Squires A. (2004). A dimensional analysis of role enactment of acute care nurses. *Journal of Nursing Scholarship, 3 (36) 272-8.*

40. Kramer, M., & Schmalenberg, C. (1988). Magnet hospitals – Part I: Institutions of excellence. *Journal of Nursing Administration. 18(1), 13-24.*

41. Kramer, M., & Schmalenberg, C. (1988). Magnet hospitals – Part II: Institutions of excellence. *Journal of Nursing Administration. 18(2), 1-11.*

42. McClure, M., Poulin, M., Sovie, M., & Wandelt, M. (2002). *Magnet hospitals: Attraction and retention of professional nurses (The Original Study)*. In M. McClure M., Hinshaw, A. (Eds.), *Magnet hospitals revisited.* Washington, DC: American Academy of Nurses.

43. Aiken, L., Smith, H., & Lake, E. (1994). Lower Medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care. *Medical Care*, 32(5), 771-787.

44. Boyle SM. (2004). Nursing unit characteristics and patient outcomes. *Nursing Economics* 3(22) 111-9.

45. Romanow, R., (2002). *Building on values: The future of health care in Canada*. Ottawa, ON: Government of Canada.

46. Kilty, H. (2003). *Nursing leadership development in Canada. A descriptive status report and analysis of leadership programs, approaches and strategies: Domains and competencies; knowledge and skills; gaps and opportunities.* Ottawa, ON: Canadian Nurses Association.

47. Canadian Health Services Research Foundation (2004). *Listening for direction II. National consultation on health services and policy issues for 2004-2007*. Ottawa, ON: Author.

48. Institute of Medicine of the National Academies, Board on Health Care Services. (2004). *Keeping patients safe: Transforming the work environment of nurses.* Washington, DC: National Academy Press.

49. Stordeur, S., Vandenbergeh, C. & D'hoore, W. (2000). Leadership styles across hierarchical levels in nursing departments. *Nursing Research* 49(1), 37-43.

50. Patrick, A., & White, P. (2005). Scope of nursing leadership. *In L. McGillis Hall (Ed.), Quality work environments for nurse and patient safety.* Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

51. Moynihan, R. (2004). *Evaluating health services*: *A reporter covers the science of research synthesis.* Millbank Memorial Fund. Retrieved November 22, 2004 from: http://www.milbank.org/reports/2004Moynihan/Moynihan.pdf

52. Pearson, A., Laschinger, H., Porritt, K., Jordan, Z., Tucker, D., & Long, L. (2004). *A comprehensive systematic review of evidence on developing and sustaining nursing leadership that fosters a healthy work environment in health care. Health Care Reports*. Adelaide, Australia: The Joanna Briggs Institute.

53. Cochrane Collaboration. *Cochrane and systematic reviews: Levels of evidence for health care interventions.* Retrieved May 7, 2005 from: http://www.cochrane.org/consumers/sysrev.htm#levels

54. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. *Levels of evidence and grades of recommendation in:* A guideline developers' handbook. *Retrieved May 7, 2005 from:* http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/section6.html#2

55. Altieri, L. (1995). *Transformational and transactional leadership in hospital nurse executives in the commonwealth of Pennsylvania: A descriptive study*. Doctoral dissertation. Fairfax, VA: George Mason University.

56. Boumans, N., & Landeweerd, J. (1993). Leadership in the nursing unit: Relationships with nurses' well being. *Journal of Advanced Nursing*. 18(5), 767-775.

57. Chiok Foong Loke, J. (2001). Leadership behaviours: Effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. *Journal of Nursing Management*. 9(4), 191-204.

58. McGilton, K., McGillis Hall, L., Pringle, D., O'Brien-Pallas, L., & Krejci, J. (2004). *Monograph.* Toronto, ON: University of Toronto Faculty of Nursing and Toronto Rehabilitation Institute.

59. McDaniel, C., & Wolf, G. (1992). Transformational leadership in nursing service. A test of theory. *Journal of Nursing Administration*. 22(2), 60-65.

60. McNeese-Smith, D. (1997). The influence of manager behaviour on nurses' job satisfaction, productivity, and commitment. *Journal of Nursing Administration*. 27(9), 47-55.

61. Medley, F., & Larochelle, D. (1995). Transformational leadership and job satisfaction. *Nursing Management*. 26(9), 64JJ-LL, 64NN.

62. Morrison, R., Jones, L., & Fuller, B. (1997). The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. *Journal of Nursing Administration*. 27(5), 27-34.

63. Peck, M. (1988). *Head nurse fit with staff, administration, and situation: Impact on unit performance and staff satisfaction.* Doctoral dissertation. University of Utah.

64. Cummings, G., Hayduk, L., & Estabrooks, C. (2005). Mitigating the impact of hospital restructuring on nurses: the responsibility of emotionally intelligent leadership. *Nursing Research.* 2(54) 2-12.

65. McCutcheon, A. (2004). *The relationship between span of control, leadership and performance.* Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto.

66. Long, J. (2004). *Factors that influence nurse attrition: An analysis of the relationship between supervisor leadership style and subordinate job satisfaction*. Doctoral dissertation. Capella University.

67. Robertson, K. (1991). *Registered Nurses' perceptions of leadership systems of nurse managers and quality of work life conditions and feelings*. Doctoral dissertation. University of Alabama at Birmingham.

68. Laschinger, H., Wong, C., McMahon, C., & Kaufmann, C. (1999). Leader behaviour impact on staff nurse empowerment, job tension and work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*. 29(5), 28-39.

69. Gullo, S.R., & Gerstle, D.S. (2004). Transformational leadership and hospital restructuring: a descriptive study. *Policy, Politics, & Nursing Practice*. 11(5) 259-66.

70. Kouzes, J., & Posner, B. (1995). *The leadership challenge. How to keep getting extraordinary things done in organizations.* San Francisco, CA: Jossey-Bass.

71. Leach, L.S. (2005). Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. *Journal of Nursing Administration*. 35, 228-37.

72. Avolio, B.J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. (2004) Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behaviour*, 25(8), 951-968.

73. Taunton, R., Boyle, D., Woods, C., Hansen, H., & Bott, M. (1997). Manager leadership and retention of hospital staff nurses. *Western Journal of Nursing Research*. 19(2), 205-226.

74. Dunham-Taylor, J. (1995). Identifying the best in nurse executive leadership, Part 2, interview results. *Journal of Nursing Administration*. 25(7), 24-31.

75. Volk, M., & Lucas, M. (1991). Relationship of management style and anticipated turnover. *Dimensions of Critical Care Nursing*. 10(1), 35-40.

76. Corrigan, P., Lickey, S., Campion, J., & Rashid, F. (2000). Mental health team leadership and consumers' satisfaction and quality of life. *Psychiatric Services*. 51(6), 781-785.

77. Anderson, R., Issel, L., & McDaniel, R., Jr. (2003). Nursing homes as complex adaptive systems: Relationship between management practice and resident outcomes. *Nursing Research*. 52, 12-21.

78. Kemerer, R. (2003). *Leadership: What works in the real health care world*. Healthcare Papers. 4(1), 37-38.

79. Fox, R., Fox, D., & Wells, P. (1999). Performance of first-line management functions on productivity of hospital unit personnel. *Journal of Nursing Administration*. 29(9), 12-18.

80. Pederson, A. (1993). Qualities of the excellent head nurse. *Nursing Administration Quarterly,* 18(1), 40-50.

81. Upenieks, V. (2003). What constitutes effective leadership? *Journal of Nursing Administration*, 33(9), 456-467.

82. Ward, K. (2002). A vision for tomorrow: Transformational nursing leaders. *Nursing Outlook,* 50(3), 121-126.

83. McGillis Hall, L., McGilton, K., Krejci, J., Pringle, D., Johnston, E., Fairley, L., & Brown, M. Enhancing the quality of supportive supervisory behaviour in long-term care facilities. *Journal of Nursing Administration, 35(4), 181-187.*

84. Gasper, J. (1992). *Transformational Leadership: An integrative review of the literature*. Doctoral dissertation, Western Michigan University.

85. Burns, J. (1978). *Leadership*. New York: Harper and Row.

86. Pielstick, C. (1998). The transforming leader: A meta-ethnographic analysis. *Community College Review, 26*(3), 15-35.

87. Levasseur, R. (2004). *The impact of a transforming leadership style on follower performance and satisfaction: A meta-analysis.* Doctoral dissertation. Walden University.

88. Scott, J., Sochalski, J., & Aiken, L. (1999). Review of magnet hospital research: Findings and implications for professional nursing practice. *Journal of Nursing Administration,* 29(1), 9-19.

89. Baird, A., & St-Amand, R. (1995). *Trust within the organization part 2 – Building Trus*t. Retrieved August 27, 2004 from: http://www.psccfp.gc.ca/publications/monogra/mono2_e.htm

90. Laschinger, H. (2004). Hospital nurses' perceptions of respect and organizational justice. *Journal of Nursing Administration*, 34(7/8), 354-364.

91. Cummings, G. G. (2004) Investing relational energy: The hallmark of resonant leadership. *Canadian Journal of Nursing Leadership*. 17(4): 76-87

92. Dirks, K., & Ferrin, D. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for organizational research. *Journal of Applied Psychology,* 87, 611-628.

93. Hood, J., & Smith, H. (1994). Quality of work life in home care: The contribution of leaders' personal concern for staff. *Journal of Nursing Administration*, 24(1), 40-47.

94. Hanna, L. (1999). Lead the way, leader. *Nursing Management*, 30(11), 36-39.

95. Mayer, R., Davis, J., & Schoorman, F., (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.

96. Harvard Business Review. (2001). *Managing Diversity*. Harvard Business School Press.

97. Covey, S.R., (1990). *The 7 Habits of Highly Effective People,* New York: Simon & Schuster.

98. Mishra, A., & Spreitzer, G. (1998). Explaining how survivors respond to downsizing: The roles of trust, empowerment, justice and work redesign. *Academy of Management Review*, 23(3), 567-588.

99. Shea, G. (2001*). Leading change*. In S. Rovin, (Ed.), *Medicine and business: Bridging the gap*. Gaithersburg, MD: Aspen Publications, 33-52.

100. Nespoli, G. (1991). *Staff nurse perceptions of a positive relationship with an appointed first-lime manager who is perceived as a leader*. Doctoral dissertation. Adelphi University.

101. Bunderson, J. (2001). How work ideologies shape the psychological contracts of professional employees: Doctors responses to perceived breach. *Journal of Organizational Behaviour*, 22, 717-741.

102. Rousseau, D., & Tijorwala, S. (1999). What's a good reason to change? Motivated reasoning and social accounts in promoting organizational change. *Journal of Applied Psychology,* 84(4), 514-528.

103. Lewicki, R., & Bunker, B. (1996). *Developing and maintaining trust in work relationships*. In Kramer, R.N., Tyler T.R. (Eds.), *Trust in organizations: Frontiers in theory and research*, pp. 114-139. Thousand Oaks, CA: Sage.

104. Bowman, D. *The five best ways to build – and lose – trust in the workplace*. Retrieved September 24, 2004 from: http://www.ttgconsultants.com/articles/trustworkforce.html

105. Drucker, P. (1990). *Managing the non-profit organization. Principles and practices*. New York: Harper Collins Publishers.

106. King, T. (2000). Paradigms of Canadian nurse managers: Lenses for viewing leadership and management. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 12(1), 15-20.

107. Perra*, B. (2000).* Leadership: The key to quality outcomes*. Nursing Administration Quarterly*, *24(2), 56-61*

108. Mayer, R., & Gavin, M. (1999). *Trust for management and performance: Who minds the shop while the employees watch the boss*? Presented in an interactive paper session at Academy of Management annual meeting, Chicago.

109. Upenieks, V. (2002). What constitutes successful nurse leadership? A qualitative approach utilizing Kanter's theory of organizational behaviour. *Journal of Nursing Administration*, 32(12), 622-632.

110. Wieck, K., Prydun, M., & Walsh, T. (2002). What the emerging workforce wants in its leaders. *Journal of Nursing Scholarship,* 34(3), 283-288.

111. Storr L. (2004). Leading with integrity: a qualitative research study. *Journal of Health Organization & Management,* 18, 415-34.

112. White, B. (2000). *Moral leadership of nurse executives*. Doctoral dissertation. University of Northern Colorado.

113. Ferguson-Paré, M. (1998). Nursing leadership and autonomous professional practice of Registered Nurses. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 11(2), 7-30.

114. Cadman, C., & Brewer, J. (2001). Emotional intelligence: A vital prerequisite for recruitment in nursing. *Journal of Nursing Management*, 9(6), 321-324.

115. Ingersoll, G., Fisher, Ross, B., Soja, M., & Kidd, N. (2001). Employee response to major organizational redesign. *Applied Nursing Research, 14(1), 18-28.*

116. Lageson, C. (2001). *First line nurse manager and quality: Relationship between selected role functions and unit outcomes*. Doctoral dissertation. University of Wisconsin-Milwaukee.

117. Severinsson, E., & Hallbeerg, I. (1996). Clinical supervisors' views of their leadership role in the clinical supervision process within nursing care. *Journal of Advanced Nursing*, 24(1), 151-161.

118. Six, F. (2004). *Trust and trouble: Building interpersonal trust within organizations.* Retrieved November 4, 2004 from: http://hdl.handle.net/1765/1271

119. Walston, S., & Kimberly, J. 1997. Reengineering hospitals: Experience and analysis from the field. *Hospital and Health Services Administration,* 42(2), 143-63.

120. Gillespie, A. & Mann, L. (2004) Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust. *Journal of Managerial Psychology*. 19(6), 588-607.

121. Parsons, M., & Stonestreet, J. (2002). Factors that contribute to nurse manager retention. *Nursing Economic$*, 23(3), 120-126.

122. Skarlicki, D., & Dirks, K. (2002). Leader as a builder of trust. *HR.com June 28, 2002.* Retrieved May 28, 2004 from http://www.olin.wustl.edu/faculty/dirks/HRcom.pdf

123. Registered Nurses Association of British Columbia. (2001). *Nursing leadership and quality care.* Vancouver, BC: Author

124. Severinsson, E. (1996). Nurse supervisors' views of their supervisory styles in clinical supervision: A hermeneutical approach. *Journal of Nursing Management*, 4(4), 191-199.

125. Skinner C., & Spurgeon P. (2005) Valuing empathy and emotional intelligence in health leadership: a study of empathy, leadership behaviour and outcome effectiveness. *Health Services Management Research,* 18, 1-12.

126. Antrobus, S., & Kitson, A. (1999). Nursing leadership: Influencing and shaping health policy and nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 29(3), 746-753.

127. Ray, M., Turkel, M., & Marino, F. (2002). The transformation process for nursing in workforce redevelopment. *Nursing Administration Quarterly,* 26(2), 1-14.

128. Englebart, S. (1993). *The relationship of nurse manager behaviours and characteristics to subordinates' perceptions of the work unit climate*. Doctoral dissertation. Virginia Commonwealth University.

129. Tucker Scott, K . (2004). *Nurses of influence: A paradigm of leadership*. Doctoral dissertation. University of Toronto.

130. Fletcher, C. (2001). Hospital RNs' job satisfaction and dissatisfactions. *Journal of Nursing Administration,* 31(6), 324-31.

131. Bousfield, C. (1997). A phenomenological investigation into the role of the clinical nurse specialist. *Journal of Advanced Nursing*, 25(2), 245-256.

132. Gillert, A., & Chuzischvili, G. (2004) Dealing with Diversity; A Matter of Beliefs. *Industrial and Commercial Training*, 36(40), 166-170.

133. Lambert, V., & Nugent, KE. (1999). Leadership Style for facilitating the Integration of Culturally Appropriate Health Care. *Seminars for Nurse Managers*. 7(4), 172-178.

134. College of Nurses of Ontario. (2002). *Professional standards*. Toronto, ON: Author

135. Disch, J., Walton, M., & Barnsteiner, J. (2001). The role of the clinical nurse specialist in creating a healthy work environment. *AACN Clinical Issues*, 12(3), 345-355.

136. Gelinas, L., & Manthey, M, (1997). The impact of organizational redesign on nurse executive leadership. *Journal of Nursing Administration*, 27(10), 35-42.

137. Porter O'Grady, T. (1992). Transformational leadership in an age of chaos*. Nursing Administration Quarterly*, *17(1), 17-24*.

138. Johnson, D., & Johnson, R. (1995). *Social interdependence, cooperative learning in education*. In: B.B. Bunker and J.Z. Rubin (Eds.), *Conflict, cooperation and justice.* San Francisco, CA: Jossey-Bass.

139. Thompson, J., & Bunderson, J. (2003). Violations of principle: Ideological currency in the psychological contract. *Academy of Management Review,* 28(4), 571-587.

140. Storch, J., Rodney, P., Pauly, B., Brown, H., & Starzomski, R. (2002). Listening to nurses' moral voices: Building a quality health care environment. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 15(4), 7-16.

141. Boyle, D., Bott, M., Hansen, H., Woods, C., & Taunton, R. (1999). Managers' leadership and critical care nurses' intent to stay*. American Journal of Critical Care, 8(6), 361-371*.

142. Adams, C. (1994). Innovative behaviour in nurse executives. *Nursing Management*, 25(5), 44-47.

143. Peters, T., & Waterman, Jr. R. (1982*). In search of excellence*. New York: Harper & Row.

144. Upenieks, V. (2002)*. The interrelationship between and meaning of power and opportunity, nursing leadership, organizational characteristics of magnet Institutions and clinical nurse job satisfaction*. Doctoral dissertation. University of Washington.

145. Kofman, R. (1994). Check-in, check-out: A tool for real conversations. *The Systems Thinker*, 5(4), 8-9.

146. Kramer, M,, Schmalenberg, C., & Maguire, P. (2004). Essentials of a magnetic work environment: part 3. *Nursing*, 8(34) 44-7.

147. Joni, S. (2004). The geography of trust. *Harvard Business Review*, 82, 83-88

148. Recker, D., Bess, C., & Wellens, H. (1996). A decision-making process in shared governance. *Nursing Management*, 27(5), 48A-48D.

149. Wheatley, M. (2002). *Turning to one another: Simple conversations to restore hope to the future*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

150. Laschinger, H., Finegan, J., Shamian, J., & Casier, S. (2000). Organizational trust and empowerment in restructured health care settings: Effects on staff nurse commitment. *Journal of Nursing Administration*, 30(9), 413-425.

151. Hatcher, S., & Laschinger, H. (1996). Staff nurses' perceptions of job empowerment and level of burnout: A test of Kanter's theory of structural power in organizations. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 9(2), 74-94.

152. Huffman, J. (1995). *Staff nurses' perceptions of work empowerment and control over nursing practice in community hospital settings*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

153. Laschinger, H., & Havens, D. (1996). Staff nurse work empowerment and perceived control over nursing practice. Conditions for work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*, 26(9), 27-35.

154. Whyte, H. (1995). *Staff Nurse Empowerment and Job Satisfaction*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

155. Upenieks, V. (2003). The interrelationship of organizational characteristics of magnet hospitals, nursing leadership and nursing job satisfaction. *Health Care Manager*, 22(2), 83-98.

156. Laschinger, H., Almost, J., & Tuer-Hodes, D. (2003). Workplace empowerment and magnet hospital characteristics. *Journal of Nursing Administration*, 33(7/8), 410-422.

157. Baguley, K. (1999). *Workplace Empowerment, Job Strain and Affective Organizational Commitment in Critical Care Nurses: Testing Kanter's structural theory of organizational behaviour*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

158. Hatcher, S., *The relationship between power perceptions of nurse managers and burnout: A test of Kanter's theory of structural power*. Master's thesis. University of Western Ontario. London, ON.

159. Howard, A. (1997). *The empowering leader: Unrealized opportunities*. In: *The Balance of Leadership and Followership Working Papers*, Baltimore, MD: Academy of Leadership Press.

160. O'Brien, L. (1997). *The relationship between Registered Nurses' perceptions of job-related empowerment and occupational mental health. A Test of Kanter's theory of organizational behaviour. Master's thesis*. London, ON: University of Western Ontario.

161. McBurney, M. (1997). *The Relationship between first-line nurse managers' perceptions of job-related empowerment and occupational stress in a large acute care teaching hospital*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

162. Laschinger, H., & Havens, D. (1997). The effect of workplace empowerment on staff nurses' occupational mental health and work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*, 27(6), 42-50.

163. Laschinger, H., Sabiston, J., & Kutszcher, L. (1997). Empowerment and staff nurse decision involvement in nursing work environments: Testing Kanter's theory of structural power in organizations. *Research in Nursing & Health*, 20, 341-352.

164. Kanter, R (1979). Power failure in management circuits. *Harvard Business Review*, 57(4), 65-75.

165. Peachy, G. (2002). *The effect of leader empowering behaviours on staff nurses' workplace empowerment, psychological empowerment, organizational commitment and absenteeism*. Doctoral dissertation. McMaster University, Hamilton, Ontario.

166. McKey, C. (2002). *Leadership practices, organizational commitment, conditions of work effectiveness of chief nursing officers in Ontario's restructured hospitals*. Doctoral dissertation. Capella University, Minneapolis, MN.

167. Beaulieu, R., Shamian, J., Donner, G., & Pringle, D. (1997). Empowerment and commitment of nurses in long-term care. *Nursing Economic$,* 15(1), 32-41.

168. Dubuc, L. (1995). *Job empowerment and commitment in military nursing: An extension study*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

169. McDermott, K., Laschinger, H., & Shamian, J. (1996). Work empowerment and organizational commitment. *Nursing Management*, 27(5), 44-49.

170. Tucker, A., & Edmondson, A. (2003). Why hospitals don't learn from failures: Organizational and psychological dynamics that inhibit system change. *California Management Review*, 45(2), 1-18.

171. Wilson, B., & Laschinger, H. (1994). Staff nurse perception of job empowerment and organizational commitment: A test of Kanter's theory of structural power in organizations. *Journal of Nursing Administration*, 24(4S), 39-47.

172. Laschinger, H., Finegan, J., & Shamian, J. (2001). Promoting nurses' health: Effect of empowerment on job strain and work satisfaction. *Nursing Economic$*, 19(2), 42-52.

173. Laschinger, H., Finegan, J., Shamian, J., & Wilk, P. (2000). Impact of structural and psychological empowerment on job strain in nursing work settings: Expanding Kanter's model. *Journal of Nursing Administration*, 31(5), 260-272.

174. Laschinger, H., Finegan, J., & Shamian, J. (2001). The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses' work satisfaction and organizational commitment. *Health Care Management Review*, 26(3), 7-23.

175. Govers, M. (1997). *Workplace empowerment and job performance in ambulatory care*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

176. Gokenbach, V. (2004) *The effects of an empowerment model intervention on registered nurse turnover and absenteeism*. Doctoral dissertation. University of Phoenix

177. Erickson, J., Hamilton, G., Jones, D., & Ditomassi, M. (2003). The value of collaborative governance/staff empowerment. *Journal of Nursing Administration*, 33(2), 96-104.

178. Kanter, R. (1993). *Men and women of the corporation.* 2nd ed. New York: Basic Books.

179. Manojlovich, M. (2005). A leadership strategy to improve practice. *Journal of Nursing Administration*. 35(5), 271-278.

180. Skelton Green, J. (1996). The perceived impact of committee participation on the job satisfaction of staff nurses. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 9(2), 7-35.

181. Suominen, T., Savikko, N., Puukka, P., Doran, DI., & Leino-Kilpi, H. (2005). Work empowerment as experienced by head nurses. *Journal of Nursing Management*. 13, 147-53.

182. Conger, J., & Kanungo, J. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. *Academy of Management Review*, 13(3), 471-482.

183. McKay, C. (1995). *Staff nurses' job related power and perceptions of managerial transformational leadership*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

184. Dunham, J., & Fisher, E. (1990). Nurse executive profile of excellent nursing leadership. *Nursing Administration Quarterly*, 15(1), 1-5.

185. Hui, C. (1994). *Effects of leader empowerment behaviours and follower's personal control, voice and self-efficacy on in-role and extra-role performance. An extension of Conger and Kanungo's empowerment process model.* Doctoral dissertation, Indiana University, Indiana.

186. Upenieks, V. (2003a). Nurse leaders' perceptions of what compromises successful leadership in today's acute inpatient environment. *Nursing Administration Quarterly*, 27(2), 140-152.

187. DeLong, D., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. *Academy of Management Executive*, 14(4), 113-127.

188. Garvin, D. (1993). Building a learning organization. *Harvard Business Review*, (4), 78-91.

189. Ballein Search Partners (2003). *Why senior nursing officers matter: A national survey of nursing executives*. Retrieved February 23, 2005 from Website of American Organization of Nurse Executives: www.hospitalconnect.com/aone/docs/03sno-survey.pdf

190. Davenport, T., DeLong, D., & Beers, M. (1998). Successful knowledge management projects. *Sloan Management Review*, 39(2), 43-57.

191. Cardin, S. (1995). *Outcomes of unit effectiveness in relation to the leadership role of nurse managers in critical care nursing*. Doctoral dissertation. University of California, Los Angeles.

192. Aiken, L., Sochalski, J., & Lake, E. (1997). Studying outcomes of organizational change in health services. *Medical Care,* 35(11), NS6-NS18.

193. Strebel, P. (1996). Why do employees resist change? *Harvard Business Review*, 74, 86-92.

194. Robinson, C. (2001). Magnet nursing services recognition: Transforming the critical care environment. *AACN Clinical Issues*, 12(3), 1-18.

195. Campbell SL, Fowles ER, & Weber BJ. (2004). Organizational structure and job satisfaction in public health nursing. *Public Health Nursing*. 6(21), 564-71.

196. Canadian Nurses Association. (2003). *Succession planning for nursing leadership*. Ottawa, ON: Author.

197. Apker, J., Zabava Ford, W., & Fox, D. (2003). Predicting nurses' organizational and professional identification: The effect of nursing roles, professional autonomy and supportive communication. *Nursing Economic$,* 21(5), 226-232.

198. Canadian Nurses Association. (2001). *Quality professional practice environments for Registered Nurses*. Ottawa, ON: Author.

199. Gifford, B., Zammuto, R., & Goodman, E. (2002). The relationship between hospital unit culture and nurses' quality of work life. *Journal of Healthcare Management*, 47(1), 13-25.

200. Collins, D. (2002). *The effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982-2001*. Doctoral dissertation. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.

201. Madison, J. (1994). The value of mentoring in nursing leadership: A descriptive study. *Nursing Forum* 29(4), 16-23.

202. Senge, P. M. (1990) *The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization*. London: Random House

203. Argyris, C., & Schön, D. (1996) *Organizational learning II: Theory, method and Practice*. Reading, MA: Addison Wesley.

204. Donaldson, N., & Rutledge, D. (1998). Expediting the harvest and transfer of knowledge for practice in nursing: Catalyst for a journal. *The Online Journal of Clinical Innovations* 1(2), 1-25.

205. Kovner, A., Elton, J., & Billings, J. (2000). Transforming health management: An evidence-based approach. *Frontiers of Health Services Management*, 16(4), 3-24.

206. Berwick D. (1996). Harvesting knowledge from improvement (editorial). *The Journal of the American Medical Association*, 275, 877- 878.

207. Walshe, K., & Rundall, T. (2001). Evidence-based management: From theory to practice in health care. *The Millbank Quarterly*, 79(3), 429-458.

208. Kitson, A., Harvey, G., & McCormack, B. (1998). Enabling the implementation of evidence-based practice: A conceptual framework. *Quality in Health Care*, 7(3), 149-158.

209. Udod, S., & Care, W. (2004). Setting the climate for evidence-based nursing practice: What is the leader's role? *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 64-75.

210. Hansen, M., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's *y*our *s*trategy for *m*anaging *K*nowledge*? Harvard Business Review*, 77(2), 106-116.

211. Kramer, M., & Schmalenberg, C. (2002). *Staff nurses identify essentials of magnetism*. In: McClure, M., Hinshaw. A. (Eds.), *Magnet hospitals revisited: Attraction and retention of professional nurses*. Washington, DC: American Nurses Publishing.

212. Rycroft-Malone, J., Kitson, A., Harvey, G., McCormack, B., Seers, K., Titchen, A., & Estabrooks, C. (2002). Ingredients for change: Revisiting a conceptual framework. *Quality and Safety in Health Care*, 11, 174-180.

213. Titchen A. (2000). *Professional craft knowledge in patient-centred nursing and the facilitation of its development.* Doctoral dissertation. University of Oxford. Oxford: Ashdale Press.

214. Upshur R. (1997). Certainty, probability and abduction: why we should look to C.S. Pierce rather than Godel for a theory of clinical reasoning? *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 3, 201-206.

215. Stone, R., Reinhard, S., Bowers, B., Zimmerman, D., Phillips, C., Hawes, et al. (2002). *Evaluation of the Wellspring model for improving nursing home quality*. The Commonwealth Fund.5

216. Rutledge, D., & Donaldson, N. (1995) Building organizational capacity in research ultilization. *Journal of Nursing Administration.* 25(10), 12-6.

217. Bethune, G. (2005). *Performance improvement: The leadership perspective. Excellence in Nursing Knowledge*. Retrieved 3/15/2005 from: *http://www.nursingknowledge.org/Portal/mian.aspx?PateIde=3514&IssueNo=7&ArticleNo*

218. Barry-Walker, J. (2000). The impact of system redesign on staff, patient and financial outcomes. *Journal of Nursing Administration*, 30(2), 77-89.

219. Katz, R. (1982). The effects of group longevity on project communication and performance. *Administrative Science Quarterly*, 27, 81-104.

220. Gil, F., et al. (2005). Change-oriented leadership, satisfaction and performance in work groups: Effects of team climate and group potency. *Journal of Managerial Psychology*. 20(3/4), 312-328.

221. McNeese-Smith, D. (1995). Job satisfaction, productivity and organizational commitment: The result of leadership. *Journal of Nursing Administration*, 25(9), 17-26.

222. Kanter, R. (1999). The enduring skills of change leaders. *Leader to Leader*, 13, (3). Retrieved April 29, 2004 from: http:www.pfdf.org/leaderbooks/121summer99/kanter.html

223. Block, P. (1987). *The empowered manager*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

224. Knox, S., & Irving, J., (1997). An interactive quality of work life model applied to organizational transition. *Journal of Nursing Administration*, 27(1), 39-47.

225. Knox, S., & Irving, J. (1997). Nurse manager perceptions of health care executive behaviours during organizational change. *Journal of Nursing Administration*, 27(11), 33-39.

226. Heifetz, R., & Laurie, D. (2001). The work of leadership. *Harvard Business Review*, (2), 106-117.

227. Leana, C., & VanBuren, H. (1999). Organizational social capital and employment practices. *Academy of Management Review*, 24, 538-555.

228. Huy, Q. (2002). Emotional balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers. *Administrative Science Quarterly*, 47, 31-69.

229. Greenberg, L. (1996). *Allowing and accepting emotional experience*. In: Kavanaugh, R., Zimmerberg, B., Fein, S. (Eds.*), Emotion: Interdisciplinary perspectives*. pp. 315-336. Mahwah, NJ: Erlbaum.

230. Macy, B., Peterson, M., & Norton, L. (1989). A test of participation theory in a work redesign field setting: Degree of participation and comparison site contrasts. *Human Relations*, 42, 1095-1165.

231. Lowe, G. (2004). *Healthy workplace strategies: Creating change and achieving results*. Prepared for the Health Strategies Bureau, Health Canada. Graham Lowe Group Inc.

232. Goodman, P. (2001). *Missing organizational linkages: Tools for cross-level organizational research.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

233. Kroposki, M., Murdaugh, C., Tavakoli, A., & Parsons, M. (1999). Role clarity, organizational commitment and job satisfaction during hospital reengineering. *Nursing Connections*, 12(1), 27-34.

234. Heller, F. (2003). Participation and power: A critical assessment. *Applied Psychology: An International Review*. 52, 144-163.

235. Cummings, G., & McLennan, M. (2005). Advanced practice nursing. Leadership to effect policy change. *Journal of Nursing Administration*, 35(2), 61- 66.

236. McDowell, A. (2004). *What strategies will support leaders during rapid change?* Masters thesis. Royal Roads University.

237. Lindholm, M., Dejin-Karlsson, P., Östergren, P-O., & Udén, G. (2003). Nurse managers' professional networks, psychosocial resources and self-rated health. *Journal of Advanced Nursing*, 42(5), 506-515.

238. Cronkhite, L. (1991). *Role of the hospital nursing administrator in a changing health care environment – A study of conflicts and values.* Doctoral dissertation. University of Milwaukee, Wisconsin.

239. Gaudine, A., & Beaton, M. (2002). Employed to go against one's values: Nurse managers' accounts of ethical conflict with their organizations. *Canadian Journal of Nursing Research*, 34(2), 17-34.

240. Mohr, W., & Mahon, M. (1996). Dirty hands: The underside of marketplace health care. *Advances in Nursing Science*, 19(1), 28-37.

241. Fenton, M. (1988). Moral distress in clinical practice: Implications for the nurse administrator. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 1, 8-11.

242. Corley, M. (1995). Moral distress of critical care nurses. *American Journal of Critical Care*, 4(4), 280-285.

243. Corley, M., Elswick, R., Gorman, M., & Clor, T. (2001). Development and evaluation of a moral distress scale. Journal of Advanced Nursing*, 33(2) 250-256.*

244. Oberle, K., & Tenove, S. (2000). Ethical issues in public health nursing. *Nursing Ethics*, 7(5), 425-438.

245. Splane, R., & Splane, V. (1994). *Chief nursing officer positions in national ministries of health. Focal points for nursing leadership*. San Francisco, CA: University of California School of Nursing.

246. Posner, B., Kouzes, J., & Schmidt, W. (1985). Shared values make a difference: An empirical test of corporate culture. *Human Resources Management* 24(3), 293-309.

247. Jameton, A. (1984). *Nursing practice: The ethical issues*. Englewoood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

248. Lageson C. (2004). Quality focus of the first line nurse manager and relationship to unit outcomes. *Journal of Nursing Care Quality*. 4(19) 336-42

249. Canadian Nurses Association. (October, 2003). *Ethical distress in health care environments. Ethics in practice for Registered Nurses*. Retrieved February 23, 2005 from: http://www.cna-nurses.ca/cna/practice/ethics/inpractice/default_e.aspx

250. May, D., Hodges, T., Chan, A., & Avolio, B. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. *Organizational Dynamics*, 32(3), 247-260.

251. Baumann, A., Blythe, J., Kolotylo, C., & Underwood, J. (2004). *Immigration and emigration trends: A Canadian perspective.* The Nursing Sector Study Corporation. Ottawa, ON.

252. Bass, B., & Avolio, B. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. *Research in Organizational Change and Development*, 4, 231-272.

253. Norrish, B., & Rundall, T. (2001). Hospital restructuring and the work of Registered Nurses. *Millbank Quarterly*, 79(1), 55-79.

254. Hurst, J. (1996). Building hospital TQM teams: Effective polarity analysis and maximization. *The Health Care Supervisor*, 15(1), 68-75.

255. Heeley, F. (1998). Leading with integrity: How to balance conflicting values. *Health Progress*, 79(5), 60-62.

256. Rokeach, M. (1973). *The Nature of human values*. New York: Free Press.

257. Krecji, J. (1999). Changing roles in nursing: Perceptions of nurse administrators. *Journal of Nursing Administration*, 29(3), 21-29.

258. Renz, D., & Eddy, W. (1996). Organizations, ethics, and health care: Building an ethics infrastructure for a new era. *Bioethics Forum*, 2,, 29-39.

259. Silva, M. (1998). Organizational and administrative ethics in health care: An ethics gap? *Online Journal of Issues in Nursing*, December 31, 1998. Retrieved on February 22, 2005 from: http://www.nursingworld.org/ojin/topic8/topic8_1.htm

260. Jeans, M., & Rowat, K. (2005). *Competencies required of nurse managers: Identifying the skills, personal attributes and knowledge required of nurse managers, and the enablers and barriers for nurse managers to acquire and sustain these competencies. The pulse of renewal: A focus on nursing human resources. May, 2005. Special report*. Toronto, ON: Canadian Journal of Nursing Leadership.

261. Laschinger, H., & Shamian, J. (1994). Staff nurses' and nurse managers' perceptions of job related empowerment and managerial self efficacy. *Journal of Nursing Administration*, 24(10), 38-47.

262. Boyle, DK., & Kochinda, C. (2004). Enhancing collaborative communication of nurse and physician leadership in two intensive care units. *The Journal of Nursing Administration*. 34(2), 60-70.

263. Krugman, M. (1989). *An investigation of the relationship between nurse executive socialization and occupational image*. Doctoral dissertation. University of Denver.

264. Upenieks, V. (2002). Assessing differences in job satisfaction of nurses in magnet and nonmagnetic hospitals. *Journal of Nursing Administration*, 32(11), 564-576.

265. Devine, G., & Turnbull, L. (2002). *Nurses' definitions of respect and autonomy in the workplace: Summary of focus groups with Canadian nurses*. Retrieved May 4, 2005 from: www.hc-sc.gc.ca/english/for-you/nursing/cnac/report/appendixC.htm

266. Bliss-Holtz, J., Winter, N., & Scherer, E. (2004). An invitation to magnet accreditation. *Nursing Management*, 35(9), 36-42.

267. American Association of Colleges of Nursing (AACN) Task Force on Hallmarks of the Professional Practice Setting. (2002). *Hallmarks of the professional nursing practice environment. January, 2002*. AACN. Retrieved September 24, 2004 from http://www.aacn.nche.edu/Publications/positions/hallmarks.htm

268. Government of Quebec. (1994). *An Act respecting health services and social services. R.S.Q., chapter S-4.2*. (Updated to 5 July 1994. Last amendment 17 June, 1994).

269. *Public Hospitals Act (1990). Regulation 965 (amended).* Retrieved May 9, 2005 from: http://192.75.156.68/DBLaws/Regs/English/900965_e.htm

270. Maslove, L. & Fooks, C. (2004). *Our health, our future: Creating quality workplaces for Canadian nurses – A progress report on implementing the final report of the Canadian Nursing Advisory Committee*. Ottawa, ON: Canadian Policy Research Networks Inc.

271. Aiken, L., Clarke, S., Sloane, D., Sochalski, J., Busse, R., Clarke, H., et al.(2001). Nurses reports on hospital care in five countries. *Health Affairs*, 20(3), 43-53.

272. Aiken, L., & Patrician, P., (2000). Measuring organizational traits of hospitals: The Revised Nursing Work Index. *Nursing Research*, 49, 146-153.

273. Burner, O. (1983). The organizational structure of air force hospitals and its effect on management of nursing services. *Dissertation Abstracts International*, 43 (7). 2, 431A.

274. Crossley, J. (1993). Chief nursing officer governing body proximity, direct reporting relationship and professionalism as predictors of chief nursing officer role conflict and role ambiguity. *Dissertation Abstracts International*, 54 (4), 1, 887B.

275. Woodham-Smith, C. (1951). Florence Nightingale, 1820-1910. New York: McGraw-Hill Book Co.

276. Reyna, S. (1992*). Leadership styles of nurse managers and how they affect the motivation level of nursing staff*. Doctoral Dissertation, University of Texas at Austin.

277. Bryman, A., Brensen, M., Beadswoth, A., Ford, J., & Keil, E. (1987). The concept of the temporary system: The case of the construction project. *Research in the Sociology of Organizations* 5, 253-283.

278. Coff, R., & Rousseau, D. (2000). *Sustainable competitive advantage and employability: Is it a "win-win" situation?* In Leana, C.R. and Rousseau, D.M. (Eds.). *Relational wealth: The advantages of stability in a changing economy*. Oxford: Oxford University Press.

279. Coile, R. (1999). Magnet hospitals: Ten Strategies to becoming a model nursing employer. *Russ Coile's Health Trends*, 11(8), 1-4.

280. Cummings, G., & Estabrooks, C. (2003). The effects of hospital restructuring that included layoffs on individual nurses who remained employed: A systematic review of impact. *International Journal of Sociology and Policy*. 23(8/9), 8-53.

281. Anderson, R., Corazzini, K., & McDaniel, R. Jr. (2004). Complexity science and the dynamics of climate and communication: Reducing nursing home turnover. *The Gerontologist*, 44(3), 378-388.

282. Canadian Nurses Association. (2005). *Nursing leadership in a changing world. Nursing Now, Issues and Trends in Canadian Nursing*, 18(1). Retrieved April 22, 2005 from: http://www.cna-nurses.ca/cna/

283. Lemire Rodger, G. (2005). *Leadership challenges and directions*. In: Hibberd, J.M., Smith, D.L. (Eds.), *Nursing leadership and management in Canada,* 3rd Ed. Toronto, ON: Elsevier Canada.

284. Canadian Institute for Health Information. (2004). *Workforce trends of Registered Nurses in Canada, 2004*. Ottawa, ON: Author.

285. Duxbury, L., & Higgins, C. (2003). *Work-life conflict in Canada in the new millennium. A status report*. Retrieved February 15, 2006 from http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/work-travail/report2/index.html

286. Laschinger, H., Almost, J., Purdy, N., & Kim, J. (2004). Predictors of nurse managers' health in Canadian restructured health care settings. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 88-105.

287. Hemman E. (2000). Leadership profiles of senior nurse executives *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 13(1), 21-30.

288. Villarruel, AM,. & Peragallo N. (2004). Leadership development of Hispanic nurses. *Nursing Administration Quarterly*. 3(28), 173-80.

289. Redmond, G. (1995). "We don't make widgets here" voices of chief nurse executives. *Journal of Nursing Administration*, 25(2), 63-69.

290. Dreachslin, J. (2002). Communication: Bridging the racial and ethnic divide in health care management. *Health Care Manager*, 20(4), 10-18.

291. Branch, C., & Fraser, I. (2001). Can cultural competency reduce racial and ethnic health disparities? *Medical Care Research and Review*, 57(1), 181-217.

292. Laschinger, HKS., Shamian, J., & Thomson, D. (2001). Impact of magnet hospital characteristics on nurses' perceptions of trust, burnout, quality of care and work satisfaction. *Nursing Economic$,* 19, 209-219.

293. Carney M. (2004). Middle manager involvement in strategy development in not-for profit organizations: the director of nursing perspective – how organizational structure impacts on the role. *Journal of Nursing Management*. 1(12), 13-21.

294. O'May, F., & Buchan, J. (1999). Shared governance: A literature review. *International Journal of Nursing Studies*, 36, 281-300.

295. Upenieks, V. (2000). The relationship of nursing practice models and job satisfaction outcomes. *Journal of Nursing Administration*, 30(6), 330-335.

296. Song, B., Daly, B., Trudy, E., Douglas, S., & Dyer, M. (1997). Nurses job satisfaction, absenteeism and turnover after implementing a special care unit model. *Research in Nursing and Health*, 20, 443-452.

297. Haines, J. (1993). *Leading in a time of change. The challenge for the nursing profession – A discussion paper*. Ottawa, ON: Canadian Nurses Association.

298. Nicklin, W. (2001). "Thank you" isn't enough. (2001). *Healthcare Management Forum*, 13(3), 6-9.

299. Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). *First break all the rules*. New York: Simon and Schuster.

300. Urwick, L. (1956). The manager's span of control. *Harvard Business Review*, 3, 39-47.

301. Mullen, B., Symons, C., Hu, L., & Salas, E. (1989). Group size, leadership behaviour and subordinate satisfaction. *Journal of General Psychology*, 116, 155-169.

302. Hechanova-Alampay, R., & Beehr., T. (2001). Empowerment, span of control, and safety performance in work teams after workforce reduction. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6(4), 275–282.

303. Gittell, J. (2001). Supervisory span, relational coordination and flight departure performance: A reassessment of post-bureaucracy theory. *Organization Science*, 12, 468–483.

304. Cathcart, D., Jeska, S., Karnas, J., Miller, S. Pechacek, J., & Rheault, L. (2004). Span of control matters. *Journal of Nursing Administration*, 34(9), 395–399.

305. Tourangeau, A., Lemonde, M., Luba, M., Dakers, D., & Alksnis, C. (2003). Evaluation of a leadership development intervention. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 16(3), 91-104.

306. George, V., Burke, L., Rodgers, B., Duthie, N., Hoffmann, M., Koceja, V., et al. (2002). Developing staff nurse shared leadership behaviour in professional nursing practice. *Nursing Administration Quarterly*, 26(3), 44-59.

307. Wolf, M. (1996). Changes in leadership styles. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 27, 245-252.

308. Cunningham G., & Kitson, A. (2000). An evaluation of RCN clinical leadership development programme (part 1). *Nursing Standard*, 15(12), 34-37.

309. Cunningham, G., & Kitson, A. (2000). An evaluation of RCN clinical leadership development programme (part 2). *Nursing Standard*, 15(13-15), 34-40.

310. Cherniss, C., Goleman, D., Emmerling, R., Cowan, K., & Adler, M. (1998). *A technical report issued by the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations.* Retrieved April 21, 2004 from: http://www.eiconsortium.org/research/technical_report.htm

311. Jones K. (2005). Leading an empowered organization (LEO): does it work?. [Review] *British Journal of Community Nursing*.10, 92-6.

312. Giber, D., Carter, L., & Goldsmith, M. (2000). *Best practices in leadership development handbook*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

313. Blanzola, C., Lindeman, R., & King, ML. (2004).Nurse internship pathway to clinical comfort, confidence, and competency. *Journal for Nurses in Staff Development*. 2(20), 27-37.

314. Barger, S. (2004). An academic-service partnership: Ideas that work. *Journal of Professional Nursing*, 20, 97-102.

315. Wood-Allen, D. (1998). How nurses become leaders: Perceptions and beliefs about leadership development. *Journal of Nursing Administration*, 28(9), 15-20.

316. Collins, D., & Holton, E. (2004). The Effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982 to 2001. *Human Resources Development Quarterly*. 15(2), 217-248.

317. Strasen, L. (1992). *The image of professional nursing: Strategies for action*. Philadelphia, PA: Lippincott

318. Strader, M., & Decker, P. (1995). *Role transition to patient care management.* Norwalk, CT: Appleton and Lange.

319. Blais, K., Hayes, H., Kozier, B., & Erb, G. (2002). *Professional nursing practice concepts and perspectives* ,4th Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

320. Hinshaw, A. (1986). *Socialization and resocialization of nurses for professional nursing practice*. In: Hein, E.C., Nicholson. M.E. (Eds.), *Contemporary leadership behaviour: Selected readings*, 2nd ed. Boston: MA: Little, Brown.

321. Shirey, M. (2004). Social support in the workplace: Nurse leader implications. *Nursing Economic$*, 22(6), 313-319.

322. Waite, P., & Richardson, G. (2004). Determining the efficacy of resiliency training in the work site. *Journal of Allied Health*, 33(3), 178-183.

323. Judkins, SK. (2004). Stress among nurse managers: can anything help? *Nurse Researcher*. 12, 58-70.

324. Sullivan, J., Bretschneider, J., & McCausland, M. (2003). Designing a leadership development program for nurse managers: An evidence-driven approach. *Journal of Nursing Administration*, 33(10), 55-549.

325. Conchie, B. (2004). The seven demands of leadership. What separates great leaders from all the rest? *Gallup Management Journal*, May 13, 2004. Retrieved December 8, 2004 from: http://gmj.gallup.com/content/default.asp?ci=11614

326. Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. New York: Bantam Books.

327. Snyderman, G. (1988). *Leadership styles of head nurses and the job satisfaction of Registered Nurses and aides*. Doctoral dissertation. Temple University.

328. Snow, J. (2001). Looking beyond nursing for clues to effective leadership. *Journal of Nursing Administration*, 31(9), 440-443

329. Goddard, M., & Laschinger, H. (1997). Nurse managers' perceptions of power and opportunity. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 10(2), 40-66.

330. Herbert, R., & Edgar, L. (2004). Emotional intelligence: A primal dimension of nursing leadership? *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 56-63.

331. Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9, 185-211.

332. Vitello-Cicciu, J. (2003). Innovative leadership through emotional intelligence. *Nursing Management*, 34(10), 28-32.

333. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee. (2002). *Primal leadership: Recognizing the power of emotional intelligence*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

334. Srivastava, R. (2005) *Presentation: Culturally Competent Leadership Practices: The good, the bad, and the Uncertain*. Canadian Nurses Association, Nursing Leadership Conference, The Changing Face of Nursing Leadership: Diversity, Partnerships, Innovations. Ottawa, Ontario

335. Taylor, A., Sylvestre, J., & Botschner, J. (1998). Social support is something you do, not something you provide: Implications for linking formal and informal support. *Journal of Leisurability*, 25(4). Retrieved March 3, 2005 from: www.lin.ca/resource/html/Vol25/v25n4a2.htm

336. Walsh, C., & Clements C. (1995). Attributes of mentors as perceived by orthopaedic nurses. *Orthopaedic Nursing*, 14(3), 49-56.

337. Allen-Tammy, D., et al. (2004). Career Benefits Associated with Mentoring for Proteges: A Meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*. 89(1), 127-136.

338. Leger Marketing. (2003). *How Canadians perceive various professions*. Retrieved June 8, 2005 from: www.rnantnu.ca/news/trusted_pros.pdf

339. Henderson, A. (2003). Nurses and workplace violence: Nurses' experience of verbal and physical abuse at work. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 16(4), 82-98.

340. Advisory Committee on Health Human Resources (2000). *The Advisory Committee on Health Human Resources*. The Nursing Strategy for Canada. October 2000. Retrieved May 13, 2005 from: http://www.hc-sc.gc.ca

341. Health Canada. *Office of Nursing Policy*. Retrieved October 6, 2005 from: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpb-dgps/onp-bpsi/index_e.html

342. Glasgow, RE., Klesges, LM., Dzewaltowski, DA., Bull, SS., & Estabrooks, P. (2004). The future of health behavior change research: What is needed to improve translation of research into health promotion practice? *Annals of Behavioral* Medicine, 27(1), 3-12.

343. Daly, B., Douglas, S., & Kelley, C. (2005). Benefits and challenges of developing a program of research. *Western Journal of Nursing Research*, 27(3), 364-377.

344. Canadian Health Services Research Foundation. *Key research themes – Nursing leadership organization and policy*. Retrieved from the CHSRF website June 2, 2005: http://www.chsrf.ca/research_themes/nlop_e.php

345. Axelsson, R. (1998). Towards an evidence-based health care management. *International Journal of Health Planning and Management*, 13, 307-317.

346. Tomblin Murphy, G., O'Brien-Pallas, L., Alksnis, C., Birch, S., Kephart, G., Pennock, M., et al.. (2003). *Health human resources planning: An examination of relationships among nursing service utilization, an estimate of population health and overall health status outcomes in the province of Ontario*. Executive summary. Retrieved on June 1, 2005 from: www.chsrf.ca/final_research/ogc/pdf/tomblin_e.pdf

347. Blegen, M. (1993). Nurses' job satisfaction: meta-analysis of related variables. *Nursing Research*, 42(1), 36-41

348. Irvine, D., & Evans, M. (1992). Job satisfaction and turnover among nurses: A review and meta-analysis. *Quality of Nursing Worklife Research Unit Monograph Series*. University of Toronto.

349. Thomson, D. Dunleavy, J., & Bruce, S. (2002). *Nurse Job Satisfaction – Factors Relating to Nurse Satisfaction in the Workplace*. Report commissioned for the Canadian Nursing Advisory Committee, Ottawa, ON.

350. *JCAHO Standards and Reference Crosswalk Contents*. Retrieved June 2, 2005 from: http://www.wramc.army.mil/JCAHO/Division.cfm?d_Id=13

351. Simpson, B., Skelton-Green, J., Scott, J., & O'Brien-Pallas, L. (2002). Building capacity in nursing: Creating a leadership institute. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 15(3), 22-27.

352. Cooperrider, D., & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational life part 2. *Research in organizational Change and Development*, 1, 129-169.

353. Michigan Hospitals. *Glossary of Terms*. Retrieved October 4, 2004 from: http://www.michiganhospitalprofiles.org/glossary_of_terms.htm

354. Stanhope, M., & Lancaster, J. (2000). *Community and public health nursing*. St. Louis: Mosby.

355. Mayer, J., & Salovey, P. (1997). *What is emotional intelligence?* In: Salovey, P., Sluyter, D.J. (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications*. pp. 3-31. New York: Basic Books.

356. Emmerling, R., & Goleman, D. (2003). (October*). Emotional intelligence issues and common misunderstandings*. Retrieved June 8, 2005 from: http://eqi.org/gole3.htm

357. Webster, G., & Baylis, F. (2000). *Moral residue*. In: Rubin, S.R., Zoloth, L. (Eds.), *Margin of error: The ethics of mistakes in the practice of medicine*. Hagerstown, MD: University Publishing Group.

358. Registered Nurses Association of Ontario (2006). *Embracing Cultural Diversity in Health Care: Developing Cultural Competence – Draft 7*. Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario

359. *Definitions of Fairness*. Retrieved June 2, 2005, from: http://www.google.ca/search?hl=en&lr=&oi=defmore&q=define:fairness www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn

360. Field, M., & Lohr, K. (1990). *Guidelines for clinical practice: Directions for a new program*. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academy Press.

361. Rothmann, S., & Coetzee, S. (2003). *Dispositional characteristics, quality of work life and effectiveness of members of self-managing teams.* Poster presented at the 11th European Congress of Work and Organizational Psychology, Lisbon, Portugal, 14-17 May 2003.

362. Carper, B. (1978). Fundamental patterns of knowing in nursing. *Advanced Nursing Science.* 1(1), 13-23.

363. Clarke, M. & Oxman, A.D. (1999). *Cochrane Reviewers' Handbook*, 4th Ed.. Oxford, UK: The Cochrane Collaboration.

364. Sleutel, M. (2000). Climate, culture, context, or work environment? Organizational factors that influence nursing practice. *Journal of Nursing Administration*, 30(2), 53-58.

365. McGillis Hall, L. (Ed.). (2004). *Quality work environments for nurse and patient safety*. Sudbury, MA: Jones and Barlett Publishers.

366. Registered Nurses Association of Nova Scotia. (2003). *Educational support for competent nursing practice*. Retrieved September 24, 2004 from: http://www.crnns.ca/default.asp?id=190&pagesize=1&sfield=content.id&search=1102&mn=414.70.80.223.320

367. Houghton Mifflin Company, (2004). Identity. *The American heritage dictionary of the English language*. 4th ed. Retrieved June 6, 2005 from: Answers.com: http://www.answers.com/main/ntquery?tname=identity&print=true

368. Houghton Mifflin Company, 1995. Identity. *Roget's II: The New Thesaurus*. 3rd ed. Retrieved June 6, 2005 from: Answers.com: http://www.answers.com/main/ntquery?tname=identity&print=true

369. Baker et al. (1999). Hospital consolidation. Applying stakeholder analysis to merger life-cycle. *Journal of Nursing Adminstration*. 29(3),11-20.

370. Ontario Public Health Association. (1996). *Making a Difference! A workshop on the basics of policy change*. Toronto, Canada: Government of Ontario.

371. National Health and Medical Research Council. (1998). *A guide to the development, implementation, and evaluation of clinical practice guidelines*. National Health and Research Council [On-line]. Available: http://www.health.gov.au/nhmrc.publications/pdf/cp30.pdf.

372. Huber, D., Maas, M., McCloskey, J., Scherb, C., Goode, C., & Watson, C. (2000). Evaluating nursing administration instruments. *Journal of Nursing Administration*, 30(5), 251-272.

373. University of Texas Repository of Nursing Administration Instruments. http://www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/

374. Evans, J. (1992). *A preliminary study to develop an instrument to measure head-nurse self-efficacy*. Abstract from 5th national conference on Nursing Administration Research.

375. Stogdill, R. (1963). *Manual for the leader behavior description questionnaire – Form XII*. Columbus: Ohio State University, Bureau of Business Research.

376. Hersey, P., & Blanchard, K. (1988). *Management of organizational behaviour: Utilizing human resources*. (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

377. Kouzes, J., & Posner, B. (1988). *The Leadership Practices Inventory*. San Diego, CA: Pfeiffer.

378. Bass, B. (1995). *Multifactor Leadership Questionnaire*. Binghamton, NY: State University of New York.

379. Jones, L., Soeken, K., & Guberski, T. (1986). Development of an instrument to measure self-reported leadership behaviours of nurse practitioners. *Journal of Professional Nursing*, 3, 180-185.

380. McGilton, K. (2003) Development and psychometric evaluation of supportive leadership scales. *Canadian Journal of Nursing Research*, 35(4), 72-86.

381. Schwirian, P. (1978). Evaluating the performance of nurses: A multidimensional approach. *Nursing Research*, 27(6), 347-351.

382. Farley, M. Assessing communication in organizations. *Journal of Nursing Administration*, 19(12), 27-31.

383. Pincus, J. (1986). Communication: Key contributor to effectiveness – The research. *Journal of Nursing Administration*, 16(9), 19-25.

384. Goldhaber, G., & Rogers, D. (1979). *Auditing organizational communication systems: The ICA communication audit*. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

385. Roberts, K., & O'Reilly, C. (1974). Measuring organizational communication. *Journal of Applied Psychology*, 59(3), 321-326.

386. Price, J., & Mueller, C. (1986). *Handbook of organizational measurement*. Marshfield, MA: Pitman.

387. Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment. *Journal of Occupational Psychology*, 53, 39-52.

388. Chandler, G. (1986). *The relationship of nursing work environments to empowerment and powerlessness*. Doctoral Dissertation. University of Utah.

389. Laschinger, H. (2004). *Scoring of nursing work empowerment scales.* Retrieved June 2, 2005 from: http://publish.uwo.ca/~hkl/scoring.html

390. Laschinger, H. (1996). A theoretical approach to studying work empowerment in nursing: A review of studies testing Kanter's theory of structural power in organizations. *Nursing Administration Quarterly*, 20(2), 25-41.

391. Spreitzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation. *Academy of Management Journal*, 38, 1442-65.

392. Boughn, S. (1995). An instrument for measuring autonomy-related attitudes and behaviours in women nursing students. *Journal of Nursing Education*, 34, 106-113.

393. Katzman, E., (1989). Nurses' and physicians' perceptions of nursing authority. *Journal of Professional Nursing*, 5(4), 208-214.

394. Kramer M., & Schmalenberg, C. (2003). Magnet hospital staff nurses describe clinical autonomy. *Nursing Outlook*, 51, 13-19.

395. Dempster, J. (1991). *Dempster practice behaviours scale. Instrumentation for measurement of autonomy*. Los Angeles, CA: American Nurses Council of Nurse Researchers Meeting, 1991 Proceedings.

396. Schutzenhofer, K. (1988). *Measuring professional autonomy in nurses*. In: Strickland, O.L., Waltz,, C.F. (Eds.), *Measurement of nursing outcomes. Measuring nursing performance: Practice, education and research*. New York: Springer.

397. Blanchfield, K., & Biordi, D. (1996). Power in practice: A study of nursing authority and autonomy. *Nursing Administration Quarterly*, 20(3), 42-46.

398. Havens, D., & Vasey, J. (2003). Measuring staff nurse decisional involvement: decisional involvement scale. *Journal of Nursing Administration*. 33(6), 331-336.

399. Maas, M., & Jacox, A. (1977). *Guidelines for nurse autonomy/patient welfare*. New York: Appleton-Century Crofts.

400. Blegen, M., & Good, C., Johnson, M., Maas, M., Chen, L., Moorhead, S. (1993). Preferences for decision-making autonomy, *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 25(4), 339-344.

401. Sietsema, M., & Spradley, B. (1987). Ethics and administrative decision-making. *Journal of Nursing Administration*, 17(4), 28-32.

402. Ekvall, G., Arvonen, J., & Waldenstrom-Lindbald, I. (1983). *Creative organizational climate, construction and validation of a measuring instrument*. Stockholm: Fa-institute.

403. Harrison, R. (1992). *Diagnosing organizational culture*. New York: Pfeiffer.

404. Litwin, G., & Stringer, R. (1968). *Motivation and organizational climate*, 2nd Ed. Boston, MA: Division of Research, Harvard University.

405. Mok, E., & Au-Yeung, B. (2002). Relationship between organizational climate and empowerment of nurses in Hong Kong. *Journal of Nursing Management*, 10(3), 129-137.

406. Duxbury, M., Henly, G., & Armstrong, G. (1982). Measurement of the nurse organizational climate of neonatal intensive care units. *Nursing Research*, 32(2), 83-88.

407. Maehr, J., & Braskamp, L. (1986). *The motivation factor: A theory of personal investment*. Lexington, MA: Lexington Books.

408. Zammuto, R., & Krakower, J. (1991). *Quantitative and qualitative studies of organizational culture, Volume 5*. Greenwich, CT: JAI Press

409. Coeling, H., & Simms, L. (1993). Facilitating innovation at the nursing unit level through cultural assessment, part 1: How to keep management ideas from falling on deaf ears. *Journal of Nursing Administration*, 23(4), 46-53.

410. Wallach, E. (1983). Individuals and organizations: The cultural match. *Training and Development Journal*, 37, 29-36. References #'rd Final.doc

411. Cooke, R., & Lafferty, J. (1987). *Organizational Culture Inventory (OCI).* Plymouth, MI: Human Synergistics.

412. Simms, L., Erbin-Roesemann, M., Darga, A., & Coeling, H. (1990). Breaking the burnout barrier: Resurrecting work excitement in nursing. *Nursing Economic$,* 8(3), 177-187.

413. Lake, E. (2002). Development of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. *Research in Nursing and Health*, 25(3), 176-188.

414. Erickson, M., Duffy, M., Gibbons, P., Fitzmaurice, J., Ditomassi, M., & Jones, D. (2004). Development and psychometric evaluation of the Professional Practice Environment (PPE) scale. *Journal of Nursing Scholarship*, 36(3), 279-285.

415. Estabrooks, C., Tourangeau, A., Humphrey, C., Hesketh, K., Giovannetti, P., Thomson, D., et al. (2002). Measuring the hospital practice environment: A Canadian context. *Research in Nursing & Health*, 25(4), 256-68.

416. Choi, J., Bakken, S., Larson, E., Du, Y., & Stone, PW. (2004). Perceived nursing work environment of critical care nurses. *Nursing Research*. 53:370-8.

417. The Ottawa Hospital Management Work-Group. (2003). *The Ottawa Hospital model of nursing clinical practice: Clinical management span of control decision-making indicators.* Unpublished work. The Ottawa Hospital, Ottawa, ON.

418. Bar-On, R. (1987). *Bar-On Emotional Quotient Inventory: User's manual.* Toronto, ON: Multi-health Systems.

419. Mayer, J., Caruso, D., & Salovey, P. (1998). *The Multifactor Emotional Intelligence Scale*. Unpublished report available from the authors.

420. Maslach, C., & Jackson, S. (1986). *Maslach Burnout Inventory manual*. 3rd Ed.Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

421. Traynor, M., & Wade, B. The development of a measure of job satisfaction for use in monitoring the morale of community nurses in four trusts. *Journal of Advanced Nursing*, 18, 127-136.

422. Stamps, P., & Piedmonte, E. (1986). *Nurses and work satisfaction: An index for measurement.* Ann Arbor, MI: Health Administration Press Perspectives.

423. Mueller, C., & McCloskey, J. (1990). Nurses' job satisfaction: A proposed measure. *Nursing Research*, 39(2), 113-117.

424. Weiss, D., Dawis, R., England, G., & Lofquist, L. (1997). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. Industrial Relations Center, University of Minnesota, 1967.

425. Hinshaw, A., & Atwood, J. (1983-1985). *Anticipated turnover among nursing staff study*. Final report pp.292-305). DHHS Division of Nursing Grant No. 1 ROl NU00908, U. S. Department of Health and Human Services, Division of Nursing, Rockville, MD.

426. Kanungo, R. (1982). Measurement of job and work involvement. *Journal of Applied Psychology*, 67, 341349.

427. Porter, L., Steers, R., Mowday, R., & Boulian, P. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603-609.

428. Hinshaw, A., & Atwood, J. (1980). Anticipated turnover study: A pilot stage Instrument. (Abstract). *Communicating Nursing Research*, 12, 56-56.

429. Eriksen, L. (1988). *Satisfaction with nursing care questionnaire*. (Revised). Retrieved June 1, 2005 from: http://www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/ASP/instruments.asp?Instruments=Satisfaction+with+Nursing+Care+Questionnaire+%28revised%29

# Références par auteur (en ordre alphabétique)


Adams, C. (1994). Innovative behaviour in nurse executives. *Nursing Management*, 25(5), 44-47.

Advisory Committee on Health Human Resources (2000). *The Advisory Committee on Health Human Resources*. The Nursing Strategy for Canada. October 2000. Retrieved May 13, 2005 from: http://www.hc-sc.gc.ca

Aiken, L., Clarke, S., Sloane, D., Sochalski, J., Busse, R., Clarke, H., et al.(2001). Nurses reports on hospital care in five countries. *Health Affairs*, 20(3), 43-53.

Aiken, L., & Patrician, P., (2000). Measuring organizational traits of hospitals: The Revised Nursing Work Index. *Nursing Research*, 49, 146-153.

Aiken, L., Smith, H., & Lake, E. (1994). Lower Medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care. *Medical Care*, 32(5), 771-787.

Aiken, L., Sochalski, J., & Lake, E. (1997). Studying outcomes of organizational change in health services. *Medical Care,* 35(11), NS6-NS18.

Aldana, S. (2001). Financial impact of health promotion programs: A comprehensive review of the literature. *American Journal of Health Promotion*, 15(5), 296-320.

Allen-Tammy, D., et al. (2004). Career Benefits Associated with Mentoring for Proteges: A Meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*. 89(1), 127-136.

Altieri, L. (1995). *Transformational and transactional leadership in hospital nurse executives in the commonwealth of Pennsylvania: A descriptive study*. Doctoral dissertation. Fairfax, VA: George Mason University.

American Association of Colleges of Nursing (AACN) Task Force on Hallmarks of the Professional Practice Setting. (2002). *Hallmarks of the professional nursing practice environment. January, 2002*. AACN. Retrieved September 24, 2004 from: http://www.aacn.nche.edu/Publications/positions/hallmarks.htm

American Nurses Association. (2000). *Nurse staffing and patient outcomes in the inpatient hospital setting*. Washington, DC: American Nurses Publishing.

Anderson, R., Corazzini, K., & McDaniel Jr., R. (2004). Complexity science and the dynamics of climate and communication: Reducing nursing home turnover. *The Gerontologist*, 44(3), 378-388.

Anderson, R., Issel, L., & McDaniel Jr., R. (2003). Nursing homes as complex adaptive systems: Relationship between management practice and resident outcomes. *Nursing Research*. 52, 12-21.

Antrobus, S., Kitson, A. (1999). Nursing leadership: Influencing and shaping health policy and nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 29(3), 746-753.

Apker, J., Zabava Ford, W., Fox, D. (2003). Predicting nurses' organizational and professional identification: The effect of nursing roles, professional autonomy and supportive communication. *Nursing Economic$,* 21(5), 226-232.

Argyris, C., Schön, D. (1996) *Organizational learning II: Theory, method and Practice*. Reading, MA: Addison Wesley.

Association of Colleges of Applied Arts and Technology. (2001). *The 2001 environmental scan for the Association of Colleges of Applied Arts and Technology of Ontario*. Toronto, ON: Author

Avolio, BJ., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. (2004) Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behaviour*, 25(8), 951-968.

Axelsson, R. (1998). Towards an evidence-based health care management. *International Journal of Health Planning and Management*, 13, 307-317.

Baguley, K. (1999). *Workplace Empowerment, Job Strain and Affective Organizational Commitment in Critical Care Nurses: Testing Kanter's structural theory of organizational behaviour*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

Baird, A., & St-Amand, R. (1995). *Trust within the organization part 2 – Building Trus*t. Retrieved August 27, 2004 from: http://www.psccfp.gc.ca/publications/monogra/mono2_e.htm

Baker et al. (1999). Hospital consolidation. Applying stakeholder analysis to merger life-cycle. *Journal of Nursing Adminstration*. 29(3),11-20.

Ballein Search Partners (2003). *Why senior nursing officers matter: A national survey of nursing executives*. Retrieved February 23, 2005 from Website of American Organization of Nurse Executives: www.hospitalconnect.com/aone/docs/03sno-survey.pdf

Bar-On, R. (1987). *Bar-On Emotional Quotient Inventory: User's manual.* Toronto, ON: Multi-health Systems.

Barger, S. (2004). An academic-service partnership: Ideas that work. *Journal of Professional Nursing*, 20, 97-102.

Barry-Walker, J. (2000). The impact of system redesign on staff, patient and financial outcomes. *Journal of Nursing Administration*, 30(2), 77-89.

Bass, B. (1995). *Multifactor Leadership Questionnaire*. Binghamton, NY: State University of New York.

Bass, B., & Avolio, B. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. *Research in Organizational Change and Development*, 4, 231-272.

Baumann, A., Blythe, J., Kolotylo, & C., Underwood, J. (2004). *Immigration and emigration trends: A Canadian perspective.* The Nursing Sector Study Corporation. Ottawa, ON.

Bauman, A., O'Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., et al. (2001). *Commitment and care – The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients and the system.* Ottawa, ON: Canadian Health Services Research Foundation and The Change Foundation.

Beaulieu, R., Shamian, J., Donner, G., & Pringle, D. (1997). Empowerment and commitment of nurses in long-term care. *Nursing Economic$,* 15(1), 32-41.

Berwick D. (1996). Harvesting knowledge from improvement (editorial). *The Journal of the American Medical Association*, 275, 877-878.

Bethune, G. (2005). *Performance improvement: The leadership perspective. Excellence in Nursing Knowledge*. Retrieved 3/15/2005 from: *http://www.nursingknowledge.org/Portal/mian.aspx?PateIde=3514&IssueNo=7&ArticleNo*

Blais, K., Hayes, H., Kozier, B., & Erb, G. (2002). *Professional nursing practice concepts and perspectives* ,4th Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Blanchfield, K., & Biordi, D. (1996). Power in practice: A study of nursing authority and autonomy. *Nursing Administration Quarterly*, 20(3), 42-46.

Blanzola, C., Lindeman, R., & King, M.L. (2004).Nurse internship pathway to clinical comfort, confidence, and competency. *Journal for Nurses in Staff Development*. 2(20), 27-37.

Blegen, M. (1993). Nurses' job satisfaction: meta-analysis of related variables. *Nursing Research*, 42(1), 36-41

Blegen, M., Good, C., Johnson, M., Maas, M., Chen, L., & Moorhead, S. (1993). Preferences for decision-making autonomy, *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 25(4), 339-344.

Blegen, M., & Vaughn, T. (1998). A multi-site study of nurse staffing and patient occurrences. *Nursing Economic$,* 16(4), 196–203.

Bliss-Holtz, J., Winter, N., & Scherer, E. (2004). An invitation to magnet accreditation. *Nursing Management*, 35(9), 36-42.

Block, P. (1987). *The empowered manager*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Boughn, S. (1995). An instrument for measuring autonomy-related attitudes and behaviours in women nursing students. *Journal of Nursing Education*, 34, 106-113.

Boumans, N., & Landeweerd, J. (1993). Leadership in the nursing unit: Relationships with nurses' well being. *Journal of Advanced Nursing*. 18(5), 767-775.

Bousfield, C. (1997). A phenomenological investigation into the role of the clinical nurse specialist. *Journal of Advanced Nursing*, 25(2), 245-256.

Bowman, D. *The five best ways to build – and lose – trust in the workplace*. Retrieved September 24, 2004 from: http://www.ttgconsultants.com/articles/trustworkforce.html

Boyle, D., Bott, M., Hansen, H., Woods, C., & Taunton, R. (1999). Managers' leadership and critical care nurses' intent to stay. *American Journal of Critical Care, 8(6), 361-371*.

Boyle, DK., & Kochinda, C. (2004). Enhancing collaborative communication of nurse and physician leadership in two intensive care units. *The Journal of Nursing Administration*. 34(2), 60-70.

Boyle SM. (2004). Nursing unit characteristics and patient outcomes. *Nursing Economics* 3(22) 111-9.

Branch, C., & Fraser, I. (2001). Can cultural competency reduce racial and ethnic health disparities? *Medical Care Research and Review*, 57(1), 181-217.

Bryman, A., Brensen, M., Beadswoth, A., Ford, J., & Keil, E. (1987). The concept of the temporary system: The case of the construction project. *Research in the Sociology of Organizations* 5, 253-283.

Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). *First break all the rules*. New York: Simon and Schuster.

Bunderson, J. (2001). How work ideologies shape the psychological contracts of professional employees: Doctors responses to perceived breach. *Journal of Organizational Behaviour*, 22, 717-741.

Burner, O. (1983). The organizational structure of air force hospitals and its effect on management of nursing services. *Dissertation Abstracts International*, 43 (7). 2, 431A.

Burns, J. (1978). *Leadership*. New York: Harper and Row.

Cadman, C., & Brewer, J. (2001). Emotional intelligence: A vital prerequisite for recruitment in nursing. *Journal of Nursing Management*, 9(6), 321-324.

Campbell SL, Fowles ER, & Weber BJ. (2004). Organizational structure and job satisfaction in public health nursing. *Public Health Nursing*. 6(21), 564-71.

Canadian Health Services Research Foundation. *Key research themes – Nursing leadership organization and policy*. Retrieved from the CHSRF website June 2, 2005: http://www.chsrf.ca/research_themes/nlop_e.php

Canadian Health Services Research Foundation (2004). *Listening for direction II. National consultation on health services and policy issues for 2004-2007*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Institute for Health Information. (2001). *Supply and distribution of Registered Nurses in Canada, 2000.* Ottawa, ON: Author.

Canadian Institute for Health Information. (2002). *Supply and distribution of Registered Nurses in Canada, 2001*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Institute for Health Information. (2002). *Workforce trends of Registered Nurses in Canada, 2002*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Institute for Health Information. (2004). *Workforce trends of Registered Nurses in Canada, 2004*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (2000). First Minister's Meeting Communiqué on Health. News Release. First Ministers' Meeting Ottawa, ON: September 11, 2000.

Canadian Nurses Association. (October, 2003). *Ethical distress in health care environments. Ethics in practice for Registered Nurses*. Retrieved February 23, 2005 from: http://www.cna-nurses.ca/cna/practice/ethics/inpractice/default_e.aspx

Canadian Nurses Association. (2002). *Planning for the future: Nursing human resource projections.* Ottawa, ON: Author

Canadian Nurses Association. (2005). *Nursing leadership in a changing world. Nursing Now, Issues and Trends in Canadian Nursing*, 18(1). Retrieved April 22, 2005 from: http://www.cna-nurses.ca/cna/

Canadian Nurses Association. (2001). *Quality professional practice environments for Registered Nurses*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Nurses Association (2003). *Succession planning for nursing leadership*. Ottawa, ON: Author.

Canadian Nursing Advisory Committee. (2002). *Our health, our future: Creating quality workplaces for Canadian nurses.* Ottawa, ON: Advisory Committee on Health Human Resources.

Cardin, S. (1995). *Outcomes of unit effectiveness in relation to the leadership role of nurse managers in critical care nursing*. Doctoral dissertation. University of California, Los Angeles.

Carney M. (2004). Middle manager involvement in strategy development in not-for profit organizations: the director of nursing perspective – how organizational structure impacts on the role. *Journal of Nursing Management*. 1(12), 13-21.

*Carper, B. (1978). Fundamental patterns of knowing in nursing.* Advanced Nursing Science. *1(1), 13-23.*
Cathcart, D., Jeska, S., Karnas, J., Miller, S. Pechacek, J., & Rheault, L. (2004). Span of control matters. *Journal of Nursing Administration*, 34(9), 395–399.

Chandler, G. (1986). *The relationship of nursing work environments to empowerment and powerlessness*. Doctoral Dissertation. University of Utah.

Cherniss, C., Goleman, D., Emmerling, R., Cowan, K., & Adler, M. (1998). *A technical report issued by the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations.* Retrieved 4/21/2004 from:
http://www.eiconsortium.org/research/technical_report.htm

Chiok Foong Loke, J. (2001). Leadership behaviours: Effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. *Journal of Nursing Management*. 9(4), 191-204.

Cho, S., Ketefian, S., Barkauskas, V., & Smith, D. (2003). The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality and medical costs. *Nursing Research,* 52(2), 71–79.

Choi, J., Bakken, S., Larson, E., Du, Y., & Stone, PW. (2004). Perceived nursing work environment of critical care nurses. *Nursing Research*. 53:370-8.

Clarke, M., & Oxman, A.D. (1999). *Cochrane Reviewers' Handbook*, 4th Ed.. Oxford, UK: The Cochrane Collaboration.

Clifford, J. (1998). *Restructuring: The Impact of hospital organization on nursing leadership.* San Francisco, CA: American Hospital Association.

Cochrane Collaboration. *Cochrane and systematic reviews: Levels of evidence for health care interventions.* Retrieved May 7, 2005 from: *http://www.cochrane.org/consumers/sysrev.htm#levels*

Coeling, H., & Simms, L. (1993). Facilitating innovation at the nursing unit level through cultural assessment, part 1: How to keep management ideas from falling on deaf ears. *Journal of Nursing Administration*, 23(4), 46-53.

Coff, R., & Rousseau, D. (2000). *Sustainable competitive advantage and employability: Is it a "win-win" situation?* In Leana, CR. and Rousseau, DM. (Eds.). *Relational wealth: The advantages of stability in a changing economy*. Oxford: Oxford University Press.

Coile, R. (1999). Magnet hospitals: Ten Strategies to becoming a model nursing employer. *Russ Coile's Health Trends*, 11(8), 1-4.

College of Nurses of Ontario. (2002). *Professional standards*. Toronto, ON: Author

Collins, D. (2002). *The effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982-2001.* Doctoral dissertation. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.

Collins, D., & Holton, E. (2004). The Effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982 to 2001. *Human Resources Development Quarterly*. 15(2), 217-248.

Conchie, B. (2004). The seven demands of leadership. What separates great leaders from all the rest? *Gallup Management Journal*, May 13, 2004. Retrieved December 8, 2004 from: http://gmj.gallup.com/content/default.asp?ci=11614

Conger, J., & Kanungo, J. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. *Academy of Management Review*, 13(3), 471-482.

Cook, J., Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment. *Journal of Occupational Psychology*, 53, 39-52.

Cooke, R., & Lafferty, J. (1987). *Organizational Culture Inventory (OCI).* Plymouth, MI: Human Synergistics.

Cooperrider, D., & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational life part 2. *Research in organizational Change and Development*, 1, 129-169.

Corley, M. (1995). Moral distress of critical care nurses. *American Journal of Critical Care*, 4(4), 280-285.

Corley, M., Elswick, R., Gorman, M., & Clor, T. (2001). Development and evaluation of a moral distress scale. Journal of Advanced Nursing*, 33(2) 250-256.*

Corrigan, P., Lickey, S., Campion, J., & Rashid, F. (2000). Mental health team leadership and consumers' satisfaction and quality of life. *Psychiatric Services*. 51(6), 781-785.

Council of Ontario University Programs in Nursing. (2002). *Position statement on nursing clinical education*. Toronto, ON: Author.

Covey, SR., (1990). *The 7 Habits of Highly Effective People,* New York: Simon & Schuster.

Cronkhite, L. (1991). *Role of the hospital nursing administrator in a changing health care environment – A study of conflicts and values.* Doctoral dissertation. University of Milwaukee, Wisconsin.

Crossley, J. (1993). Chief nursing officer governing body proximity, direct reporting relationship and professionalism as predictors of chief nursing officer role conflict and role ambiguity. *Dissertation Abstracts International*, 54 (4), 1, 887B.

Cummings, G., & Estabrooks, C. (2003). The effects of hospital restructuring that included layoffs on individual nurses who remained employed: A systematic review of impact. *International Journal of Sociology and Policy*. 23(8/9), 8-53.

Cummings, G., Hayduk, L., Estabrooks, C. (2005). Mitigating the impact of hospital restructuring on nurses: the responsibility of emotionally intelligent leadership. *Nursing Research.* 2(54) 2-12.

Cummings, G., & McLennan, M. (2005). Advanced practice nursing. Leadership to effect policy change. *Journal of Nursing Administration*, 35(2), 61- 66.

Cummings, G.G. (2004) Investing relational energy: The hallmark of resonant leadership. *Canadian Journal of Nursing Leadership*. 17(4): 76-87

Cunningham G., & Kitson, A. (2000). An evaluation of RCN clinical leadership development programme (part 1). *Nursing Standard*, 15(12), 34-37.

Cunningham, G., & Kitson, A. (2000). An evaluation of RCN clinical leadership development programme (part 2). *Nursing Standard*, 15(13-15), 34-40.

Daly, B., Douglas, S., & Kelley, C. (2005). Benefits and challenges of developing a program of research. *Western Journal of Nursing Research*, 27(3), 364-377.

Davenport, T., DeLong, D., & Beers, M. (1998). Successful knowledge management projects. *Sloan Management Review*, 39(2), 43-57.

*Definitions of Fairness*. Retrieved June 2, 2005, 2004 from:
http://www.google.ca/search?hl=en&lr=&oi=defmore&q=define:fairness www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn

DeLong, D., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. *Academy of Management Executive*, 14(4), 113-127.

Dempster, J. (1991). *Dempster practice behaviours scale. Instrumentation for measurement of autonomy*. Los Angeles, CA: American Nurses Council of Nurse Researchers Meeting, 1991 Proceedings.

Devine, G., & Turnbull, L. (2002). *Nurses' definitions of respect and autonomy in the workplace: Summary of focus groups with Canadian nurses*. Retrieved May 4, 2005 from: www.hc-sc.gc.ca/english/for-you/nursing/cnac/report/appendixC.htm

Dirks, K., & Ferrin, D. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for organizational research. *Journal of Applied Psychology,* 87, 611-628.

Disch, J., Walton, M., & Barnsteiner, J. (2001). The role of the clinical nurse specialist in creating a healthy work environment. *AACN Clinical Issues*, 12(3), 345-355.

Donaldson, N., & Rutledge, D. (1998). Expediting the harvest and transfer of *knowledge for practice in nursing: Catalyst for a journal.* The Online Journal of Clinical Innovations *1(2), 1-25.*

Dreachslin, J. (2002). Communication: Bridging the racial and ethnic divide in health care management. *Health Care Manager*, 20(4), 10-18.

Drucker, P. (1990). *Managing the non-profit organization. Principles and practices*. New York: Harper Collins Publishers.

Dubuc, L. (1995). *Job empowerment and commitment in military nursing: An extension study*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

Dugan, J., Lauer, E., Bouquot, Z., Dutro, B., Smith, M. & Widmeyer, G. (1996). Stressful nurses: The effect on patient outcomes. *Journal of Nursing Care Quality,* 10(3), 46–58.

Dunham, J., & Fisher, E. (1990). Nurse executive profile of excellent nursing leadership. *Nursing Administration Quarterly*, 15(1), 1-5.

Dunham-Taylor, J. (1995). Identifying the best in nurse executive leadership, Part 2, interview results. *Journal of Nursing Administration*. 25(7), 24-31.

Dunleavy, J., Shamian, J., & Thomson, D. (2003). Workplace pressures: Handcuffed by cutbacks. *Canadian Nurse,* 99(3), 23-26.

Duxbury, L., & Higgins, C. (2003). *Work-life conflict in Canada in the new millennium. A status report*. Retrieved February 15, 2006 from http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/work-travail/report2/index.html

Duxbury, M., Henly, G., & Armstrong, G. (1982). Measurement of the nurse organizational climate of neonatal intensive care units. *Nursing Research*, 32(2), 83-88.

Ekvall, G., Arvonen, J., & Waldenstrom-Lindbald, I. (1983). *Creative organizational climate, construction and validation of a measuring instrument*. Stockholm: Fa-institute.

Emmerling, R., & Goleman, D. (2003). (October*). Emotional intelligence issues and common misunderstandings*. Retrieved June 8, 2005 from: http://eqi.org/gole3.htm

Englebart, S. (1993). *The relationship of nurse manager behaviours and characteristics to subordinates' perceptions of the work unit climate*. Doctoral dissertation. Virginia Commonwealth University.

Erickson, J., Hamilton, G., Jones, D., & Ditomassi, M. (2003). The value of collaborative governance/staff empowerment. *Journal of Nursing Administration*, 33(2), 96-104.

Eriksen, L. (1988). *Satisfaction with nursing care questionnaire*. (Revised). Retrieved June 1, 2005 from: http://www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/ASP/instruments.asp?Instruments=Satisfaction+with+Nursing+Care+Questionnaire+%28revised%29

Erickson, M., Duffy, M., Gibbons, P., Fitzmaurice, J., Ditomassi, M., & Jones, D. (2004). Development and psychometric evaluation of the Professional Practice Environment (PPE) scale. *Journal of Nursing Scholarship*, 36(3), 279-285.

Estabrooks, C., Midodzi, W., Cummings, G., Ricker, K.,& Giovannetti, P. (2005). The impact of hospital nursing characteristics on 30-day mortality. *Nursing Research,* 54(2), 74-84.

Estabrooks, C., Tourangeau, A., Humphrey, C., Hesketh, K., Giovannetti, P., Thomson, D., et al. (2002). Measuring the hospital practice environment: A Canadian context. *Research in Nursing & Health*, 25(4), 256-68.

Evans, J. (1992). *A preliminary study to develop an instrument to measure head-nurse self-efficacy*. Abstract from 5th national conference on Nursing Administration Research.

Farley, M. Assessing communication in organizations. *Journal of Nursing Administration*, 19(12), 27-31.

Fenton, M. (1988). Moral distress in clinical practice: Implications for the nurse administrator. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 1, 8-11.

Ferguson-Paré, M. (1998). Nursing leadership and autonomous professional practice of Registered Nurses. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 11(2), 7-30.

Ferguson-Paré, M., Mitchell, G., Perkin, K., & Stevenson, L. (2002). Academy of Canadian Executive Nurses (ACEN) background paper on leadership. *Canadian Journal of Nursing Leadership, 15(3), 4-8.*

Field, M., & Lohr, K. (1990). *Guidelines for clinical practice: Directions for a new* program. *Washington, DC: Institute of Medicine, National Academy Press.*

First Ministers' Meeting on the Future of Health Care (2004). Retrieved between Nov 2004 – June 2005. http://www.hc-sc.gc.ca/english/hca2003/fmm/index.html

Fletcher, C. (2001). Hospital RNs' job satisfaction and dissatisfactions. *Journal of Nursing Administration,* 31(6), 324-31.

Foley, R., & Wurmser, TA. (2004). Culture Diversity/A Mobile Workforce Command Creative Leadership, New Partnerships, and Innovative Approaches to Integration. *Nursing Administration Quarterly*. *Reconstructing Healthcare in a Global Marketplace. 28(2) 122-128.*

Fox, R., Fox, D., & Wells, P. (1999). Performance of first-line management functions on productivity of hospital unit personnel. *Journal of Nursing Administration*. 29(9), 12-18.

Garvin, D. (1993). Building a learning organization. *Harvard Business Review*, (4), 78-91.

Gasper, J. (1992). *Transformational Leadership: An integrative review of the literature*. Doctoral dissertation, Western Michigan University.

Gaudine, A., & Beaton, M. (2002). Employed to go against one's values: Nurse managers' accounts of ethical conflict with their organizations. *Canadian Journal of Nursing Research*, 34(2), 17-34.

Gelinas, L., & Manthey, M, (1997). The impact of organizational redesign on nurse executive leadership. *Journal of Nursing Administration*, 27(10), 35-42.

George, V., Burke, L., Rodgers, B., Duthie, N., Hoffmann, M., Koceja, V., et al. (2002). Developing staff nurse shared leadership behaviour in professional nursing practice. *Nursing Administration Quarterly*, 26(3), 44-59.

Giber, D., Carter, L., & Goldsmith, M. (2000). *Best practices in leadership development handbook*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Gifford, B., Zammuto, R., & Goodman, E. (2002). The relationship between hospital unit culture and nurses' quality of work life. *Journal of Healthcare Management*, 47(1), 13-25.

Gil, F., et al. (2005). Change-oriented leadership, satisfaction and performance in work groups: Effects of team climate and group potency. *Journal of Managerial Psychology*. 20(3/4), 312-328.

Gillert , A., & Chuzischvili, G. (2004) Dealing with Diversity; A Matter of Beliefs. *Industrial and Commercial Training*, 36(40), 166-170.

Gillespie, NA., & Mann, L. (2004) Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust. *Journal of Managerial Psychology*. 19(6), 588-607.

Gittell, J. (2001). Supervisory span, relational coordination and flight departure performance: A reassessment of post-bureaucracy theory. *Organization Science*, 12, 468–483.

Glasgow, RE., Klesges, LM., Dzewaltowski, DA., Bull, SS., & Estabrooks, P. (2004). The future of health behavior change research: What is needed to improve translation of research into health promotion practice? *Annals of Behavioral* Medicine, 27(1), 3-12.

Goddard, M., & Laschinger, H. (1997). Nurse managers' perceptions of power and opportunity. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 10(2), 40-66.

Gokenbach, V. (2004) *The effects of an empowerment model intervention on registered nurse turnover and absenteeism*. Doctoral dissertation. University of Phoenix

Goldhaber, G., & Rogers, D. (1979). *Auditing organizational communication systems: The ICA communication audit*. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. New York: Bantam Books.

Goleman, D., Boyatzis, & R., McKee. (2002). *Primal leadership: Recognizing the power of emotional intelligence*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Goodman, P. (2001). *Missing organizational linkages: Tools for cross-level organizational research.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Government of Quebec. (1994). *An Act respecting health services and social services. R.S.Q., chapter S-4.2.* (Updated to 5 July 1994. Last amendment 17 June, 1994).

Govers, M. (1997). *Workplace empowerment and job performance in ambulatory care*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

Greenberg, L. (1996). *Allowing and accepting emotional experience*. In: Kavanaugh, R., Zimmerberg, B., Fein, S. (Eds.*), Emotion: Interdisciplinary perspectives*. pp. 315-336. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Griffin, P., El-Jardali, F., Tucker, D., Grinspun, D., Bajnok, I., & Shamian, J. (2004). *Healthy work environments: Building a conceptual model.* Submitted for publication.

Grinspun, D. (2000). Taking care of the bottom line: Shifting paradigms in hospital management. In D.L. Gustafson (Ed.), *Care and consequences.* Halifax, NS: Fernwood Publishing.

Grinspun, D. (2000). *The social construction of nursing caring*. Doctoral dissertation proposal. Toronto, ON: York University.

Gullo, SR., & Gerstle, DS. (2004). Transformational leadership and hospital restructuring: a descriptive study. *Policy, Politics, & Nursing Practice*. 11(5) 259-66.

Haines, J. (1993). *Leading in a time of change. The challenge for the nursing profession – A discussion paper*. Ottawa, ON: Canadian Nurses Association.

Hanna, L. (1999). Lead the way, leader. *Nursing Management*, 30(11), 36-39.

Hansen, M., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing Knowledge? *Harvard Business Review*, 77(2), 106-116.

Harrison, R. (1992). *Diagnosing organizational culture*. New York: Pfeiffer.

Harvard Business Review. (2001). *Managing Diversity*. Harvard Business School Press.

Hatcher, S., *The relationship between power perceptions of nurse managers and burnout: A test of Kanter's theory of structural power*. Master's thesis. University of Western Ontario. London, ON.

Hatcher, S., & Laschinger, H. (1996). Staff nurses' perceptions of job empowerment and level of burnout: A test of Kanter's theory of structural power in organizations. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 9(2), 74-94.

Havens, D., & Vasey, J. (2003). Measuring staff nurse decisional involvement: decisional involvement scale. *Journal of Nursing Administration*. 33(6), 331-336.

Health Canada. Office of Nursing Policy. Retreived Retrieved October 6, 2005 from: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpb-dgps/onp-bpsi/index_e.html

Health Canada 2003 First Ministers' Accord on Health Care Renewal. Retrieved May 5, 2005 from: www.healthservices.gov.bc.ca/ bchealth care/publications/health_accord.pdf

Hechanova-Alampay, R., & Beehr., T. (2001). Empowerment, span of control, and safety performance in work teams after workforce reduction. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6(4), 275–282.

Heeley, F. (1998). Leading with integrity: How to balance conflicting values. *Health Progress*, 79(5), 60-62.

Heifetz, R., & Laurie, D. (2001). The work of leadership. *Harvard Business Review*, (2), 106-117.

Heller, F. (2003). Participation and power: A critical assessment. *Applied Psychology: An International Review*. 52, 144-163.

Hemman E. (2000). Leadership profiles of senior nurse executives *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 13(1), 21-30.

Henderson, A. (2003). Nurses and workplace violence: Nurses' experience of verbal and physical abuse at work. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 16(4), 82-98.

Herbert, R., & Edgar, L. (2004). Emotional intelligence: A primal dimension of nursing leadership? *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 56-63.

Hersey, P., & Blanchard, K. (1988). *Management of organizational behaviour: Utilizing human resources*. (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hinshaw, A. (1986). *Socialization and resocialization of nurses for professional nursing practice*. In: Hein, E.C., Nicholson. M.E. (Eds.), *Contemporary leadership behaviour: Selected readings*, 2nd ed. Boston: MA: Little, Brown.

Hinshaw, A., & Atwood, J. (1983-1985). *Anticipated turnover among nursing staff study*. Final report pp.292-305). DHHS Division of Nursing Grant No. 1 ROl NU00908, U. S. Department of Health and Human Services, Division of Nursing, Rockville, MD.

Hinshaw, A., & Atwood, J. (1980). Anticipated turnover study: A pilot stage Instrument. (Abstract). *Communicating Nursing Research*, 12, 56-56.

Hood, J., & Smith, H. (1994). Quality of work life in home care: The contribution of leaders' personal concern for staff. *Journal of Nursing Administration*, 24(1), 40-47.

Houghton Mifflin Company, (2004). Identity. *The American heritage dictionary of the English language*. 4th ed. Retrieved June 6, 2005 from: Answers.com: http://www.answers.com/main/ntquery?tname=identity&print=true

Houghton Mifflin Company, 1995. Identity. *Roget's II: The New Thesaurus*. 3rd ed. Retrieved June 6, 2005 from: Answers.com: http://www.answers.com/main/ntquery?tname=identity&print=true

Howard, A. (1997). *The empowering leader: Unrealized opportunities*. In: *The Balance of Leadership and Followership Working Papers*, Baltimore, MD: Academy of Leadership Press.

Huber, D., Maas, M., McCloskey, J., Scherb, C., Goode, C., & Watson, C. (2000). Evaluating nursing administration instruments. *Journal of Nursing Administration*, 30(5), 251-272.

Huffman, J. (1995). *Staff nurses' perceptions of work empowerment and control over nursing practice in community hospital settings*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

Hui, C. (1994). *Effects of leader empowerment behaviours and follower's personal control, voice and self-efficacy on in-role and extra-role performance. An extension of Conger and Kanungo's empowerment process model.* Doctoral dissertation, Indiana University, Indiana.

Hurst, J. (1996). Building hospital TQM teams: Effective polarity analysis and maximization. *The Health Care Supervisor*, 15(1), 68-75.

Huy, Q. (2002). Emotional balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers. *Administrative Science Quarterly*, 47, 31-69.

Ingersoll, G., Fisher, Ross, B., Soja, M., & Kidd, N. (2001). Employee response to major organizational redesign. *Applied Nursing Research, 14(1), 18-28.*

Institute of Medicine of the National Academies, Board on Health Care Services. (2004). *Keeping patients safe: Transforming the work environment of nurses.* Washington, DC: National Academy Press.

Irvine, D., & Evans, M. (1992). Job satisfaction and turnover among nurses: A review and meta-analysis. *Quality of Nursing Worklife Research Unit Monograph Series*. University of Toronto.

Jameton, A. (1984). *Nursing practice: The ethical issues*. Englewoood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

*JCAHO Standards and Reference Crosswalk Contents*. Retrieved June 2, 2005 from:
http://www.wramc.army.mil/JCAHO/Division.cfm?d_Id=13

Jeans, M., & Rowat, K. (2005). *Competencies required of nurse managers: Identifying the skills, personal attributes and knowledge required of nurse managers, and the enablers and barriers for nurse managers to acquire and sustain these competencies. The pulse of renewal: A focus on nursing human resources. May, 2005. Special report*. Toronto, ON: Canadian Journal of Nursing Leadership.

Johnson, D., & Johnson, R. (1995). *Social interdependence, cooperative learning in education*. In: B.B. Bunker and J.Z. Rubin (Eds.), *Conflict, cooperation and justice.* San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Jones K. (2005). Leading an empowered organization (LEO): does it work? *British Journal of Community Nursing*.10, 92-6.

Jones, L., Soeken, K., & Guberski, T. (1986). Development of an instrument to measure self-reported leadership behaviours of nurse practitioners. *Journal of Professional Nursing*, 3, 180-185.

Joni, S. (2004). The geography of trust. *Harvard Business Review*, 82, 83-88

Judkins SK. (2004). Stress among nurse managers: can anything help? *Nurse Researcher*. 12, 58-70.

Kanter, R. (1999). The enduring skills of change leaders. *Leader to Leader*, 13(3). Retrieved April 29, 2004 from:
http:www.pfdf.org/leaderbooks/121summer99/kanter.html

Kanter, R. (1993). *Men and women of the corporation.* 2nd ed. New York: Basic Books.

Kanter, R (1979). Power failure in management circuits. *Harvard Business Review*, 57(4), 65-75.

Kanungo, R. (1982). Measurement of job and work involvement. *Journal of Applied Psychology*, 67, 341349.

Katz, R. (1982). The effects of group longevity on project communication and performance. *Administrative Science Quarterly*, 27, 81-104.

Katzman, E., (1989). Nurses' and physicians' perceptions of nursing authority. *Journal of Professional Nursing*, 5(4), 208-214.

Kemerer, R. (2003). Leadership: What works in the real health care world. *Healthcare Papers.* 4(1), 37-38.

Kilty, H. (2003). *Nursing leadership development in Canada. A descriptive status report and analysis of leadership programs, approaches and strategies: Domains and competencies; knowledge and skills; gaps and opportunities.* Ottawa, ON: Canadian Nurses Association.

King, T. (2000). Paradigms of Canadian nurse managers: Lenses for viewing leadership and management. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 12(1), 15-20.

Kitson, A., Harvey, G., & McCormack, B. (1998). Enabling the implementation of evidence-based practice: A conceptual framework. *Quality in Health Care*, 7(3), 149-158.

Knox, S., & Irving, J., (1997). An interactive quality of work life model applied to organizational transition. *Journal of Nursing Administration*, 27(1), 39-47.

Knox, S., & Irving, J. (1997). Nurse manager perceptions of health care executive behaviours during organizational change. *Journal of Nursing Administration*, 27(11), 33-39.

Kofman, R. (1994). Check-in, check-out: A tool for real conversations. *The Systems Thinker*, 5(4), 8-9.

Kouzes, J.,& Posner, B. (1995). *The leadership challenge. How to keep getting extraordinary things done in organizations.* San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kouzes, J., & Posner, B. (1988). *The Leadership Practices Inventory*. San Diego, CA: Pfeiffer.

Kovner, A., Elton, J., & Billings, J. (2000). Transforming health management: An evidence-based approach. *Frontiers of Health Services Management*, 16(4), 3-24.

Kovner, C., & Gergen, P. (1998). Nurse staffing levels and adverse events following surgery in US hospitals. *Image: Journal of Nursing Scholarship,* 30(4), 315-321.

Kramer, M., & Schmalenberg, C. (1988). Magnet hospitals – Part I: Institutions of excellence. *Journal of Nursing Administration. 18(1), 13-24.*

Kramer, M., & Schmalenberg, C. (1988). Magnet hospitals – Part II: Institutions of excellence. *Journal of Nursing Administration*. *18(2), 1-11*.

Kramer M., Schmalenberg, C. (2003). Magnet hospital staff nurses describe clinical autonomy. *Nursing Outlook*, 51, 13-19.

Kramer, M., & Schmalenberg, C. (2002). *Staff nurses identify essentials of magnetism*. In: McClure, M., Hinshaw. A. (Eds.), *Magnet hospitals revisited: Attraction and retention of professional nurses*. Washington, DC: American Nurses Publishing.

Kramer, M, & Schmalenberg, C., & Maguire, P. (2004). Essentials of a magnetic work environment: part 3. *Nursing*, 8(34) 44-7.

Krecji, J. (1999). Changing roles in nursing: Perceptions of nurse administrators. *Journal of Nursing Administration*, 29(3), 21-29.

Kroposki, M., Murdaugh, C., Tavakoli, A., & Parsons, M. (1999). Role clarity, organizational commitment and job satisfaction during hospital reengineering. *Nursing Connections*, 12(1), 27-34.

Krugman, M. (1989). *An investigation of the relationship between nurse executive socialization and occupational image*. Doctoral dissertation. University of Denver.

Lageson, C. (2001). *First line nurse manager and quality: Relationship between selected role functions and unit outcomes*. Doctoral dissertation. University of Wisconsin-Milwaukee.

Lageson C. (2004). Quality focus of the first line nurse manager and relationship to unit outcomes. *Journal of Nursing Care Quality*. 4(19) 336-42

Lake, E. (2002). Development of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. *Research in Nursing and Health*, 25(3), 176-188.

Lambert, V., & Nugent, KE. (1999). Leadership Style for facilitating the Integration of Culturally Appropriate Health Care *Seminars for Nurse Managers* 7(4) 172-178

Laschinger, H. (2004). Hospital nurses' perceptions of respect and organizational justice. *Journal of Nursing Administration*, 34(7/8), 354-364.

Laschinger, H. (2004). *Scoring of nursing work empowerment scales* Retrieved June 2, 2005 from: http://publish.uwo.ca/~hkl/scoring.html

Laschinger, H. (1996). A theoretical approach to studying work empowerment in nursing: A review of studies testing Kanter's theory of structural power in organizations. *Nursing Administration Quarterly*, 20(2), 25-41.

Laschinger, H., Almost, J., Purdy, N., & Kim, J. (2004). Predictors of nurse managers' health in Canadian restructured health care settings. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 88-105.

Laschinger, H., Almost, J., & Tuer-Hodes, D. (2003). Workplace empowerment and magnet hospital characteristics. *Journal of Nursing Administration*, 33(7/8), 410-422.

Laschinger, H., Finegan, J., & Shamian, J. (2001). The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses' work satisfaction and organizational commitment. *Health Care Management Review*, 26(3), 7-23.

Laschinger, H., Finegan, J., & Shamian, J. (2001). Promoting nurses' health: Effect of empowerment on job strain and work satisfaction. *Nursing Economic$*, 19(2), 42-52.

Laschinger, H., Finegan, J., Shamian, J., & Casier, S. (2000). Organizational trust and empowerment in restructured health care settings: Effects on staff nurse commitment. *Journal of Nursing Administration*, 30(9), 413-425.

Laschinger, H., Finegan, J., Shamian, J., & Wilk, P. (2000). Impact of structural and psychological empowerment on job strain in nursing work settings: Expanding Kanter's model. *Journal of Nursing Administration*, 31(5), 260-272.

Laschinger, H., & Havens, D. (1997). The effect of workplace empowerment on staff nurses' occupational mental health and work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*, 27(6), 42-50.

Laschinger, H., & Havens, D. (1996). Staff nurse work empowerment and perceived control over nursing practice. Conditions for work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*, 26(9), 27-35.

Laschinger, H., Sabiston, J., & Kutszcher, L. (1997). Empowerment and staff nurse decision involvement in nursing work environments: Testing Kanter's theory of structural power in organizations. *Research in Nursing & Health*, 20, 341-352.

Laschinger, H., & Shamian, J. (1994). Staff nurses' and nurse managers' perceptions of job related empowerment and managerial self efficacy. *Journal of Nursing Administration*, 24(10), 38-47.

Laschinger, H., Shamian, J., & Thomson, D. (2001). Impact of magnet hospital characteristics on nurses' perceptions of trust, burnout, quality of care and work satisfaction. *Nursing Economic$,* 19, 209-219.

Laschinger, H., Wong, C., McMahon, C., & Kaufmann, C. (1999). Leader behaviour impact on staff nurse empowerment, job tension and work effectiveness. *Journal of Nursing Administration*. 29(5), 28-39.

Leach, LS. (2005). Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. *Journal of Nursing Administration*. 35, 228-37.

Leana, C., & VanBuren, H. (1999). Organizational social capital and employment practices. *Academy of Management Review*, 24, 538-555.

Leger Marketing. (2003). *How Canadians perceive various professions*. Retrieved June 8, 2005 from: www.rnantnu.ca/news/trusted_pros.pdf

Lemire Rodger, G. (2005). *Leadership challenges and directions*. In: Hibberd, J.M., Smith, D.L. (Eds.), *Nursing leadership and management in Canada,* 3rd Ed. Toronto, ON: Elsevier Canada.

Levasseur, R. (2004). *The impact of a transforming leadership style on follower performance and satisfaction: A meta-analysis.* Doctoral dissertation. Walden University.

Lewicki, R., & Bunker, B. (1996). *Developing and maintaining trust in work relationships*. In Kramer, R.N., Tyler T.R. (Eds.), *Trust in organizations: Frontiers in theory and research*, pp. 114-139. Thousand Oaks, CA: Sage.

Lindholm, M., Dejin-Karlsson, P., Östergren, P-O., & Udén, G. (2003). Nurse managers' professional networks, psychosocial resources and self-rated health. *Journal of Advanced Nursing*, 42(5), 506-515.

Litwin, G., & Stringer, R. (1968). *Motivation and organizational climate*, 2nd Ed. Boston, MA: Division of Research, Harvard University.

Long, J. (2004). *Factors that influence nurse attrition: An analysis of the relationship between supervisor leadership style and subordinate job satisfaction*. Doctoral dissertation. Capella University.

Lowe, G. (2004). *Healthy workplace strategies: Creating change and achieving results*. Prepared for the Health Strategies Bureau, Health Canada. Graham Lowe Group Inc.

Lowe, G. (2004*). Thriving on healthy: Reaping the benefits in our workplaces.* Keynote presentation at the RNAO 4th Annual International Conference – Healthy Workplaces in Action 2004: Thriving in Challenge. *17 November 2004, Markham, ON*

Lundstrom, T., Pugliese, G., Bartley, J., Cos, J., & Guither, C. (2002). Organizational and environmental factors that affect worker health and safety and patient outcomes. *American Journal of Infection Control,* 30(2), 93-106.

Maas, M., & Jacox, A. (1977). *Guidelines for nurse autonomy/patient welfare*. New York: Appleton-Century Crofts.

Macy, B., Peterson, M., & Norton, L. (1989). A test of participation theory in a work redesign field setting: Degree of participation and comparison site contrasts. *Human Relations*, 42, 1095-1165.

Madison, J. (1994). The value of mentoring in nursing leadership: A descriptive study. *Nursing Forum* 29(4), 16-23.

Maehr, J., & Braskamp, L. (1986). *The motivation factor: A theory of personal investment*. Lexington, MA: Lexington Books.

Manojlovich, M. (2005). A leadership strategy to improve practice. *Journal of Nursing Administration*. 35(5), 271-278.

Maslach, C., & Jackson, S. (1986). *Maslach Burnout Inventory manual*. 3rd Ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Maslove, L. & Fooks, C. (2004). *Our health, our future: Creating quality workplaces for Canadian nurses – A progress report on implementing the final report of the Canadian Nursing Advisory Committee*. Ottawa, ON: Canadian Policy Research Networks Inc.

May, D., Hodges, T., Chan, A., & Avolio, B. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. *Organizational Dynamics*, 32(3), 247-260.

Mayer, J., Caruso, D., & Salovey, P. (1998). *The Multifactor Emotional Intelligence Scale*. Unpublished report available from the authors.

Mayer, J., & Salovey, P. (1997). *What is emotional intelligence?* In: Salovey, P., Sluyter, D.J. (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications*. pp. 3-31. New York: Basic Books.

Mayer, R., Davis, J., & Schoorman, F., (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.

Mayer, R., & Gavin, M. (1999). *Trust for management and performance: Who minds the shop while the employees watch the boss*? Presented in an interactive paper session at Academy of Management annual meeting, Chicago.

McBurney, M. (1997). *The Relationship between first-line nurse managers' perceptions of job-related empowerment and occupational stress in a large acute care teaching hospital*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

McClure, M., Poulin, M., Sovie, M., & Wandelt, M. (2002). *Magnet hospitals: Attraction and retention of professional nurses (The Original Study)*. In M. McClure M., Hinshaw, A. (Eds.), *Magnet hospitals revisited.* Washington, DC: American Academy of Nurses.

McCutcheon, A. (2004). *The relationship between span of control, leadership and performance.* Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto.

McDaniel, C., & Wolf, G. (1992). Transformational leadership in nursing service. A test of theory. *Journal of Nursing Administration*. 22(2), 60-65.

McDermott, K., Laschinger, H., & Shamian, J. (1996). Work empowerment and organizational commitment. *Nursing Management*, 27(5), 44-49.

McDowell, Avril (2004). *What strategies will support leaders during rapid change?* Masters thesis. Royal Roads University.

McGillis Hall, L. (Ed.). (2004). *Quality work environments for nurse and patient safety*. Sudbury, MA: Jones and Barlett Publishers.

McGillis Hall, L., McGilton, K., Krejci, J., Pringle, D., Johnston, E., Fairley, L., & Brown, M. Enhancing the quality of supportive supervisory behaviour in long-term care facilities. *Journal of Nursing Administration, 35(4), 181-187.*

McGilton, K. (2003) Development and psychometric evaluation of supportive leadership scales. *Canadian Journal of Nursing Research*, 35(4), 72-86.

McGilton, K., McGillis Hall, L., Pringle, D., O'Brien-Pallas, L., & Krejci, J. (2004). *Monograph.* Toronto, ON: University of Toronto Faculty of Nursing and Toronto Rehabilitation Institute.

McKay, C. (1995). *Staff nurses' job related power and perceptions of managerial transformational leadership*. Master's thesis. London, ON: University of Western Ontario.

McKey, C. (2002). *Leadership practices, organizational commitment, conditions of work effectiveness of chief nursing officers in Ontario's restructured hospitals*. Doctoral dissertation. Capella University, Minneapolis, MN.

McNeese-Smith, D. (1995). Job satisfaction, productivity and organizational commitment: The result of leadership. *Journal of Nursing Administration*, 25(9), 17-26.

McNeese-Smith, D. (1997). The influence of manager behaviour on nurses' job satisfaction, productivity, and commitment. *Journal of Nursing Administration*. 27(9), 47-55.

Medley, F., & Larochelle, D. (1995). Transformational leadership and job satisfaction. *Nursing Management*. 26(9), 64JJ-LL, 64NN.

Michigan Hospitals. *Glossary of Terms*. Retrieved October 4, 2004 from: http://www.michiganhospitalprofiles.org/glossary_of_terms.htm

Mishra, A., & Spreitzer, G. (1998). Explaining how survivors respond to downsizing: The roles of trust, empowerment, justice and work redesign. *Academy of Management Review*, 23(3), 567-588.

Mohr, W., & Mahon, M. (1996). Dirty hands: The underside of marketplace health care. *Advances in Nursing Science*, 19(1), 28-37.

Mok, E., & Au-Yeung, B. (2002). Relationship between organizational climate and empowerment of nurses in Hong Kong. *Journal of Nursing Management*, 10(3), 129-137.

Morrison, R., Jones, L., & Fuller, B. (1997). The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. *Journal of Nursing Administration*. 27(5), 27-34.

Moynihan, R. (2004). *Evaluating health services*: *A reporter covers the science of research synthesis.* Millbank Memorial Fund. Retrieved November 22, 2004 from: http://www.milbank.org/reports/2004Moynihan/Moynihan.pdf

Mueller, C., & McCloskey, J. (1990). Nurses' job satisfaction: A proposed measure. *Nursing Research*, 39(2), 113-117.

Mullen, B., Symons, C., Hu, L., & Salas, E. (1989). Group size, leadership behaviour and subordinate satisfaction. *Journal of General Psychology*, 116, 155-169.

National Health and Medical Research Council. (1998). *A guide to the development, implementation, and evaluation of clinical practice guidelines*. National Health and Research Council [On-line]. Available: http://www.health.gov.au/nhmrc.publications/pdf/cp30.pdf

Needleman, J., & Buerhaus, P. (2003). Nurse staffing and patient safety: Current knowledge and implications for action. (editorial). *International Journal for Quality in Health Care*, 15(4), 275-77.

Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M., & Zelevinsky, K. (2002). Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. *New England Journal of Medicine,* 346(22), 1715–1722.

Nespoli, G. (1991). *Staff nurse perceptions of a positive relationship with an appointed first-lime manager who is perceived as a leader*. Doctoral dissertation. Adelphi University.

Nicklin, W. (2001). "Thank you" isn't enough. (2001). *Healthcare Management Forum*, 13(3), 6-9.

Norrish, B., & Rundall, T. (2001). Hospital restructuring and the work of Registered Nurses. *Millbank Quarterly*, 79(1), 55-79.

Nursing Task Force. (1999). *Good nursing, good health: An investment for the 21st century*. Toronto, ON: Ontario Ministry of Health and Long-Term Care.

Oberle, K., & Tenove, S. (2000). Ethical issues in public health nursing. *Nursing Ethics*, 7(5), 425-438.

O'Brien, L. (1997). *The relationship between Registered Nurses' perceptions of job-related empowerment and occupational mental health. A Test of Kanter's theory of organizational behaviour. Master's thesis*. London, ON: University of Western Ontario.

O'May, F., & Buchan, J. (1999). Shared governance: A literature review. *International Journal of Nursing Studies*, 36, 281-300.

Ontario Public Health Association. (1996). *Making a Difference! A workshop on the basics of policy change*. Toronto, Canada: Government of Ontario.

The Ottawa Hospital Management Work-Group. (2003). *The Ottawa Hospital model of nursing clinical practice: Clinical management span of control decision-making indicators.* Unpublished work. The Ottawa Hospital, Ottawa, ON.

Parsons, M., & Stonestreet, J. (2002). Factors that contribute to nurse manager retention. *Nursing Economic$*, 23(3), 120-126.

Patrick, A., & White, P. (2005). Scope of nursing leadership. *In L. McGillis Hall (Ed.), Quality work environments for nurse and patient safety.* Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Peachy, G. (2002). *The effect of leader empowering behaviours on staff nurses' workplace empowerment, psychological empowerment, organizational commitment and absenteeism*. Doctoral dissertation. McMaster University, Hamilton, Ontario.

Pearson, A., Laschinger, H., Porritt, K., Jordan, Z., Tucker, D., & Long, L. (2004). *A comprehensive systematic review of evidence on developing and sustaining nursing leadership that fosters a healthy work environment in health care. Health Care Reports*. *Adelaide, Australia: The Joanna Briggs Institute.*

Peck, M. (1988). *Head nurse fit with staff, administration, and situation: Impact on unit performance and staff satisfaction.* Doctoral dissertation. University of Utah.

Pederson, A. (1993). Qualities of the excellent head nurse. *Nursing Administration Quarterly,* 18(1), 40-50.

Perra*, B. (2000).* Leadership: The key to quality outcomes*. Nursing Administration Quarterly*, *24(2), 56-61*

Person, S., Allison, J., Kiefe, C., Weaver, M., Williams, O., Centor, R., & Weissman, N. (2004). Nurse staffing and mortality for medicare patients with acute myocardial Infarction. *Medical Care,* 42(1), 4–12.

Peters, T., & Waterman, Jr. R. (1982). *In search of excellence.* New York: Harper & Row

Pielstick, C. (1998). The transforming leader: A meta-ethnographic analysis. *Community College Review, 26*(3), 15-35.

Pincus, J. (1986). Communication: Key contributor to effectiveness – The research. *Journal of Nursing Administration*, 16(9), 19-25.

Porter, L., Steers, R., Mowday, R., & Boulian, P. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603-609.

Porter O'Grady, T. (1992). Transformational leadership in an age of chaos*. Nursing Administration Quarterly*, *17(1), 17-24*.

Posner, B. Kouzes, J., & Schmidt, W. (1985). Shared values make a difference: An empirical test of corporate culture. *Human Resources Management* 24(3), 293-309.

Price, J., & Mueller, C. (1986). *Handbook of organizational measurement*. Marshfield, MA: Pitman.

*Public Hospitals Act (1990). Regulation 965 (amended).* Retrieved May 9, 2005 from: http://192.75.156.68/DBLaws/Regs/English/900965_e.htm

Ray, M., Turkel, M., & Marino, F. (2002). The transformation process for nursing in workforce redevelopment. *Nursing Administration Quarterly,* 26(2), 1-14.

Recker, D., Bess, C., & Wellens, H. (1996). A decision-making process in shared governance. *Nursing Management*, 27(5), 48A-48D.

Redmond, G. (1995). "We don't make widgets here" voices of chief nurse executives. *Journal of Nursing Administration*, 25(2), 63-69.

Registered Nurses Association of British Columbia. (2001). *Nursing leadership and quality care. Vancouver, BC: Author*

Registered Nurses Association of Nova Scotia. (2003). *Educational support for competent nursing practice*. Retrieved September 24, 2004 from: http://www.crnns.ca/default.asp?id=190&pagesize=1&sfield=content.id&search=1102&mn=414.70.80.223.320

Registered Nurses Association of Ontario (2006). *Embracing Cultural Diversity in Health Care: Developing Cultural Competence – Draft 7*. Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario

Registered Nurses Association of Ontario and the Registered Practical Nurses Association of Ontario. (2000). *Ensuring the care will be there – Report on nursing recruitment and retention in Ontario*. Toronto, ON: Author.

Renz, D., & Eddy, W. (1996). Organizations, ethics, and health care: Building an ethics infrastructure for a new era. *Bioethics Forum*, 2,, 29-39.

Reyna, S. (1992*). Leadership styles of nurse managers and how they affect the motivation level of nursing staff*. Doctoral Dissertation, University of Texas at Austin.

Roberts, K., & O'Reilly, C. (1974). Measuring organizational communication. *Journal of Applied Psychology*, 59(3), 321-326.

Robertson, K. (1991). *Registered Nurses' perceptions of leadership systems of nurse managers and quality of work life conditions and feelings*. Doctoral dissertation. University of Alabama at Birmingham.

Robinson, C. (2001). Magnet nursing services recognition: Transforming the critical care environment. *AACN Clinical Issues*, 12(3), 1-18.

Rokeach, M. (1973). *The Nature of human values*. New York: Free Press.

Romanow, R., (2002). *Building on values: The future of health care in Canada*. Ottawa, ON: Government of Canada.

Rothmann, S., & Coetzee, S. (2003). *Dispositional characteristics, quality of work life and effectiveness of members of self-managing teams.* Poster presented at the 11th European Congress of Work and Organizational Psychology, Lisbon, Portugal, 14-17 May 2003.

Rousseau, D., & Tijorwala, S. (1999). What's a good reason to change? Motivated reasoning and social accounts in promoting organizational change. *Journal of Applied Psychology,* 84(4), 514-528.

Rutledge, D., & Donaldson, N. (1995) Building organizational capacity in research ultilization. *Journal of Nursing Administration.* 25(10), 12-6.

Rycroft-Malone, J., Kitson, A., Harvey, G., McCormack, B., Seers, K., Titchen, A., & Estabrooks, C. (2002). Ingredients for change: Revisiting a conceptual framework. *Quality and Safety in Health Care*, 11, 174-180.

Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9, 185-211.

Sasichay-Akkadechanunt, T., Scalzi, C., & Jawad, A. (2003). The relationship between nurse staffing and patient outcomes. *Journal of Nursing Administration,* 23(9), 478–85.

Schutzenhofer, K. (1988). *Measuring professional autonomy in nurses*. In: Strickland, O.L., Waltz,, C.F. (Eds.), *Measurement of nursing outcomes. Measuring nursing performance: Practice, education and research*. New York: Springer.

Schwirian, P. (1978). Evaluating the performance of nurses: A multidimensional approach. *Nursing Research*, 27(6), 347-351.

Scott, J., Sochalski, J., & Aiken, L. (1999). Review of magnet hospital research: Findings and implications for professional nursing practice. *Journal of Nursing Administration,* 29(1), 9-19.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Levels of evidence and grades of recommendation in: *A guideline developers' handbook. Retrieved May 7, 2005 from: http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/section6.html#2*

Senge, PM. (1990) *The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization*. London: Random House

Severinsson, E. (1996). Nurse supervisors' views of their supervisory styles in clinical supervision: A hermeneutical approach. *Journal of Nursing Management*, 4(4), 191-199.

Severinsson E., & Hallbeerg, I. (1996). Clinical supervisors' views of their leadership role in the clinical supervision process within nursing care. *Journal of Advanced Nursing*, 24(1), 151-161.

Shea, G. (2001*). Leading change*. In S. Rovin, (Ed.), *Medicine and business: Bridging the gap*. Gaithersburg, MD: Aspen Publications, 33-52.

Shindul-Rothschild, J. (1994). Restructuring, redesign, rationing and nurses' morale: A qualitative study of the impact of competitive financing. *Journal of Emergency Nursing,* 20(6), 497-504.

Shirey, M. (2004). Social support in the workplace: Nurse leader implications. *Nursing Economic$*, 22(6), 313-319.

Sietsema, M., & Spradley, B. (1987). Ethics and administrative decision-making. *Journal of Nursing Administration*, 17(4), 28-32.

Silva, M. (1998). Organizational and administrative ethics in health care: An ethics gap? *Online Journal of Issues in Nursing*, December 31, 1998. Retrieved on February 22, 2005 from: http://www.nursingworld.org/ojin/topic8/topic8_1.htm

Simms, L., Erbin-Roesemann, M., Darga, A., & Coeling, H. (1990). Breaking the burnout barrier: Resurrecting work excitement in nursing. *Nursing Economic$,* 8(3), 177-187.

Simpson, B., Skelton-Green, J., Scott, J., & O'Brien-Pallas, L. (2002). Building capacity in nursing: Creating a leadership institute. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 15(3), 22-27.

Six, F. (2004). *Trust and trouble: Building interpersonal trust within organizations.* Retrieved November 4, 2004 from: http://hdl.handle.net/1765/1271

Skarlicki, D., & Dirks, K. (2002). Leader as a builder of trust. *HR.com June 28, 2002*. Retrieved May 28, 2004 from http://www.olin.wustl.edu/faculty/dirks/HRcom.pdf

Skelton Green, J. (1996). The perceived impact of committee participation on the job satisfaction of staff nurses. *Canadian Journal of Nursing Administration*, 9(2), 7-35.

Skinner C,. & Spurgeon P. (2005) Valuing empathy and emotional intelligence in health leadership: a study of empathy, leadership behaviour and outcome effectiveness. *Health Services Management Research,* 18, 1-12.

Sleutel, M. (2000). Climate, culture, context, or work environment? Organizational factors that influence nursing practice. *Journal of Nursing Administration*, 30(2), 53-58.

Snow, J. (2001). Looking beyond nursing for clues to effective leadership. *Journal of Nursing Administration*, 31(9), 440-443

Snyderman, G. (1988). *Leadership styles of head nurses and the job satisfaction of Registered Nurses and aides*. Doctoral dissertation. Temple University.

Song, B., Daly, B., Trudy, E., Douglas, S., & Dyer, M. (1997). Nurses job satisfaction, absenteeism and turnover after implementing a special care unit model. *Research in Nursing and Health*, 20, 443-452.

Sovie, M., & Jawad, A. (2001). Hospital restructuring and its impact on outcomes. *Journal of Nursing Administration,* 31(12), 588–600.

Splane, R., & Splane, V. (1994). *Chief nursing officer positions in national ministries of health. Focal points for nursing leadership*. San Francisco, CA: University of California School of Nursing.

Spreitzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation. *Academy of Management Journal*, 38, 1442-65.

Squires A. (2004). A dimensional analysis of role enactment of acute care nurses. *Journal of Nursing Scholarship*, *3 (36) 272-8.*

Srivastava, R.. (2005) *Presentation: Culturally Competent Leadership Practices: The good, the bad, and the Uncertain*. Canadian Nurses Association, Nursing Leadership Conference, The Changing Face of Nursing Leadership: Diversity, Partnerships, Innovations. Ottawa, Ontario

Stamps, P., & Piedmonte, E. (1986). *Nurses and work satisfaction: An index for measurement.* Ann Arbor, MI: Health Administration Press Perspectives.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2000). *Community and public health nursing*. St. Louis: Mosby.

Stogdill, R. (1963). *Manual for the leader behavior description questionnaire – Form XII*. Columbus: Ohio State University, Bureau of Business Research.

Stone, R., Reinhard, S., Bowers, B., Zimmerman, D., Phillips, C., Hawes, et al. (2002). *Evaluation of the Wellspring model for improving nursing home quality*. The Commonwealth Fund.5

Storch, J., Rodney, P., Pauly, B., Brown, H., & Starzomski, R. (2002). Listening to nurses' moral voices: Building a quality health care environment. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 15(4), 7-16.

Stordeur, S., Vandenbergeh, C., & D'hoore, W. (2000). Leadership styles across hierarchical levels in nursing departments. *Nursing Research*. 49(1), 37-43.

Storr L., (2004). Leading with integrity: a qualitative research study. *Journal of Health Organization & Management,* 18, 415-34.

Strader, M., & Decker, P. (1995). *Role transition to patient care management.* Norwalk, CT: Appleton and Lange.

Strasen, L. (1992). *The image of professional nursing: Strategies for action*. Philadelphia, PA: Lippincott

Strebel, P. (1996). Why do employees resist change? *Harvard Business Review*, 74, 86-92.

Sullivan, J., Bretschneider, J., & McCausland, M. (2003). Designing a leadership development program for nurse managers: An evidence-driven approach. *Journal of Nursing Administration*, 33(10), 55-549.

Suominen, T., Savikko, N., Puukka, P., Doran, DI., & Leino-Kilpi, H. (2005). Work empowerment as experienced by head nurses. *Journal of Nursing Management*. 13, 147-53.

Taunton, R., Boyle, D., Woods, C., Hansen, H., & Bott, M. (1997). Manager leadership and retention of hospital staff nurses. *Western Journal of Nursing Research*. 19(2), 205-226.

Taylor, A., Sylvestre, J., & Botschner, J. (1998). Social support is something you do, not something you provide: Implications for linking formal and informal support. *Journal of Leisurability*, 25(4). Retrieved March 3, 2005 from: www.lin.ca/resource/html/Vol25/v25n4a2.htm

Titchen A. (2000). *Professional craft knowledge in patient-centred nursing and the facilitation of its development.* Doctoral dissertation. University of Oxford. Oxford: Ashdale Press.

Thomson, D. Dunleavy, J., & Bruce, S. (2002). *Nurse Job Satisfaction – Factors Relating to Nurse Satisfaction in the Workplace*. Report commissioned for the Canadian Nursing Advisory Committee, Ottawa, ON.

Thompson, J., & Bunderson, J. (2003). Violations of principle: Ideological currency in the psychological contract. *Academy of Management Review,* 28(4), 571-587.

Tomblin Murphy, G., O'Brien-Pallas, L., Alksnis, C., Birch, S., Kephart, G., Pennock, M., et al.. (2003). *Health human resources planning: An examination of relationships among nursing service utilization, an estimate of population health and overall health status outcomes in the province of Ontario*. Executive summary. Retrieved on June 1, 2005 from: www.chsrf.ca/final_research/ogc/pdf/tomblin_e.pdf

Tourangeau, A., Giovannetti, P., Tu, J., & Wood, M. (2002). Nursing-related determinants of 30-day mortality for hospitalized patients. *Canadian Journal of Nursing Research*, 33(4), 71-88.

Tourangeau, A., Lemonde, M., Luba, M., Dakers, D., & Alksnis, C. (2003). Evaluation of a leadership development intervention. *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 16(3), 91-104.

Traynor, M., & Wade, B. The development of a measure of job satisfaction for use in monitoring the morale of community nurses in four trusts. *Journal of Advanced Nursing*, 18, 127-136.

Tucker, A., & Edmondson, A. (2003). Why hospitals don't learn from failures: Organizational and psychological dynamics that inhibit system change. *California Management Review*, 45(2), 1-18.

Tucker Scott, K. (2004). *Nurses of influence: A paradigm of leadership*. Doctoral dissertation. University of Toronto.

Udod, S., & Care, W. (2004). Setting the climate for evidence-based nursing practice: What is the leader's role? *Canadian Journal of Nursing Leadership*, 17(4), 64-75.

*United States Agency for Health care Research and Quality. (2003).* The effect of health care working conditions on patient safety. Summary, evidence report /technology assessment. *Number 74. Rockville, MD*

University of Texas Repository of Nursing Administration Instruments. http://www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/

Upenieks, V. (2002). Assessing differences in job satisfaction of nurses in magnet and nonmagnetic hospitals. *Journal of Nursing Administration*, 32(11), 564-576.

Upenieks, V. (2002). *The interrelationship between and meaning of power and opportunity, nursing leadership, organizational characteristics of magnet Institutions and clinical nurse job satisfaction*. Doctoral dissertation. University of Washington.

Upenieks, V. (2003). The interrelationship of organizational characteristics of magnet hospitals, nursing leadership and nursing job satisfaction. *Health Care Manager, 22(2), 83-98.*

Upenieks, V. (2003). Nurse leaders' perceptions of what compromises successful leadership in today's acute inpatient environment. *Nursing Administration Quarterly, 27(2), 140-152.*

Upenieks, V. (2000). The relationship of nursing practice models and job satisfaction outcomes. *Journal of Nursing Administration*, 30(6), 330-335.

Upenieks, V. (2003). What constitutes effective leadership? *Journal of Nursing Administration*, 33(9), 456-467.

Upenieks, V. (2002). What constitutes successful nurse leadership? A qualitative approach utilizing Kanter's theory of organizational behaviour. *Journal of Nursing Administration*, 32(12), 622-632.

Upshur R. (1997). Certainty, probability and abduction: why we should look to C.S. Pierce rather than Godel for a theory of clinical reasoning? *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 3, 201-206.

Urwick, L. (1956). The manager's span of control. *Harvard Business Review*, 3, 39-47.

Villarruel, A.M., Peragallo N. (2004). Leadership development of Hispanic nurses. Nursing Administration Quarterly. 3(28), 173-80.

Vitello-Cicciu, J. (2003). Innovative leadership through emotional intelligence. *Nursing Management*, 34(10), 28-32.

Volk, M., & Lucas, M. (1991). Relationship of management style and anticipated turnover. *Dimensions of Critical Care Nursing*. 10(1), 35-40.

Waite, P., & Richardson, G. (2004). Determining the efficacy of resiliency training in the work site. *Journal of Allied Health*, 33(3), 178-183.

Wallach, E. (1983). Individuals and organizations: The cultural match. *Training and Development Journal*, 37, 29-36.

Walsh, C., & Clements C. (1995). Attributes of mentors as perceived by orthopaedic nurses. *Orthopaedic Nursing*, 14(3), 49-56.

Walshe, K., & Rundall, T. (2001). Evidence-based management: From theory to practice in health care. *The Millbank Quarterly*, 79(3), 429-458.

Walston, S., & Kimberly, J. 1997. Reengineering hospitals: Experience and analysis from the field. *Hospital and Health Services Administration,* 42(2), 143-63.

Ward, K. (2002). A vision for tomorrow: Transformational nursing leaders. *Nursing Outlook,* 50(3), 121-126.

Webster, G., & Baylis, F. (2000). *Moral residue*. In: Rubin, SR., Zoloth, L. (Eds.), *Margin of error: The ethics of mistakes in the practice of medicine*. Hagerstown, MD: University Publishing Group.

Weiss, D., Dawis, R., England, G., & Lofquist, L. (1997). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. Industrial Relations Center, University of Minnesota, 1967.

Wheatley, M. (2002). *Turning to one another: Simple conversations to restore hope to the future*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

White, B. (2000). *Moral leadership of nurse executives*. Doctoral dissertation. University of Northern Colorado.

Whyte, H. (1995). *Staff Nurse Empowerment and Job Satisfaction*. Master' thesis. London, ON: University of Western Ontario.

Wieck, K., Prydun, M., & Walsh, T. (2002). What the emerging workforce wants in its leaders. *Journal of Nursing Scholarship,* 34(3), 283-288.

Wilson, B., & Laschinger, H. (1994). Staff nurse perception of job empowerment and organizational commitment: A test of Kanter's theory of structural power in organizations. *Journal of Nursing Administration*, 24(4S), 39-47.

Wolf, M. (1996). Changes in leadership styles. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 27, 245-252.

Wood-Allen, D. (1998). How nurses become leaders: Perceptions and beliefs about leadership development. *Journal of Nursing Administration*, 28(9), 15-20.

Woodham-Smith, C. (1951). Florence Nightingale, 1820-1910. New York: McGraw-Hill Book Co.

Yang, K. (2003). Relationships between nurse staffing and patient outcomes. *Journal of Nursing Research,* 11(3), 149–58.

Zammuto, R., & Krakower, J. (1991). *Quantitative and qualitative studies of organizational culture, Volume 5*. Greenwich, CT: JAI Press

# Annexe A : Glossaire

**Amélioration continue de la qualité :** approche de gestion qui vise à améliorer et à maintenir la qualité en mettant l'accent sur les évaluations internes et relativement continues des causes potentielles des défectuosités, suivies de mesures afin de les corriger et d'améliorer la qualité. Règle générale, le rendement est mesuré selon les repères ou les normes de l'industrie et cette information est mise en application afin d'améliorer les opérations du programme.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
http://www.qaproject.org/methods/resglossary.html

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
http://www.doe.k12.ga.us/schools/nutrition/qmgloss.asp

**Ampleur du contrôle :** correspond au nombre de personnes qui se rapportent directement à un seul gestionnaire, superviseur ou leader et non au nombre de postes équivalents à temps plein[305].

**Caractéristiques individuelles :** traits innés des personnes qui influenceront leur auto-évaluation, celle de leur milieu et de leurs capacités, et par conséquent, leurs comportements[361].

**Climat organisationnel :** influence sociale, organisationnelle ou situationnelle sur le comportement qui reflète sur le rendement général ou les politiques et les pratiques et les buts; la façon de faire;[364] les aspects perçus comme importants par les membres individuels de l'organisation[365].

**Collaboration :** Stanhope et Lancaster (2000)[354] ont défini la collaboration comme « le fait de partager et de travailler ensemble à l'atteinte de buts communs, de façon à ce que toutes les personnes et tous les groupes soient reconnus et que la croissance soit favorisée » (p. 33).

**Compétences essentielles :** les aptitudes, connaissances, qualités et comportements essentiels nécessaires à la réussite des pratiques de leadership.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 aux adresses suivantes :
http://www.mcgill.ca/hr/mcompensation/terms/ et
http://www.astd.org/astd/Resources/performance_improvement_community/Glossary.htm

**Comportements types :** exemples de gestes précis posés par les individus afin de démontrer des compétences essentielles.

**Connaissances :** la pratique infirmière se fonde sur différents types de connaissances[362]. Les connaissances empiriques ont une base scientifique et incluent les faits, les modèles et les théories. Les connaissances esthétiques font référence à l'« art » des soins infirmiers – les connaissances proviennent des relations empathiques que les infirmières créent avec les patients. Les connaissances éthiques sont tirées des théories et des principes éthiques. Grâce à un processus de valorisation, de clarification de la situation et de promotion des droits, les infirmières adoptent une perspective éthique des soins. Les connaissances personnelles touchent la connaissance, la rencontre et l'actualisation du moi individuel et concret. On ne se connaît jamais; on ne peut que tenter d'y arriver. Ces connaissances se définissent en relation avec un autre être humain et le confrontent en tant que personne[362].

**Consensus :** opinion collective obtenue au sein d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans des conditions permettant la communication ouverte et le soutien, de façon à ce que chaque membre du groupe croie avoir une chance d'influencer la décision et puisse la soutenir auprès des autres.

**Culture organisationnelle :** les valeurs, les hypothèses et les croyances sousjacentes d'une organisation.

**Dénonciation :** processus par lequel une personne signale une faute au sein d'une organisation, à une personne ou à des entités ayant l'autorité de prendre des mesures correctives. Règle générale, la faute est une infraction à la loi, à une règle, à un règlement ou constitue une menace directe pour l'intérêt public (p. ex., la fraude, une menace pour la santé, une infraction à la sécurité et la corruption).

Traduction d'un texte extrait le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
en.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing

**Détresse éthique :** concerne des situations où les infirmières ne peuvent pas s'acquitter de leurs obligations et engagements moraux ou ne sont pas en mesure de respecter la ligne de conduite qu'elles jugent appropriée ou de se montrer à la hauteur de leurs propres exigences en matière de pratique éthique[357].

**Équité :** capacité à émettre des jugements honnêtes et non discriminatoires[359].

**Étude méthodique :** application d'une approche scientifique rigoureuse à la préparation d'un rapport de synthèse[371]. Les études méthodiques définissent les endroits où les effets sur les soins de santé sont constants, où les résultats de la recherche peuvent être appliqués dans la population, dans le milieu et les différences entre les traitements de même que les endroits où les effets peuvent varier de façon considérable. L'utilisation de méthodes systématiques et explicites dans les études limite les biais (erreurs systématiques) et réduit l'incidence des impondérables, fournissant ainsi des résultats plus fiables à partir desquels on peut tirer des conclusions et prendre des décisions[363].

**Études de corrélation :** études qui déterminent les relations entre les variables. Trois types de résultats sont possibles : aucune relation, corrélation positive et corrélation négative.

**Expertise en leadership :** connaissances, compétences et aptitudes techniques pour le leadership acquises par le biais d'une formation formelle ou d'expérience.

**Habilitation :** la capacité à mobiliser les ressources humaines et matérielles pour obtenir des résultats[164]. C'est un processus grâce auquel les intervenants influencent et partagent le contrôle des initiatives de développement de même que les décisions et les ressources qui les affectent.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante : http://www.worldbank.org/afr/particip/keycon.htm

**Hôpital qui attire et retient le personnel infirmier :** étiquette donnée au début des années 1980 aux hôpitaux des États-Unis capables de recruter et de maintenir en poste des infirmières en dépit des pénuries nationales de personnel en soins infirmiers. Aujourd'hui, le terme fait référence aux installations désignées qui ont été agréées par l'American Nurses Credentialing Center pour leur excellence dans la pratique des soins infirmiers. Ces hôpitaux sont reconnus comme des établissements où la satisfaction au travail des infirmières et les résultats des patients sont supérieurs à la moyenne en raison de caractéristiques organisationnelles spécifiques[88, 266].

**Identité ethnoculturelle :** connexion et interaction entre l'ethnicité, la culture et l'identité. Fait référence aux caractéristiques uniques qui nous distinguent en tant qu'individu et nous identifient en tant que membre d'un groupe[358].

**Identité professionnelle :** caractéristiques comportementales ou personnelles par lesquelles il est possible de reconnaître une personne en tant que membre d'un groupe[367]. La mesure selon laquelle la personne souscrit aux valeurs et aux convictions de la profession[368].

**Directrice ou Chef des soins infirmiers :** infirmière leader en soins infirmiers embauchée par l'organisation dans un poste de cadre supérieur. Elle se rapporte directement à l'administrateur et est responsable des services infirmiers offerts[269].

**Infirmières :** fait référence aux infirmières autorisées, aux infirmières auxiliaires autorisées, aux infirmières psychiatriques autorisées, aux infirmières qui jouent des rôles de pratique avancée, comme les infirmières praticiennes et les infirmières cliniciennes spécialisées, et les infirmières stagiaires.

**Intégrité :** perception que la personne en qui la confiance a été placée respecte un ensemble de principes que la personne qui fait confiance trouve acceptables[95] ou qu'elle tient parole[122].

**Interrogation appréciative (IA) :** point de vue de recherche conçue pour découvrir, comprendre et favoriser les innovations des ententes et des processus socio-organisationnels. Elle suppose la recherche de ce qu'il y a de mieux chez les gens, leurs organisations, ainsi que le monde pertinent qui les entoure. Le but visé par l'IA est de renforcer la capacité d'un système à maximiser le potentiel positif en se concentrant sur ce qui fonctionne et sur ce qu'il a de positif chez les gens et les organisations[352].

**Intervenant :** une personne, un groupe ou une organisation qui s'intéresse tout particulièrement aux décisions et aux actions des organisations, et qui peuvent tenter d'influencer ces décisions et ces actions[369]. Les intervenants comprennent toutes les personnes et tous les groupes qui seront directement ou indirectement touchés par le changement. Il existe différents types d'intervenants : opposants, partisans ou neutres[370].

**Leadership :** processus relationnel dans le cadre duquel un individu cherche à influencer les autres vers un but mutuellement souhaitable.

**Leadership infirmier :** leadership qui se fonde sur les soins infirmiers ou qui s'y trouve[38].

**Leadership transformationnel :** approche de leadership dans le cadre de laquelle les individus et leurs leaders s'engagent dans un processus d'échange qui élargit l'approche et motive les deux parties afin d'accroître les réussites, transformant de ce fait le milieu de travail[85]. Le leadership transformationnel se produit lorsqu'un leader adopte une position visionnaire et inspire les autres à le suivre.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/transformational_leadership.htm

**Les bourses de recherche en pratique/clinique avancée de l'AIIAO :** les bourses de recherche en pratique/clinique avancée de l'AIIAO constituent une expérience d'apprentissage pour les infirmières visant à accroître les compétences en soins infirmiers dans les domaines suivants : leadership, clinique et mise en œuvre des lignes directrices pour la pratique exemplaire dont l'objectif principal est d'améliorer les soins et les résultats des patients en Ontario. Grâce à l'appui de la Nurse Fellow's Sponsor Organization, l'infirmière travaille en collaboration avec un mentor ou une équipe qui possède de l'expérience dans le domaine d'intérêt particulier. Les bourses de recherche en pratique/clinique avancée sont financées par le gouvernement de l'Ontario. Pour plus de renseignements, consultez le www.rnao.org/acpf (en anglais).

**Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains :** énoncés préparés systématiquement et basés sur les meilleures données probantes disponibles en soutien à la prise de décisions au sujet des structures et des processus appropriés afin d'obtenir un milieu de travail sain[360].

**Métaanalyse :** l'usage de méthodes statistiques pour résumer les résultats de plusieurs études indépendantes. On obtient alors des estimations plus précises des effets ou des phénomènes des soins de santé que lorsque les résultats sont tirés d'études individuelles comprises dans une critique[363].

**Milieu de travail sain :** un milieu de travail sain pour les infirmières est un milieu de pratique qui maximise la santé et le bien-être des infirmières, la qualité des résultats auprès des patients et le rendement organisationnel.

**Patient-client :** fait référence à la personne qui reçoit des services infirmiers. Cela inclut les particuliers, les familles (membre de la famille, gardien, aidant naturel), les groupes, les populations ou les collectivités. Dans un contexte scolaire, le patient peut être un étudiant; dans un contexte administratif, il peut s'agir d'un membre du personnel et dans un contexte de recherche, d'un participant à l'étude[134, 366].

**Planification de la relève :** processus qui va au-delà de la planification du remplacement unique pour créer un processus d'établissement et de formation d'un bassin de candidats potentiels aux postes de leadership[196].

**Pratique réflexive :** processus continu que l'infirmière utilise afin d'examiner sa propre pratique infirmière, d'évaluer ses forces et de trouver des façons d'améliorer continuellement sa pratique afin de répondre aux besoins des patients. Parmi les questions utiles au processus, on trouve : « Qu'ai-je appris? », « Qu'est-ce qui a été le plus utile? », « De quoi ai-je également besoin? », « Quelles pratiques puis-je partager avec les autres? ».

**Pratiques en leadership :** dans le présent document, il s'agit des façons caractéristiques d'être ou un ensemble de comportements connexes qui distinguent les leaders en soins infirmiers prospères.

**Quotient émotionnel :** la capacité à percevoir avec précision, à analyser et à exprimer les émotions; la capacité à accéder aux sentiments lorsqu'ils facilitent la pensée et la capacité à comprendre les émotions et la croissance émotionnelle ou à les gérer[355]. On croit qu'il contribue au succès du lieu de travail[356].

**Recherche qualitative :** méthodes de collecte et d'analyse des données qui ne sont pas quantitatives. La recherche qualitative utilise plusieurs méthodes pour obtenir des données d'observation ou interroger des participants afin de comprendre leur point de vue, leur vision du monde et leurs expériences.

**Recommandations relatives à l'établissement :** déclaration des conditions nécessaires à un milieu de travail qui permet la mise en place réussie de la ligne directrice pour la pratique exemplaire. Ces conditions à la réussite sont en grande partie du ressort de l'établissement.

**Recommandations relatives à la formation :** énoncés sur les exigences et les démarches ou stratégies en matière d'éducation, pour l'introduction, la mise en place et le maintien durable des lignes directrices pour la pratique exemplaire.

**Recommandations relatives à la pratique :** déclarations au sujet de la pratique exemplaire concernant la pratique des professionnels de la santé qui sont idéalement basées sur des données probantes.

**Recommandations relatives au système :** déclarations sur les conditions requises pour permettre la mise en œuvre des lignes directrices pour la pratique exemplaire dans tout le système. Ces conditions de succès sont associées à la préparation de politiques sur le plan plus général du gouvernement, de la recherche et du système.

**Repère :** norme à partir de laquelle il est possible de mesurer, de comparer et de juger. L'analyse comparative suppose la mesure du produit ou du service d'une autre personne ou organisation selon des normes spécifiques et de la comparer à son propre produit ou service[353].

**Soutiens sociaux :** fait référence aux activités qui se produisent au sein du réseau social d'une personne et qui supposent l'apport d'encouragement, de sympathie, d'appréciation ou d'autres interactions avec les gens, de façon à les soutenir émotionnellement[297].

**Stratégies :** actions et activités ciblées pour obtenir des résultats.

**Systèmes d'aide à la décision :** technologies informatiques utilisées en soins de santé qui permettent aux fournisseurs de recueillir et d'analyser des données. Parmi les activités soutenues, mentionnons la clientèle, l'établissement du budget, la comptabilité analytique, les protocoles cliniques et l'analyse des voies à suivre, les résultats et l'analyse actuarielle.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
http://www.plexisweb.com/glossary/words/d.html

**Télétravail :** on parle souvent de *travail à distance*. Se produit lorsque des travailleurs payés réduisent leurs déplacements en transférant la totalité ou une partie de leur travail hors de l'endroit normal où se font les affaires.

Traduction d'une définition extraite le 6 octobre 2005 à l'adresse suivante :
http://www.ivc.ca/definition.htm

# Annexe B : Processus de préparation des lignes directrices

**En octobre 2003,** l'AIIAO a réuni un groupe d'étude composé d'infirmières possédant de l'expertise en pratique, en recherche, en politiques, en formation et en administration, représentant une vaste gamme de spécialités, de rôles et de milieux de pratique des soins infirmiers.

Le groupe a entrepris les étapes suivantes pour la préparation du présent document :

- Le champ d'activité de la ligne directrice a été établi et défini grâce à un processus de discussion et de consensus.
- Les termes de recherche pertinents au développement et au maintien du leadership infirmier dans tous les rôles ont été envoyés au Joanna Briggs Institute afin qu'ils effectuent un examen général de la documentation.
- Une recherche Internet des lignes directrices publiées en lien avec le leadership infirmier a été effectuée et a généré peu de résultats. Les documents cités ne portaient pas précisément sur le sujet ou ne contenaient pas une description suffisante des données probantes pour les soumettre à une évaluation. Il a donc été convenu de ne les utiliser qu'à titre de matériel documentaire.
- Un modèle conceptuel basé sur les données probantes a été développé afin d'organiser les concepts et leur contenu au sein des lignes directrices. Le modèle a subi un processus itératif alors que le groupe avait travaillé avec l'étude de la documentation.
- Un protocole incluant plusieurs questions ciblées a été préparé afin de guider le Joanna Briggs Institute lors de l'étude méthodique de la documentation (consultez l'annexe C au sujet du processus utilisé et des résultats).
- De la documentation supplémentaire a été citée par les membres du groupe.
- Grâce à un processus de discussion et de consensus, les recommandations relatives à la pratique, à la formation, aux organisations et aux politiques ont été rédigées.
- L'ébauche des lignes directrices a été soumise aux intervenants externes aux fins d'examen et de rétroaction. Ils représentaient une variété d'organisations et de personnes provenant de divers milieux de pratiques et de rôles qui s'intéressent au sujet et qui possèdent une expertise en leadership. Les intervenants externes ont dû commenter des questions précises et ont aussi eu l'occasion de donner de la rétroaction et des impressions générales.
- Des révisions ont été faites à l'ébauche en fonction de la rétroaction reçue des intervenants.
- Le document final a été soumis pour publication.

# Annexe C : Processus de l'examen méthodique de la documentation concernant le développement et le maintien du leadeship infirmier effectué par le Joanna Briggs Institute

1. **L'étude générale de la documentation par l'utilisation de mots-clés associés au sujet général du leadership saisis dans :**

   - CINAHL
   - Medline
   - Embase
   - PsychInfo

2. **La préparation d'un protocole pour guider une étude à répondre aux questions suivantes :**

   - Quelles caractéristiques de leadership favorisent le leadership et mènent à un milieu de travail sain en soins de santé?
   - Quels effets ou quelles influences le milieu de travail a-t-il sur le développement et le maintien du leadership infirmier afin de produire des résultats positifs dans un milieu de soins de santé? Autrement dit, quels sont les processus et les structures qui appuient et contribuent au développement et au maintien du leadership infirmier efficace? (Les structures et les processus font référence, entre autres, à la culture organisationnelle et à la valorisation des soins infirmiers, du soutien en ce qui concerne les ressources financières et humaines pour les leaders, l'ampleur du contrôle, la présence ou l'absence de leaders en soins infirmiers à l'échelon supérieur et les structures de communication et de rapport.)

3. **Parmi les termes de recherche établis, on trouve :**

   - Autonomie et leadership
   - Leadership clinique
   - Continuité et mandat du leadership
   - Quotient émotionnel
   - Habilitation
   - Milieu
   - Leadership
   - Développement du leadership
   - Leadership et milieu de pratique
   - Styles de leadership
   - Les traits de leadership
   - Gestion

- Soutien de la gestion
- Changement organisationnel
- Culture organisationnelle
- Structures organisationnelles et leadership
- Résultats auprès des patients-clients et leadership
- Satisfaction des patients-clients et leadership
- Pouvoir et leadership
- Ampleur du contrôle
- Confiance, engagement et leadership
- Satisfaction au travail et leadership
- Milieu de travail

4. **La stratégie de recherche a tenté de trouver des études publiées et non publiées, en se limitant à la langue anglaise. Une recherche limitée initiale sur CINAHL et MEDLINE a été effectuée, suivie d'une analyse des mots contenus dans le titre et le résumé et des termes d'indexation utilisés pour décrire l'article. Une recherche secondaire à l'aide de tous les mots-clés et termes d'indexation déterminés a été entreprise en utilisant les termes de recherche susmentionnés.**

   Parmi les bases de données consultées à la deuxième étape, on trouve :

   - ABI Inform Global (jusqu'en décembre 2003)
   - CINAHL (de 1982 à décembre 2003)
   - Cochrane (jusqu'en décembre 2003)
   - Current Contents Library (jusqu'en décembre 2003)
   - Econ lit (jusqu'en décembre 2003)
   - Embase (jusqu'en décembre 2003)
   - ERIC (jusqu'en décembre 2003)
   - MEDLINE (de 1966 à décembre 2003)
   - PsychINFO (jusqu'en décembre 2003)
   - Social Sciences Abstracts (jusqu'en décembre 2003)

   La recherche d'études non publiées comprenait :

   - Dissertation Abstracts International (jusqu'en décembre 2003)

5. **Les études mentionnées pendant la recherche des bases de données ont été évaluées selon leur pertinence à l'étude en se basant sur l'information contenue dans le titre et le résumé. Tous les articles semblant répondre aux critères d'inclusion ont été extraits et leur pertinence a été une fois de plus évaluée.**

6. **Les études mentionnées qui répondaient aux critères d'inclusion ont été groupées par type d'études (p. ex., expérimentale, descriptive, etc.).**

7. **Avant d'être ajoutés à l'étude, les articles ont été évalués par deux évaluateurs indépendants selon leur qualité méthodologique au moyen d'instruments d'évaluation cruciaux de la trousse SUMARI (System for the Unified Management, Assessment and Review of Information), un logiciel spécialement conçu pour gérer, évaluer, analyser et synthétiser les données.**

   **Les désaccords entre les évaluateurs ont été résolus par la discussion et, si nécessaire, par l'ajout d'un troisième évaluateur.**

## Résultats de l'étude

Au total, 48 articles de nature expérimentale, qualitative et textuelle, ont été inclus dans l'étude. La majorité des articles étaient descriptifs et examinaient les relations entre les styles de leadership, et les caractéristiques et les résultats précis, tels que la satisfaction. En raison de la nature variée des articles, il était impossible d'effectuer une métaanalyse des résultats. Huit synthèses sont dérivées des thèmes clés en lien avec la collaboration, la formation, le quotient émotionnel, le climat organisationnel[G], le développement professionnel, les qualités et les comportements positifs et la nécessité d'un milieu où le soutien est présent[52].

# Annexe D : Mesures des concepts liés au modèle conceptuel pour le dévloppement et le maintien du leadership

## Mesures du leadership infirmier

Dans une récente publication qui intégrait le travail sur la mesure du leadership, Patrick et White[50] ont choisi de n'inclure que les instruments pour la mesure des comportements de leadership utilisés dans la recherche du domaine des soins infirmiers. Cette décision a été basée sur le travail de Leatt et Porter[298] qui ont prétendu que les soins de santé avaient des qualités uniques qui généraient des milieux différents des autres industries. Ils ont aussi affirmé avoir découvert que la fiabilité et la validité de quelques instruments avaient été testées et que la plupart des instruments mettaient l'accent sur les perceptions du leadership plus que sur le rendement ou les résultats.

Huber et coll.[372] ont effectué une analyse comparative des outils d'administration des soins infirmiers qui incluaient les instruments pour la mesure du leadership. Ils ont préparé des définitions normalisées des concepts et ont établi des mesures de l'autonomie, des conflits, de la satisfaction au travail, du leadership et du climat organisationnel valides et faciles à utiliser grâce à une méthode de consensus du groupe d'experts. Tous les membres de l'équipe possédaient une expertise en recherche et en contenu.

Les outils compris dans le présent document ont été extraits de Huber[373], Patrick et White[50] et de l'University of Texas Repository of Nursing Administration Instruments[372] (www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/). Ils ont été choisis parce qu'ils ont été utilisés dans des études portant sur les soins infirmiers et que leur fiabilité et validité rapportées sont acceptables. Les outils sont présentés conformément aux composantes et aux éléments clés du *modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership*.

| CONCEPT | INSTRUMENT | AUTEUR |
|---|---|---|
| **Pratiques de leadership** | | |
| Évaluation du leadership | | |
| Évaluation du leadership | Échelle d'auto-efficacité de l'infirmière en chef | Evans[374] |
| Perception personnelle de l'efficacité | Questionnaire de description du comportement de leadership | Stogdill[375] |
| Comportements du leader | LEAD | Hersey & Blanchard[376] |
| Style de leadership | Inventaire des pratiques de leadership – soi-même, observateur | Kouzes & Posner[377] |
| Comportements et actions du leader | Questionnaire multifactoriel sur le leadership | Bass & Avolio[252] |
| Comportements ou style du leader | Questionnaire multifactoriel sur le leadership– 5X | Bass[378] |
| Comportements ou style du leader | Questionnaire sur le leadership de l'infirmière praticienne | Jones et al.[379] |
| Perception personnelle des comportements<br>Comportements de soutien aux soins de longue durée | Styles de leadership de soutien – Échelle de soutien de l'infirmière responsable et échelle de soutien du gestionnaire du service | McGilton et al.[380] |
| Rendement concernant le leadership de l'infirmière soignante | Échelle à six dimensions (6D) du rendement infirmier | Schwirian[381] |

| CONCEPT | INSTRUMENT | AUTEUR |
|---|---|---|
| **Communication** | | |
| Perceptions de la communication par les infirmières | Questionnaire d'évaluation de la communication | Farley[382] |
| Satisfaction des infirmières en ce qui concerne la communication | Questionnaire de satisfaction en ce qui concerne la communication | Pincus[383] |
| Statut perçu et idéal de la communication | Vérification de la communication ICA | Goldhaber & Rogers[384] |
| Facteurs de communication | Échelle de la communication organisationnelle | Roberts & O'Reilly[385] |
| Justice et équité distributives, mesure de la perception individuelle des récompenses | Indice de la justice distributive | Price & Mueller[386] |
| **Confiance** | | |
| Confiance envers les pairs et les gestionnaires | Confiance interpersonnelle à l'échelle du travail | Cook & Wall[387] |
| **Habilitation** | | |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'habilitation en milieu de travail | Questionnaire I sur les conditions d'un travail efficace | Chandler[388] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'habilitation en milieu de travail | Questionnaire II sur les conditions d'un travail efficace | Laschinger[174, 389] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autorité dans le milieu de travail | Échelle des activités professionnelles | Laschinger[389, 390] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne les comportements habilitants du leader | Échelle des comportements habilitants du leader | Hui[185] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autorité non formelle dans le milieu de travail | Échelle des relations organisationnelles | Laschinger[389, 390] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autorité | Échelle des activités professionnelles | Laschinger[389] |
| **Autonomie infirmière** | | |
| Travail significatif, compétence, autonomie et incidence | Échelle de l'habilitation psychologique | Spreitzer[391] |
| Attitudes et comportements des étudiants | Autonomie : instrument de perspective des soins | Boughn[392] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autonomie et l'autorité idéales et actuelles | Inventaire de l'autorité dans les rôles des soins infirmiers | Katzman[393] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autonomie | Échelle de l'autonomie clinique classée par catégorie | Kramer & Schmalenberg[394] |
| Autonomie professionnelle | Échelle Dempster des comportements de la pratique | Dempster[395] |
| Autonomie professionnelle | Échelle des activités infirmières | Schutzenhofer[396] |
| Perceptions des infirmières en ce qui concerne l'autonomie et l'autorité | Échelle de l'autorité et de l'autonomie infirmières | Blanchfield & Biordi[397] |
| Participation à la décision | Échelle de participation décisionnelle | Havens & Vasey[398] |
| Signification de l'autonomie professionnelle | Différenciateur sémantique Maas et Jacox | Maas & Jacox[399] |
| Signification de l'autonomie professionnelle | Entrevue concept Maas et Jacox | Maas & Jacox[399] |
| Autonomie en ce qui concerne les soins et les activités de l'unité | Questionnaire sur l'autonomie des infirmières soignantes | Blegen et al.[400] |
| Contrôle sur la pratique | Indice du travail infirmier -R | Aiken & Patrician[272] |
| **Optimisation des valeurs et des priorités contradictoires** | | |
| Détresse morale | Échelle de détresse morale | Corley et al.[243] |
| Prise de décision et de risque | Sondage portant sur l'éthique lors de l'administration des soins aux patients | Sietsema & Spradley[401] |

| CONCEPT | INSTRUMENT | AUTEUR |
|---|---|---|
| **Soutiens organisationnels** | | |
| Culture et climat organisationnel | | |
| Type de climat (p.ex., prise de risque, défi) | Questionnaire sur le climat créatif | Ekvall et al.[402] |
| Valeurs organisationnelles et personnelles | Questionnaire sur l'idéologie organisationnelle de Harrison | Harrison[403] |
| Climat organisationnel (p. ex., récompense, risque, soutien) | Questionnaire sur le climat organisationnel de Litwin et Stringer | Litwin & Stringer[404] |
| Climat organisationnel (p. ex., soutien, innovation) | Questionnaire modifié sur le climat organisationnel de Litwin et Stringer | Mok & Au-Yeung[405] |
| Climat organisationnel | Questionnaire sur la description du climat organisationnel des infirmières | Duxbury et al.[406] |
| Culture organisationnelle et satisfaction au travail | Sondage sur l'évaluation des soins infirmiers | Maehr & Braskamp[407] |
| Culture ou style organisationnel | Sondage sur le cadre des valeurs contradictoires | Zammuto & Krakower[408] |
| Culture professionnelle de l'unité | Outil 3 d'évaluation culturelle des soins infirmiers de l'unité | Coeling & Simms[409] |
| Bureaucratie, innovation et soutien | Inventaire des climats organisationnels | Wallach[410] |
| Styles de pensée et culture organisationnelle | Inventaire des cultures organisationnelles | Cooke & Lafferty[411] |
| Perception des infirmières en ce qui concerne les caractéristiques et le milieu de travail | Instrument concernant les caractéristiques du travail et l'excitation | Simms et al.[412] |
| Milieu de pratique professionnelle | | |
| | Indice du travail infirmier (R) | Aiken & Patrician[272] |
| | Échelle NWI du milieu de pratique | Lake[413] |
| | Échelle du milieu de pratique professionnelle | Erickson et al.[414] |
| | Indice des milieux de travail canadiens | Estabrooks et al.[415] |
| | Milieu de travail infirmier perçu | Choi et al. [416] |
| Ampleur du contrôle | | |
| | Indicateurs de l'étendue des responsabilités des gestionnaires cliniques en matière de prise de décisions | The Ottawa Hospital[417] |

| CONCEPT | INSTRUMENT | AUTEUR |
|---|---|---|
| **Ressources personnelles** | | |
| Quotient émotionnel | | |
| Instrument de rétroaction à 360 degrés | Inventaire des quotients émotionnels | Goleman[326] |
| Auto-évaluation des qualités personnelles | Inventaire des quotients émotionnels de Bar-On | Bar-On[418] |
| Test de la capacité de QE | Échelle du quotient émotionnel multifactoriel | Mayer et al.[419] |
| **Résultats** | | |
| Épuisement professionnel | | |
| | Inventaire de l'épuisement professionnel de Maslach | Maslach & Jackson[420] |
| Satisfaction au travail | | |
| | L'unité de mesure de recherche de la satisfaction au travail de Daphne Heald | Traynor & Wade[421] |
| | Indice de la satisfaction au travail | Stamps & Piedmonte[422] |
| | Échelle de satisfaction McCloskey/Mueller | Mueller & McCloskey[423] |
| | Questionnaire sur la satisfaction au Minnesota | Weiss et al.[424] |
| | Échelle de la satisfaction au travail des infirmières | Hinshaw & Atwood[425] |
| | Échelle de satisfaction au travail | Hinshaw & Atwood[425] |
| Motivation et participation au travail | | |
| | Outil de motivation - Kanungo | Kanungo[426] |
| Engagement envers l'organisation | | |
| | Questionnaire sur l'engagement envers l'organisation | Porter et al.[427] |
| Roulement | | |
| | Échelle du roulement prévu | Hinshaw & Atwood[428] |
| Satisfaction des patients | | |
| | Questionnaire sur la satisfaction des soins de santé | Eriksen[429] |

# Remarques:

# Remarques:

# Remarques:

# Remarques:

# Remarques:

FÉVRIER 2007

RNAO Registered Nurses' Association of Ontario
L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario

PROGRAMME DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SOINS INFIRMIERS

## Programme de lignes directrices pour la pratique exemplaire des soins infirmiers

# Développement et maintien du leadership infirmier

*Rendu possible grâce au financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.*

*Développé en partenariat avec Santé Canada, Bureau de la politique des soins infirmiers.*

ISBN
0-920166-75-X

Ontario